

Buku Ajar **PSIKOLOGI KEHAMILAN, PERSALINAN, NIFAS**

Ni Nyoman Ayuk Widiani • Hana Nurhanifah Budiadi
Yanti • Sesmi Nanda Oktavia



BUKU AJAR PSIKOLOGI KEHAMILAN, PERSALINAN, NIFAS

Penulis:

Bdn. Ni Nyoman Ayuk Widiani, S.ST., M.Kes.

Hana Nurhanifah Budiadi, SST., M.Tr.Keb.

bdn. Yanti, S.SiT., M.Keb.

Bd. Sesmi Nanda Oktavia, S.ST., M.Biomed.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Ajar Psikologi Kehamilan, Persalinan, Nifas

Penulis: Bdn. Ni Nyoman Ayuk Widiani, S.ST., M.Kes.
Hana Nurhanifah Budiadi, SST., M.Tr.Keb.
bdn. Yanti, S.SiT., M.Keb.
Bd. Sesmi Nanda Oktavia, S.ST., M.Biomed.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7426-26-0

Cetakan Pertama: Oktober, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, buku ajar ini hadir untuk memperkuat pemahaman tentang aspek psikologis yang menyertai kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Praktik kebidanan yang berpusat pada perempuan menuntut kompetensi tidak hanya pada ranah klinis-fisiologis, tetapi juga pada kesehatan mental ibu dan bayi serta dinamika keluarga. Karena itu, buku ini disusun sebagai panduan belajar yang ringkas, sistematis, dan aplikatif bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi layanan kesehatan ibu dan anak.

Struktur buku mengikuti alur kebutuhan belajar. Bab 1 membahas adaptasi psikologis pada masa nifas dan menyusui, dimulai dari proses adaptasi fisiologis, fase-fase, faktor yang memengaruhi, dampak terhadap kesehatan mental, ragam kelainan psikologis, hingga bentuk dukungan yang dibutuhkan ibu. Bab 2 mengalihkan fokus pada bayi: tahap adaptasi, faktor yang memengaruhi perkembangan psikologis, dan tahapan perkembangannya. Bab 3 menguraikan dampak kehamilan dan persalinan terhadap status kesehatan mental perempuan. Bab 4 dan Bab 5 memandu deteksi dini gangguan psikologi pada persalinan dan masa nifas, mencakup penyebab, masalah yang sering muncul, serta langkah-langkah identifikasi dini. Bab 6 memperkaya wawasan tentang sibling rivalry dan menegaskan tanggung jawab bidan dalam memberikan dukungan terhadap kesehatan mental perempuan. Setiap bab dilengkapi Rangkuman Materi, Latihan Soal, Glosarium, dan Referensi untuk memperkuat pemahaman; di bagian akhir disertakan pula Profil Penulis.

Kami berharap buku ajar ini menjadi bekal praktis dalam pembelajaran di kelas, praktik klinik, dan pelayanan komunitas. Kritik serta saran dari pembaca sangat kami nantikan untuk penyempurnaan edisi berikutnya. Semoga upaya kecil ini berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan dan layanan kebidanan, serta menghadirkan pengalaman kehamilan, persalinan, dan nifas yang lebih sehat, baik secara fisik maupun psikologis, bagi perempuan, bayi, dan keluarga.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 ADAPTASI PSIKOLOGIS DALAM NIFAS DAN MENYUSUI.....	1
A. Proses Adaptasi Fisologis Ibu Nifas dan Menyusui	3
B. Fase-Fase Masa Nifas dan Menyusui	4
C. Faktor Yang Mempengaruhi Psikologis Masa Nifas dan Menyusui.....	5
D. Dampak Nifas Pada Status Kesehatan Mental Perempuan	7
E. Macam-macam Kelainan Psikologis Pada Masa Nifas dan Menyusui.....	8
F. Dukungan Psikologi Pada Ibu Nifas dan Menyusui.....	13
G. Rangkuman Materi	16
H. Latihan Soal.....	16
I. Glosarium.....	17
J. Referensi.....	18
BAB 2 ADAPTASI PSIKOLOGIS PADA BAYI.....	19
A. Tahap Adaptasi Bayi.....	21
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Psikologi Bayi.....	25
C. Tahap Perkembangan Psikologis Pada Bayi.....	26
D. Rangkuman Materi	35
E. Latihan Soal.....	36
F. Glosarium.....	37
G. Referensi.....	37
BAB 3 DAMPAK KEHAMILAN DAN PERSALINAN TERHADAP STATUS KESEHATAN MENTAL PEREMPUAN	39
A. Kesehatan Mental Perempuan	41
B. Dampak Kehamilan terhadap Status Kesehatan Mental Perempuan	44
C. Dampak Persalinan terhadap Status Kesehatan Mental Perempuan.....	49
D. Latihan.....	55
E. Rangkuman Materi	56
F. Glosarium.....	57
G. Referensi.....	57

BAB 4 DETEKSI DINI GANGGUAN PSIKOLOGI PADA PERSALINAN.....	63
A. Penyebab gangguan psikologi pada ibu bersalin.....	64
B. Masalah-masalah psikologi pada ibu bersalin	65
C. Deteksi dini gangguan psikologi pada persalinan.....	67
D. Latihan.....	68
E. Rangkuman Materi	69
F. Referensi.....	69
 BAB 5 DETEKSI DINI GANGGUAN PSIKOLOGI PADA NIFAS.....	 71
A. Penyebab Gangguan Psikologi Nifas.....	72
B. Masalah-masalah Psikologi Pada Nifas.....	73
C. Deteksi Dini Gangguan Psikologi Nifas.....	75
D. Latihan.....	76
E. Rangkuman Materi	77
F. Glosarium.....	78
G. Referensi.....	78
 BAB 6 SIBLING RIVALRY DAN TANGGUNG JAWAB BIDAN MEMBERIKAN DUKUNGAN TERHADAP KESEHATAN PEREMPUAN	 79
A. Sibling Rivalry	81
B. Aspek Sibling Rivalry.....	83
C. Dampak Sibling Rivalry	84
D. Kategori Sibling Rivalry	84
E. Cara Mengatasi Sibling Rivalry.....	85
F. Tanggung Jawab Bidan Memberikan Dukungan Terhadap Kesehatan Mental Perempuan	86
G. Latihan soal	89
H. Rangkuman Materi	90
I. Glosarium.....	91
J. Referensi.....	92
 PROFIL PENULIS	 95

BAB 1

ADAPTASI PSIKOLOGIS DALAM NIFAS DAN MENYUSUI

Tujuan Intruksional:

Mahasiswa mampu memahami Proses Adaptasi Psikologis dalam nifas dan menyusui.

Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami Proses Adaptasi Fisologis Ibu Nifas dan Menyusui
2. Mahasiswa mampu memahami Proses Fase-Fase Masa Nifas dan Menyusui
3. Mahasiswa mampu memahami Proses Faktor Yang Mempegaruhi Psikologis Masa Nifas dan Menyusui
4. Mahasiswa mampu memahami Proses Dampak Nifas Pada Status Kesehatan Mental Perempuan
5. Mahasiswa mampu memahami Proses Macam-macam Kelainan Psikologis Pada Masa Nifas dan Menyusui
6. Mahasiswa mampu memahami Proses Dukungan Psikologi Pada Ibu Nifas dan Menyusui

Pendahuluan:

Proses adaptasi psikologi sudah terjadi selama kehamilan, menjelang proses kelahiran maupun setelah persalinan. Pada periode tersebut, kecemasan seorang wanita dapat bertambah. Pengalaman yang unik dialami oleh ibu setelah persalinan. Masa nifas merupakan masa yang rentan dan terbuka untuk bimbingan dan pembelajaran. Perubahan peran seorang ibu memerlukan adaptasi. Tanggungjawab ibu mulai bertambah.

Masa nifas merupakan masa yang paling kritis dalam kehidupan ibu maupun bayi, diperkirakan bahwa 60% kematian ibu akibat kehamilan terjadi setelah persalinan, dan 50% kematian masa nifas terjadi dalam 24 jam pertama. Dalam memberikan pelayanan pada masa nifas, bidan menggunakan asuhan yang berupa memantau keadaan fisik, psikologis, spiritual, kesejahteraan sosial ibu/keluarga, memberikan pendidikan dan penyuluhan secara terus menerus. Dengan pemantauan dan asuhan yang dilakukan

pada ibu dan bayi pada masa nifas diharapkan dapat mencegah atau bahkan menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

Kondisi nifas atau pascapersalinan juga dapat dikatakan sebagai fase penting. Jika banyak orang yang menganggap bahwa kehamilan dan kelahiran adalah sebuah tahapan dan kodrat perempuan, kenyataannya keduanya adalah fase dramatis dalam kehidupan perempuan. Bahkan, merupakan sebuah fenomena yang tarumatis bagi sejumlah perempuan. Setelah persalinan, ibu dapat mengalami stres, diiringi perasaan takut dan sedih. Hal ini memengaruhi emosional ibu dan sensitivitas ibu pasca melahirkan. Untuk itulah, kondisi psikologis seorang ibu pasca melahirkan juga wajib menjadi perhatian baik bagi pasangan (suami), keluarga, bidan, dan seluruh petugas kesehatan.

Pengalaman menjadi orang tua khususnya menjadi seorang ibu tidaklah selalu merupakan suatu hal yang menyenangkan bagi setiap wanita atau pasangan suami istri. Realisasi tanggung jawab sebagai seorang ibu merupakan faktor pemicu munculnya gangguan emosi, intelektual, dan tingkah laku pada seorang wanita. Beberapa penyesuaian dibutuhkan oleh wanita dalam menghadapi aktivitas dan peran barunya sebagai seorang ibu. Sebagian wanita berhasil menyesuaikan diri dengan baik, tetapi sebagian lainnya tidak berhasil menyesuaikan diri dan mengalami gangguan-gangguan psikologis dengan berbagai gejala atau sindrom yang oleh para peneliti dan klinisi disebut post-partum blues.

Perubahan psikologis mempunyai peranan yang sangat penting. Pada masa ini, ibu nifas menjadi sangat sensitif, sehingga diperlukan pengertian dari keluarga-keluarga terdekat. Peran bidan sangat penting dalam hal memberi pengarahan pada keluarga tentang kondisi ibu serta pendekatan psikologis yang dilakukan bidan pada ibu nifas agar tidak terjadi perubahan psikologis yang patologis.

Uraian Materi

A. Proses Adaptasi Fisologis Ibu Nifas dan Menyusui

Pengalaman menjadi orang tua khususnya menjadi seorang ibu tidaklah selalu merupakan suatu hal yang menyenangkan bagi setiap wanita atau pasangan suami istri. Realisasi tanggung jawab sebagai seorang ibu merupakan faktor pemicu munculnya gangguan emosi, intelektual, dan tingkah laku pada seorang wanita. Beberapa penyesuaian dibutuhkan oleh wanita dalam menghadapi aktivitas dan peran barunya sebagai seorang ibu. Sebagian wanita berhasil menyesuaikan diri dengan baik, tetapi sebagian lainnya tidak berhasil menyesuaikan diri dan mengalami gangguan-gangguan psikologis dengan berbagai gejala atau sindrom yang oleh para peneliti dan klinisi disebut post-partum blues.

Perubahan psikologis mempunyai peranan yang sangat penting. Pada masa ini, ibu nifas menjadi sangat sensitif, sehingga diperlukan pengertian dari keluarga-keluarga terdekat. Peran bidan sangat penting dalam hal memberi pengarahan pada keluarga tentang kondisi ibu serta pendekatan psikologis yang dilakukan bidan pada ibu nifas agar tidak terjadi perubahan psikologis yang patologis.

Banyak faktor yang diduga berperan pada sindrom post-partum blues, salah satu yang penting adalah kecukupan dukungan social dari lingkungannya (terutama suami). Kurangnya dukungan social dari keluarga dan teman khususnya dukungan suami selama periode pasca salin (nifas) diduga kuat merupakan faktor penting dalam terjadinya post-partum blues. Ada banyak perubahan yang telah terjadi di masa 9 bulan saat kehamilan, dan bahkan bisa lebih yang terjadi pada masa nifas, bahkan mungkin merasa sedikit ditinggalkan atau dipisahkan dari lingkungannya.

Banyak hal yang dapat menambah beban hingga membuat seorang wanita merasa down. Banyak juga wanita yang merasa tertekan setelah melahirkan, sebenarnya hal tersebut adalah wajar. Perubahan peran seorang ibu semakin besar dengan lahirnya bayi yang baru lahir. Dukungan positif dan perhatian dari seluruh anggota keluarga lainnya merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh ibu.

Hal-hal yang dapat membantu ibu dalam beradaptasi pada masa nifas adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi menjadi orangtua
- b. Respon dan dukungan dari keluarga
- c. Riwayat dan pengalaman kehamilan serta melahirkan
- d. Harapan, keinginan dan aspirasi saat hamil dan melahirkan

B. Fase-Fase Masa Nifas dan Menyusui

1. Fase taking in

Fase taking in yaitu periode ketergantungan berlangsung pada hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Ibu baru umumnya pasif dan tergantung, perhatiannya tertuju pada kekhawatiran akan tubuhnya. Pengalaman selama proses persalinan berulang kali diceritakannya. Hal ini membuat ibu cenderung menjadi pasif terhadap lingkungannya. Kemampuan mendengarkan (listening skills) dan menyediakan waktu yang cukup merupakan dukungan yang tidak ternilai bagi ibu. Kehadiran suami dan keluarga sangat diperlukan pada fase ini. Petugas kesehatan dapat menganjurkan kepada suami dan keluarga untuk memberikan dukungan moril dan menyediakan waktu untuk mendengarkan semua yang disampaikan oleh ibu agar dia dapat melewati fase ini dengan baik. Gangguan psikologis yang mungkin dirasakan ibu pada fase ini adalah sebagai berikut:

- a. Kekecewaan karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan tentang bayinya misalkan: jenis kelamin tertentu, warna kulit, dan sebagainya
- b. Ketidaknyamanan sebagai akibat dari perubahan perubahan fisik yang dialami ibu misalnya rasa mules akibat dari kontraksi rahim, payudara bengkak, akibat luka jahitan, dan sebagainya. Rasa bersalah karena belum bisa menyusui bayinya
- c. Suami atau keluarga yang mengkritik ibu tentang cara merawat bayinya dan cenderung melihat saja tanpa membantu. Ibu akan merasa tidak nyaman karena sebenarnya hal tersebut bukan hanya tanggung jawab ibu saja, tetapi tanggung jawab bersama.

Pada saat ini tidur tanpa gangguan sangat penting untuk mengurangi gangguan fisik dan psikologis yang dapat diakibatkan karena kurang istirahat, selain itu peningkatan nutrisi dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan dan penyembuhan luka, serta persiapan proses laktasi aktif.

Dalam memberikan asuhan, bidan harus dapat memfasilitasi kebutuhan psikologis ibu. Pada tahap ini bidan dapat menjadi pendengar yang baik ketika ibu menceritakan pengalamannya. Berikan juga dukungan mental atau apresiasi atas hasil perjuangan ibu dalam melahirkan bayinya. Bidan diharapkan dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi ibu sehingga ibu dapat dengan leluasa menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi kepada bidan. Dalam hal ini sering kali terjadi kesalahan dalam perawatan yang dilakukan kepada pasien dan bayinya akibat kurangnya jalinan komunikasi yang baik antara pasien dengan bidan.

2. Fase taking hold

Fase taking hold adalah fase/periode yang berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. Pada fase ini, ibu merasa khawatir akan ketidakmampuannya dan rasa tanggung jawabnya dalam merawat bayi. Ibu memiliki perasaan yang sangat sensitive sehingga mudah tersinggung dan gampang marah sehingga kita perlu berhati-hati dalam berkomunikasi dengan ibu.

Pada fase ini ibu memerlukan dukungan karena saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk menerima berbagai masukan dalam merawat diri dan bayinya sehingga timbul percaya diri. Tugas sebagai tenaga kesehatan yakni mengajarkan cara merawat bayi, cara menyusui yang benar, cara merawat luka jahitan, mengajarkan senam nifas, memberikan Pendidikan kesehatan yang diperlukan ibu seperti gizi, istirahat, kebersihan diri, dan lain-lain.

3. Fase letting go

Fase letting go merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran barunya yang berlangsung sepuluh hari setelah melahirkan. Ibu sudah dapat menyesuaikan diri, merawat diri dan bayinya, serta kepercayaan dirinya sudah meningkat. Pendidikan kesehatan yang kita berikan pada fase sebelumnya akan sangat berguna bagi ibu agar lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan diri dan bayinya.

Dukungan dari suami dan keluarga masih sangat diperlukan ibu. Suami dan keluarga dapat membantu merawat bayi, mengerjakan urusan rumah tangga sehingga ibu tidak terlalu lelah dan terbebani. Ibu memerlukan istirahat yang cukup sehingga mendapatkan kondisi fisik yang bagus untuk dapat merawat bayinya.

Pada periode ini ibu mengambil tanggung jawab terhadap perawatan bayi dan harus beradaptasi dengan segala kebutuhan bayi sangat bergantung pada ibu, hal ini menyebabkan berkurangnya hak ibu, kebebasan serta hubungan sosial. Jika hal ini tidak dapat dilalui dengan baik maka dapat menyebabkan terjadinya post partum blues dan depresi post partum.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Psikologis Masa Nifas dan Menyusui

1. Lingkungan

Faktor yang paling memengaruhi status Kesehatan masyarakat terutama ibu hamil, bersalin dan nifas adalah faktor lingkungan yaitu pendidikan di samping faktor-faktor lainnya. Jika masyarakat mengetahui dan memahami hal-hal yang memengaruhi status kesehatan tersebut maka diharapkan masyarakat tidak

melakukan kebiasaan/adat-istiadat yang merugikan kesehatan khususnya bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas.

2. Sosial

Secara sosial terjadi perubahan-perubahan pada wanita yang sudah melahirkan, perlu menyesuaikan diri terhadap dasar sebagai ibu, atau penambahan anak. Terdapat konflik rasa kewanitaan dan rasa keibuan pada masa nifas. Sebagian wanita berhasil menyesuaikan diri dengan baik pada masa nifas, tetapi sebagian lainnya tidak berhasil menyesuaikan diri dengan keadaan sosialnya sehingga mengalami gangguan psikologis dengan berbagai gejala atau sindroma.

Berarti secara langsung bahwa perubahan sosial menentukan psikologis ibu nifas. Perubahan sosial yang akan dialami oleh ibu setelah melahirkan di antaranya:

a. Menjadi Orang Tua yang Sempurna

Maksudnya di sini adalah bagi pasangan yang baru pertama kali memiliki anak terdapat perubahan sosial besar dimana sebelumnya hanya ada 2 orang (suami istri) tiba-tiba berubah menjadi orangtua yang sempurna ketika buah hati lahir. Pada masa ini, suami istri dituntut untuk menjadi orangtua yang siap siaga 24 jam dalam kehidupannya, dimulai dengan mengatur jadwal bersama demi si buah hati

untuk memenuhi kebutuhannya. Mulai dari memberikan ASI, bangun di tengah malam, memasang popok, memandikan, dan lain-lain. Semua itu harus dipersiapkan dengan baik-baik agar perubahan sosial menjadi orang tua dapat dicapai dengan maksimal. Dan bagi orang tua yang sebelumnya telah memiliki anak, pekerjaan tambahannya adalah memberikan pengertian dan keadilan kasih sayang terhadap anak sebelumnya dan yang baru saja dilahirkan. Di sini orang tua dituntut memberikan pemahaman yang baik pada anak sebelumnya tentang kehadiran anggota keluarga baru agar tidak terjadi kesenjangan kasih sayang yang diberikan.

b. Penerimaan Anggota Baru oleh Keluarga Besar

Dengan kehadirannya seorang anggota baru dalam sebuah keluarga, secara tidak langsung mengubah suasana seluruh anggota besar. Di sini dimaksudkan dengan adanya kelahiran bayi diharapkan anggota keluarga besar (seperti kakek, nenek, mertua, dan lain-lain) bisa digerakkan dalam membantu serta untuk merawat si bayi. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana kekeluargaan yang erat antara kehadiran si buah hati dengan keluarga besarnya.

3. Budaya

Budaya atau kebiasaan merupakan salah satu yang memengaruhi status kesehatan. Di antara kebudayaan maupun adat-istiadat dalam masyarakat ada yang menguntungkan, ada pula yang merugikan. Banyak sekali pengaruh atau yang menyebabkan berbagai aspek kesehatan di negara kita, bukan hanya karena pelayanan medik yang tidak memadai atau kurangnya perhatian dari instansi kesehatan, antara lain masih adanya pengaruh sosial budaya yang turun temurun masih dianut sampai saat ini. Selain itu ditemukan pula sejumlah pengetahuan dan perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan.

Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan pulih kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama 6-8 minggu. Periode nifas merupakan masa kritis bagi ibu, diperkirakan bahwa 60% kematian ibu akibat kehamilan terjadi setelah persalinan, yang mana 50% dari kematian ibu tersebut terjadi dalam 24 jam pertama setelah persalinan. Selain itu, masa nifas ini juga merupakan masa kritis bagi bayi, sebab dua per tiga kematian bayi terjadi dalam 4 minggu setelah persalinan dan 60% kematian bayi baru lahir terjadi dalam waktu 7 hari setelah lahir. Untuk itu perawatan selama masa nifas merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

4. Ekonomi

Status ekonomi merupakan simbol status sosial di masyarakat. Pendapatan yang tinggi menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan nutrisi yang memenuhi zat gizi untuk ibu hamil. Sedangkan kondisi ekonomi keluarga yang rendah mendorong ibu nifas untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kesehatan.

D. Dampak Nifas Pada Status Kesehatan Mental Perempuan

Bagi kebanyakan wanita, kehamilan dan kelahiran adalah waktu untuk perayaan. Namun, ini juga dapat menjadi waktu perubahan dalam tubuh wanita dan gaya hidup, yang dapat meningkatkan risiko kesehatan mental yang buruk. Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan kesehatan mental sebagai "negara kesejahteraan di mana individu menyadari dirinya atau kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan yang normal dalam kehidupan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat".

Kehamilan dan persalinan dapat membawa sukacita dan kepuasan bagi kehidupan seorang wanita, tetapi dapat juga membawa kecemasan, depresi, dan stres. Jika tidak diobati, depresi dan gangguan suasana hati lainnya dapat bertambah parah dan bahkan fatal bagi ibu dan anaknya. American Psychological

Association memperkirakan bahwa 1 dari 7 wanita yang mengalami depresi postpartum, namun sebenarnya statistik adalah tidak diketahui, karena kebanyakan wanita tidak mengenali gejala-gejala yang terkait dengan kondisi tersebut. Gangguan mood pada perinatal termasuk depresi postpartum—dapat mempengaruhi setiap wanita, namun wanita warna sering menghadapi keadaan hidup yang meningkatkan kemungkinan mereka mengalami gangguan mood perinatal. Gangguan Mood yang terjadi selama kehamilan dan pada tahun pertama setelah kelahiran dapat mengambil banyak bentuk, beberapa di antaranya termasuk depresi antenatal, postnatal depresi, gangguan kecemasan, perinatal gangguan obsesif kompulsif, depresi postpartum, postpartumpsikosis, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD).

Menurut ernal Mental Health Leadership AllianceGangguan mood yang dialami oleh ibu post partum dan menyusui adalah :

- a. Depresi Postnatal: Depresi yang dapat terjadi pada seorang wanita setelah melahirkan
- b. Gangguan kecemasan: intens bentuk kecemasan yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari seorang ibu hamil atau wanita postpartum
- c. Gangguan obsesif kompulsif Perinatal: Obsesi, dorongan, dan kecemasan yang dapat dialami oleh seorang wanita selama kehamilan atau setelah melahirkan.
- d. Depresi Postpartum: Sedang depresi berat yang dapat terjadi pada seorang wanita segera setelah melahirkan atau sampai satu tahun setelah melahirkan
- e. Postpartum psikosis: langka kejiwaan darurat yang dapat terjadi pada seorang wanita dalam beberapa minggu pertama setelah melahirkan; gejala dapat mencakup mania, depresi, kebingungan yang parah, paranoia dan halusinasi
- f. Post-traumatic stress disorder: gangguan mood yang disebabkan oleh nyata atau dirasakan trauma yang dialami oleh seorang wanita selama melahirkan atau pada periode postpartum

Tanda-tanda dan gejala dari depresi setelah melahirkan berbeda-beda, dan hal tersebut dapat berkisar dari ringan sampai parah

E. Macam-macam Kelainan Psikologis Pada Masa Nifas dan Menyusui

1. Post Partum Blues

Post partum blues sering juga disebut baby syndrome. Menurut ambarwati post partum blues adalah perasaan sedih yang dialami oleh ibu setelah melahirkan, hal ini berkaitan dengan bayinya. Dan hal ini dapat terjadi 3 – 6 hari setelah 14 hari pasca melahirkan, ibu mengalami perubahan perasaan , sering menangis, cemas, kesepian, khawatir mengenai bayinya, tidak mampu

beradaptasi, sensitive, nafsu makan menurun, sulit tidur hingga gairah seks menurun. Gejala baby blues antara lain, ibu mengalami perubahan mood, sering menangis, cemas, kesepian, khawatir mengenai bayinya, sensitive, tidak nafsu makan, sulit tidur.

a. Menurut Yanti & Sundawati (2011) hal-hal yang disarankan pada ibu adalah sebagai berikut:

- 1) Minta bantuan suami atau keluarga jika ibu ingin istirahat
- 2) Beritahu suami tentang apa yang disarankan oleh ibu
- 3) Buang rasa cemas dan khawatir akan kemampuan merawat bayi
- 4) Meluangkan waktu dan cari hiburan untuk diri sendiri
- 5) Faktor Penyebab Postpartum Blues

b. Komplikasi Postpartum Blues

- 1) Depresi Postpartum. Gejala yang timbul adalah perasaan sedih, tertekan, sensitive, merasa bersalah, lelah, cemas, dan tidak mampu merawat dirinya dan bayinya. Keadaan ini memerlukan psikoterapi dan obat-obatan disamping dukungan social.
- 2) Postpartum Psikosis. Depresi berat yaitu dengan gejala proses piker yang dapat mengancam dan membahayakan keselamatan jiwa ibu dan bayinya sehingga memerlukan pertolongan dari tenaga professional yaitu psikeater dan pemberian obat.

c. Pencegahan Postpartum Blues

- 1) Persiapan diri yang baik selama kehamilan untuk menghadapi masa nifas
- 2) Komunikasikan segala permasalahan atau hal yang ingin disampaikan
- 3) Selalu membicarakan rasa cemas yang dialami
- 4) Bersikap tulus serta ikhlas terhadap apa yang telah dialami dan berusaha melakukan peran barunya sebagai seorang ibu yang baik
- 5) Cukup istirahat
- 6) Menghindari perubahan hidup yang drastic
- 7) Berolahraga ringan
- 8) Berikan dukungan dari keluarga, suami, atau saudara
- 9) Konsultasikan kepada tenaga kesehatan atau orang yang professional agar dapat memfasilitasi faktor risiko lainnya selama masa nifas dan membantu dalam melakukan upaya pengawasan

d. Penatalaksanaan Postpartum Blues

Penanganan gangguan mental pasca-salin pada prinsipnya tidak berbeda dengan penanganan gangguan mental pada momen-momen lainnya. Para ibu yang mengalami postpartum blues membutuhkan pertolongan yang sesungguhnya. Para ibu ini membutuhkan dukungan psikologis seperti juga

kebutuhan fisik lainnya yang harus juga dipenuhi. Mereka membutuhkan kesempatan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka dari situasi yang menakutkan.

Mungkin juga mereka membutuhkan pengobatan atau istirahat, dan seringkali akan merasa gembira mendapat pertolongan yang praktis. Dengan bantuan dari teman dan keluarga, mereka mungkin perlu untuk mengatur atau menata kembali kegiatan rutin sehari-hari, atau mungkin menghilangkan beberapa kegiatan, disesuaikan dengan konsep mereka tentang keibuan dan perawatan bayi. Bila memang diperlukan, dapat diberikan pertolongan dari para ahli, misalnya dari seorang psikolog atau konselor yang berpengalaman dalam bidang tersebut

2. Depresi Post Partum

Banyak ibu mengalami perasaan let down setelah melahirkan sehubungan dengan seriusnya pengalaman waktu melahirkan dan keraguan akan kemampuan mengatasi secara efektif dalam membesarkan anak.

Postpartum Depression adalah kondisi Dimana seorang ibu yang baru saja melahirkan mengalami perubahan mood yang parah dan persisten selama beberapa bulan atau bahkan setahun atau lebih. postpartum depression merupakan gangguan mood setelah melahirkan yang merefleksikan disregulasi psikologikal yang merupakan tanda dari gejala gejala depresi mayor.

Menurut Kaplan ibu setelah melahirkan sering mengalami kesedihan, Dimana kesedihan itu bersifat normal sering menangis, distoria, dan ketergantungan namun ibu yang mengalami postpartum depression sering ditandai dengan perasaan depresi dan keinginan untuk bunuh diri, untuk kasus postpartum depression sering ditandai dengan perasaan depresi dan keinginan untuk bunuh diri. Untuk kasus postpartum depression tingkat berat dapat menjadikan ibu psikotik dengan halusinasi, waham dan pikiran untuk membunuh bayinya.

Berdasarkan pemaparan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa

postpartum depression adalah sebuah kondisi Dimana ibu yang baru saja melahirkan mengalami perubahan mood yang merefleksikan disregulasi psikologikal yang merupakan tanda dari gejala gejala depresi mayor yang berlangsung selama tujuh hari sampai satu tahun setelah kelahiran bayi.

a. Gejala Depresi Post Partum

- 1) Mood depresi atau perubahan suasana hati yang parah
- 2) Menangis berlebihan
- 3) Kesulitan membentuk ikatan dengan bayi
- 4) Menarik diri dari keluarga dan teman-teman

- 5) Kehilangan nafsu makan atau makan lebih banyak dari biasanya
- 6) Ketidakmampuan untuk tidur (insomnia) atau tidur terlalu banyak
- 7) Luar biasa kelelahan atau kehilangan energi
- 8) Berkurangnya minat dan kesenangan dalam aktivitas yang biasa dinikmati
- 9) Intens mudah tersinggung dan marah
- 10) Takut bahwa kau bukan ibu yang baik
- 11) Keputusasaan
- 12) Perasaan tidak berharga, malu, bersalah atau tidak mampu
- 13) Berkurang kemampuan untuk berpikir dengan jelas, berkonsentrasi atau membuat keputusan

b. Faktor Penyebab Depresi Post Partum

- 1) Faktor biologis berupa perubahan kadar hormonal seperti estrogen, progesterone, prolactin, dan ekstriol yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam masa melahirkan atau mungkin perubahan hormon tersebut terlalu cepat atau terlalu lambat
- 2) Faktor demografi yaitu unsur Perempuan yang bersangkutan saat kehamilan dan sering kali dikaitkan dengan kesiapan mental Perempuan tersebut untuk menjadi seorang ibu, umur yang tepat bagi seorang Perempuan untuk melahirkan pada usia antara 20-30 tahun
- 3) Faktor pengalaman depresi postpartum lebih banyak ditemukan pada Perempuan yang baru pertama kali melahirkan (primipara) bahwa peran seorang ibu dan segala yang berkaitan dengan bayinya merupakan situasi yang sama sekali baru bagi dirinya dan dapat menimbulkan stress;
- 4) faktor Pendidikan, Perempuan yang berpendidikan tinggi menghadapi tekanan social dan konflik peran, antara tuntutan sebagai Perempuan yang memiliki dorongan untuk bekerja atau melakukan aktivitasnya diluar rumah dengan peran sebagai ibu rumah tangga dan orang tua dari anak anaknya.
- 5) Faktor selama persalinan hal ini mencakup lamanya persalinan serta intervensi medis yang digunakan selama proses persalinan.
- 6) Diduga semakin besar trauma fisik yang ditimbulkan pada saat persalinan, maka akan semakin besar pula trauma psikis yang muncul dan kemungkinan Perempuan yang bersangkutan akan menghadapi depresi persalinan.
- 7) Faktor dukungan sosial dari suami dan keluarga yang membantu pada saat kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, beban seorang ibu sedikit banyak.

3. Psikosis

Postpartum psikosis adalah masalah kejiwaan serius yang dialami ibu setelah proses persalinan dan ditandai dengan agitasi yang hebat, pergantian perasaan yang cepat, depresi dan delusi. Wanita yang mengalami postpartum psikosis ini membutuhkan perawatan segera dan pengobatan psikiater. Hal ini dikarenakan wanita tersebut mengalami gangguan bipolar namun bisa merupakan hal lanjutan yang di alami dari gangguan depresi mayor.

1) Penyebab Post Partum Psikosis

- a. Perubahan hormon,
- b. Rendahnya dukungan sosial
- c. Emosional,
- d. Rasa rendah diri.

2) Gejala Post Partum Psikosis

- a. Adanya halusinasi
- b. Melihat hal-hal yang tidak nyata
- c. Perubahan mood dan tenaga yang ekstrim
- d. Ketidak mampuan merawat bayi
- e. Terjadi periode kebingungan hingga amnesia
- f. Hiperaktivitas,
- g. insomnia,
- h. kesulitan mengingat
- i. Serangan gelisah yang tak terkendali
- j. Mengalami gangguan komunikasi.

3) Dampak depresi Dan Post Partum Psikosis

- a. Dampak biaya. Kinerja menurun, istirahat, cuti, tidak produktif, biaya pengobatan, bahkan hilangnya potensi penghasilan karena penderita merasa ingin bunuh diri.
- b. Dampak emosi, Hidup dipenuhi dengan perasaan yang tidak nyaman, tidak berdaya, penyesalan mendalam, sedih, putus asa, cemas, dampak fisik, tubuhsakit, psikosomatis, jika ada sakit lebih cenderung mengalami komplikasi, kecepatan pemulihan kondisi kesehatan lebih lama dan lambat.
- c. Dampak sosial, Sering timbul konflik dalam keluarga, ketidak mampuan menjalankan fungsi dan peran sebagai orang tua yang baik, perceraian, putusnya persahabatan, perilaku yang merugikan diri sendiri, dan atau orang lain. Seperti mabuk, penggunaan obat-obatan terlarang.

4) Penatalaksanaan Tindakan Post Partum Psikosis

- a. Penatalaksanaan tindakan yang dapat diberikan dengan rawat inap (hospitalisasi), pemberian obat anti psikotik atau anti depresan atau anti ansietas, sedatif, terapi anti kejang, perawatan bayinya, dukungan sosial dan psikoterapi/pendampingan psikiater. Hal tersebut dikarenakan wanita yang mengalami gangguan kejiwaan ini tidak mampu atau tidak bersedia berbicara dengan orang di sekitarnya.
- b. Psikosis postpartum merupakan suatu kondisi emergensi dan memerlukan perhatian dan penanganan segera. pasien mungkin akan membutuhkan terapi obat untuk jangka waktu tertentu, seperti haloperidol atau flufenazin, keduanya diberikan dalam dosis 2- 5 mg per os 3 kali perhari. Bila agitasi maka pasien membutuhkan anti psikotika berpotensi tinggi dan diberikan IM. Mood stabilizer seperti lithium, valproid acid, carbamazepine digunakan sebagai terapi akut yang dikombinasi dengan obat anti psikotik dan benzodiazepine. indikasi pemakaian ECT sama seperti psikosis tanpa persalinan tetapi dianjurkan ditunda sampai satu bulan post partum untuk menghindari terjadinya emboli.

F. Dukungan Psikologi Pada Ibu Nifas dan Menyusui

Wanita yang telah mengalami proses persalinan, pada periode ini membutuhkan bantuan. Dukungan sosial penting untuk kesehatan ibu baik fisik maupun psikologis setelah ibu melahirkan terutama saat ibu memiliki peran baru sebagai ibu.

Pierce dalam Kail dan Cavanaugh, mendefinisikan dukungan social sebagai sumber emosional, informasional atau pendampingan dari orang-orang sekitar individu yang sedang menghadapi masalah dan kondisi krisis. Definisi ini hampir sama dengan yang disampaikan oleh Saroson bahwa dukungan sosial adalah interaksi interpersonal yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada seseorang hingga yang bersangkutan merasa adanya bentuk perhatian, bernilai, dan dicintai.

Berdasarkan pendapat dua ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial adalah dukungan atau bantuan yang diberikan oleh orang terdekat terhadap seseorang yang sedang menghadapi permasalahan sehingga merasakan adanya bentuk perhatian, dihargaidan menjadi bagian dari kelompok. Dukungan sosial ini memiliki klasifikasi di dalamnya, seperti disampaikan oleh Cohen dan Syme (1985) yaitu:

1. Dukungan informasi, yaitu memberikan penjelasan tentang situasi dari segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi individu. Dukungan ini meliputi memberikan nasehat, petunjuk, masukan atau penjelasan bagaimana seseorang bersikap
2. Dukungan emosional, yang meliputi ekspresi empati misalnya mendengarkan, bersikap terbuka, menunjukkan sikap percaya terhadap apa yang dikeluhkan, mau memahami, ekspresi kasih sayang dan perhatian. Dukungan emosional akan membuat penerimanya merasa berharga, nyaman, aman, terjamin, dan disayangi.
3. Dukungan instrumental adalah bantuan yang diberikan secara langsung, bersifat fasilitas atau materi misalnya menyediakan fasilitas yang diperlukan, meminjamkan uang, memberikan makanan, permainan atau bantuan yang lain.
4. Dukungan appraisal atau penilaian, dukungan ini bisa berbentuk penilaian yang positif, penguatan (pembenaran) untuk melakukan sesuatu, umpan balik atau menunjukkan perbandingan sosial yang membuka wawasan seseorang yang sedang dalam keadaan stres.

Dukungan sosial yang dibutuhkan ibu pasca melahirkan tidak hanya suami, tapi dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Karena kenyataannya oranglain yang berada di sekitar ibu ini yang juga menjadi peran sebagai stressor. Misalnya saja pemberian nasehat yang cenderung melarang ibu untuk tidak melakukan ini dan itu menjadi sumber stressor tersendiri. Padahal ibu belum tentu minim pengetahuan terkait perawatan setelah melahirkan maupun perawatan bayi sehingga daripada memberikan nasehat atau informasi yang banyak lebih baik langsung memberikan dukungan dalam bentuk bantuan langsung.

Katz and Kahn, menjelaskan bahwa perhatian dari lingkungan terdekat seperti suami dan keluarga dapat berpengaruh terhadap terjadinya sindrom baby blues. Dukungan berupa perhatian, komunikasi dan hubungan emosional yang hangat sangat penting. Dorongan moral dari teman-teman yang sudah pernah bersalin juga dapat membantu. Suami berperan dalam memberikan support atau dukungan terhadap masalah yang dihadapi oleh istrinya dalam melewati masa-masa adaptasi psikologis postpartum, dimana dukungan yang dibutuhkan tidak hanya fisik tapi juga moral.

Suami dalam membuat keputusan ditentukan oleh kemampuan keluarga, tentunya hal ini akan berpengaruh pada dukungan yang diberikan. Hubungan perkawinan merupakan hubungan akrab yang diikuti oleh minat yang sama, kepentingan yang sama, saling membagi perasaan, saling mendukung dan menyelesaikan permasalahan bersama.

Dukungan suami merupakan strategi coping penting pada saat mengalami stress dan berfungsi sebagai strategi prefentif untuk mengurangi stress dan

konsekuensi negatifnya. Dukungan keluarga sangat dibutuhkan oleh perempuan selama mengalami persalinan. Peran suami dalam meminimalkan postpartum blues yaitu memahami kebutuhan istri, suami bisa meluangkan waktunya untuk menemani istri dalam perawatan bayi, kesediaan suami mengambil alih sebagian tugastugas rumah tangga yang selama ini dilakukan istri, kewajiban suami membagi perhatian secara adil kepada bayi dan ibunya. Meskipun kehadiran bayi sangat menyenangkan dan membahagiakan, perlu diingat bahwa ibu yang melahirkannya, dan perlunya sentuhan fisik sangat dirasakan pada masa-masa pasca melahirkan.

Dukungan keluarga merupakan salah satu bentuk interaksi social didalamnya terhadap hubungan yang saling memberi dan menerima bantuan yang bersifat nyata, bantuan tersebut akan menempatkan individu-individu yang terlibat dalam sistem sosial yang pada akhirnya akan memberikan cinta, perhatian maupun sense of attachment baik pada keluarga sosial maupun pasangan.

Dukungan keluarga sangat penting dan tidak bisa diremehkan dan yang tidak kalah penting membangun suasana positif, dimana istri merasakan hari-hari pertama yang melelahkan. Oleh sebab itu, dukungan atau sikap positif dari pasangan/keluarga akan memberi kekuatan tersendiri bagi ibu postpartum. Keluarga memegang peranan penting dalam terjadinya postpartum blues dan harapan keluarga menyadari bahwa ibu sangat membutuhkannya pada saat tertentu dan suami diharapkan ada saat istri membutuhkannya.

Diperkirakan bahwa wanita dengan riwayat depresi pascapartum memiliki risiko untuk terulang kembali sebesar 50% hingga 62% pada kehamilan yang berikutnya. Beck, dalam 44 penelitian Meta analisisnya menentukan besarnya jarak hubungan antara depresi pasca partum dengan variabel-variabel yang mendukung mengidentifikasi pengaruh ringan dari riwayat depresi sebelumnya, kondisi ekonomi lemah meningkatnya stress dalam kehidupan stres dalam merawat anak, adanya blues post partum, dan menurunnya kebahagiaan dalam perkawinan. Suatu pengaruh yang besar ditemukan sebagai faktor pendukung pada depresi prenatal titik secara umum sebagian besar wanita mengalami gangguan emosional setelah melahirkan (Regina dkk, 2001) bentuk gangguan postpartum yang umum adalah depresi, mudah marah dan terutama mudah frustrasi serta emosional.

Penelitian mengenai keefektifan penambahan estrogen selama periode pasca partum terbatas oleh sejumlah variabel bebas. Penurunan progesteron setelah persalinan juga merupakan implikasi perkembangan gejala depresi, namun penelitian gagal menemukan hubungan antara depresi dengan kadar progesteron total atau progesteron bebas. Tidak ada penelitian yang mengeksplorasi pengaruh penambahan progesterone sebagai penatalaksanaan untuk mencegah gejala depresi titik penelitian telah gagal menemukan hubungan antara oksitosin,

vasopresin, prolactin dan kadar kortisol, dengan perkembangan depresi. Wanita yang memiliki antibodi tiroid dapat beresiko mengalami depresi pasca partum.

G. Rangkuman Materi

Perubahan psikologis mempunyai peranan yang sangat penting. Pada masa ini, ibu nifas menjadi sangat sensitif, sehingga diperlukan pengertian dari keluarga-keluarga terdekat. Peran bidan sangat penting dalam hal memberi pengarahan pada suami dan keluarga tentang kondisi ibu serta pendekatan psikologis yang dilakukan oleh suami, bidan dan keluarga pada ibu nifas agar tidak terjadi perubahan psikologis yang patologis.

H. Latihan Soal

1. Dibawah ini yang bukan merupakan hal-hal yang dapat membantu ibu dalam beradaptasi pada masa nifas adalah?
 - a. Fungsi menjadi orangtua
 - b. Respon dan dukungan dari masyarakat
 - c. Riwayat dan pengalaman kehamilan serta melahirkan
 - d. Harapan, keinginan dan aspirasi saat hamil dan melahirkan
2. Fase/periode yang berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. Pada fase ini, ibu merasa khawatir akan ketidakmampuannya dan rasa tanggung jawabnya dalam merawat bayi, merupakan pengertian dari fase masa nifas ?
 - a. Taking in
 - b. Taking Hold
 - c. Letting Go
 - d. Post Partum Blues
3. Faktor Yang Mempegaruhi Psikologis Masa Nifas dan Menyusui adalah, Kecuali
 - a. Suami
 - b. Lingkungan
 - c. Sosial
 - d. Ekonomi
4. kondisi Dimana seorang ibu yang baru saja melahirkan mengalami perubahan mood yang parah dan persisten selama beberapa bulan atau bahkan setahun atau lebih merupakan pengertian dari
 - a. Baby Blues

- b. Psikosis
 - c. Trauma psot partum
 - d. Depresi psot partum
5. Adanya halusinasi, Melihat hal-hal yang tidak nyata, Perubahan mood dan tenaga yang ekstrim, Ketidak mampuan merawat bayi dan Terjadi periode kebingungan hingga amnesia merupakan tanda dan gejala dari
- a. Baby Blues
 - b. Psikosis
 - c. Trauma psot partum
 - d. Depresi psot partum

Kunci Jawaban

- 1. B
- 2. B
- 3. A
- 4. D
- 5. D

I. Glosarium

Antenatal: kondisi perawatan pada saat kehamilan

Anti Ansietas: obat untuk mencegah gangguan cemas

Anti Sedative: obat atau zat yang menekan atau memperlambat aktivitas sistem saraf pusat (SSP) untuk menghasilkan efek tenang, menenangkan kecemasan, atau membantu tidur

ASI: Air Susu Ibu

IM: Intra Muscular

Laktasi: Proses menyusui pada masa nifas

Perinatal: masa kehamilan hingga sekitar satu tahun setelah bayi lahir.

Postnatal: kondisi atau periode waktu segera setelah melahirkan (persalinan), baik untuk ibu maupun bayi, yang berlangsung selama masa nifas hingga organ reproduksi wanita kembali normal, biasanya sekitar enam minggu pertama pasca-melahirkan.

Psikosomatis: kondisi di mana gejala penyakit fisik timbul, dipicu, atau diperparah oleh kondisi psikologis seperti stres, kecemasan, atau emosi negatif, meskipun tidak selalu ada penyebab fisik yang jelas untuk gejala tersebut

J. Referensi

- Sari, M. H., Furwasyih, D., Anggraeni, L., Komariyah, S., & Dwichristy, J. (2023). *Buku Ajar Psikologi Kebidanan*. Jakarta: Nuansa Fajar Cemerlang.
- Khasanah, A. N., & Sulistyawati, W. (2017). *Buku Ajar Nifas Dan Menyusui*. Surakarta: Kekata Publisher.
- Nurseha, Kusumastuti, Farida, S. N., Mardianingsih, S., & Marlinawati, I. T. (2024). *Buku Ajar Psikologi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas*. Jakarta: PT Nuansa Fajar Cemerlang .
- Nurul, A. (2023). *Buku Ajar Psikologi Pendidikan Profesi Bidan*. Sidoarjo: UMSIDA Press .
- Rosyidah, R., & Azizah, N. (2016). *Asuhan Kebidanan Masa Nifas Dan Menyusui*. Sidoarjo: UMSIDA Press.

BAB 2

ADAPTASI PSIKOLOGIS PADA BAYI

Tujuan Instruksional:

Mahasiswa mampu memahami Adaptasi Psikologis Pada Bayi

Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami tahapan adaptasi pada bayi
2. Mahasiswa mampu memahami Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Psikologi Bayi
3. Mahasiswa mampu memahami Tahap Perkembangan Psikologis Pada Bayi

Pendahuluan:

Bayi dilahirkan menjadi manusia yang sangat tergantung pada orang tua nya. Para ilmuwan dan penulis telah melakukan rekonseptualisasi tentang anak – anak yang berusia sangat muda, yaitu dari usia baru lahir hingga 3 tahun. Para ilmuwan terus mengungkapkan informasi baru yang vital tentang cara kerja otak bayi, yang meningkatkan pemahaman baru tentang kompetensi sosial bawaan pada bayi dan kapasitas belajar mereka.

Masa bayi telah menjadi objek invasif dalam penelitian seperti dikemukakan oleh Smith & Murphy pada tahun 1974 dalam bukunya yang berjudul, "*The Competent Infant*". Lipsitt menyatakan "Bayi normal dilahirkan dengan fungsi sistem sensori. Mereka sudah mempunyai kemampuan sejak lahir dalam sebuah hubungan keterikatan dengan orang lain. Tingkat akuisisi perilaku pada bayi adalah satu hal yang fenomenal. Aspek yang paling penting dalam perkembangan bayi pada bulan pertama adalah kapasitas untuk belajar. Seluruh tahap perkembangan melibatkan input yang luar biasa dan apresiasi dari bayi dengan stimulasi sensori, registrasi stimulasi pada memori, dan perubahan gaya dan perilaku sebagai hasil dari input pengalaman". Lipsitt menjelaskan lebih lanjut bahwa "jalan diantara perkembangan otak dan pengalaman individu adalah jalan dua arah".

Apa dan bagaimana bayi belajar pada tahun pertama kehidupan mereka adalah pondasi untuk pembelajaran di masa depan dan kualitas hidup mereka sepanjang usia. Studi dari Bower mengindikasikan kesimpulan yang berbeda tentang persepsi pada bayi. Menurut Bower bayi pada faktanya mempunyai kemampuan untuk meregistrasi

sebagian besar informasi yang dapat diregistrasi oleh otak orang dewasa, akan tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menangani informasi tersebut sebanyak yang bisa dilakukan oleh orang dewasa. Sejalan dengan kematangan perkembangannya, kemampuan dan kapasitas pengelolaan informasi pada bayi juga berkembang

Uraian Materi

A. Tahap Adaptasi Bayi

Perkembangan adalah suatu proses yang dimulai sejak saat pembuahan dan berlanjut sepanjang kehidupan seseorang. Menurut Pieter, perkembangan adalah serangkaian perubahan yang terjadi secara bertahap dan teratur sebagai hasil dari pengalaman dan proses belajar manusia. Dalam konteks buku ini, kita akan membahas perkembangan anak dengan fokus pada tahapan penting dalam proses adaptasi mereka. Tahapan perkembangan psikologis yang penting untuk diketahui oleh bidan adalah masa prenatal, masa neonatal, dan masa bayi (*babyhood*).

1. Adaptasi Masa Prenatal

Menurut penelitian Janiwarty dan rekan-rekan, dapat dijelaskan bahwa janin dalam kandungan bukanlah sebuah penumpang yang hanya bersifat pasif dalam tubuh ibu. Sebaliknya, janin aktif melakukan berbagai macam aktivitas seperti menendang, berputar, menggeliat, berkedip, menghisap jari, cegukan, dan sebagainya. Semua aktivitas tersebut menjadi bukti bahwa masa prenatal merupakan periode di mana janin menunjukkan gerakan aktif sebagai individu.

Ketika usia kehamilan mencapai 12 minggu, janin mulai menelan dan menghisap cairan ketuban yang berfungsi sebagai tempat mengapung. Cairan ketuban mengandung substansi yang menghubungkan plasenta dari aliran darah ibu dengan aliran darah janin. Gabungan dari kedua hal ini berperan dalam perkembangan sensor perasa dan penciuman. Hal ini pada akhirnya membuka kemungkinan adanya kontribusi dalam perkembangan organ untuk bernapas dan mencerna.

Ada beberapa adaptasi yang dialami oleh janin dalam masa prenatal, seperti adaptasi pendengaran, adaptasi penciuman (perasa), adaptasi belajar, dan mengingat. Respons terhadap suara dan getaran dari ibu mulai terjadi pada usia kehamilan 26 minggu dan terus meningkat. Janin dapat merespons suara atau beradaptasi dengan suara melalui detak jantung dan getaran suara yang dihasilkan oleh ibunya. Puncak respons janin terhadap suara sebagai salah satu proses adaptasi pendengaran terjadi pada usia kehamilan 32 minggu.

Pada periode adaptasi ini, bayi memiliki kemampuan untuk membedakan berbagai suara (*auditor*), dan kemampuan ini terus berkembang pesat setelah kelahiran. Jika janin mengalami kesulitan atau tidak mampu menerima stimulus yang cukup, maka kemungkinan bayi akan mengalami gangguan pendengaran, yang pada gilirannya dapat menyebabkan hambatan dan keterlambatan dalam perkembangan bahasa dan bicara.

Dalam penelitian Janiwarty dan koleganya, dijelaskan bahwa pada usia kehamilan 14 minggu, sel-sel perasa dan penciuman pada janin mulai matang dalam tubuh ibu. Organ-organ yang mengontrol penciuman juga semakin baik menjelang kelahiran. Bayi pada masa ini juga sudah mampu mencium aroma makanan yang dikonsumsi oleh ibunya. Rasa dan bau makanan ini disampaikan kepada janin melalui cairan ketuban. Bayi juga aktif dalam proses belajar, termasuk mendengarkan cerita-cerita yang dibacakan oleh ibunya sejak 6 minggu sebelum kelahiran. Dalam bidang psikologi dan obstetri, para ibu disarankan untuk memberikan rangsangan yang cukup (misalnya, cerita dan sentuhan) agar perkembangan psikologis anak menjadi lebih baik.

Namun, pada masa ini, seringkali timbul berbagai masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan psikologis bayi yang akan dilahirkan. Masalah-masalah ini dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis bayi jika bayi berada dalam kondisi tersebut. Lingkungan prenatal bayi adalah rahim ibunya, sehingga faktor-faktor seperti genetik, penyakit ibu, kesejahteraan psikologis ibu, usia ibu saat hamil, aktivitas fisik selama kehamilan, penggunaan obat-obatan, penggunaan narkoba, pola hidup yang tidak sehat, perilaku merokok, dan lingkungan fisik dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis bayi.

2. Adaptasi Masa Neonatal

Pada periode neonatal, bayi mengalami penyesuaian atau adaptasi yang sangat signifikan. Ini berarti bayi berpindah dari lingkungan dalam rahim ke lingkungan luar. Menurut penelitian Janiwarty dan rekan-rekannya, periode neonatal melibatkan penghentian perkembangan sementara, sehingga dianggap sebagai periode yang paling berisiko. Banyak kasus di mana bayi mengalami kematian karena ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.

Proses adaptasi yang dilakukan oleh bayi neonatal meliputi adaptasi terhadap perubahan suhu, adaptasi pernapasan, dan adaptasi pola mengisap dan menelan. Sementara itu, bayi pada periode neonatal juga memiliki fenomena adaptasi psikologis. Awal perkembangan bayi neonatal adalah bermula dari perkembangan otaknya, dimana pada gilirannya akan memengaruhi perkembangan psikologis. Misalnya, perkembangan intelektual, sensoris, motoris, dan kemampuan bayi menerima stimulus. Pada masa ini pula, juga terjadi adaptasi psikologis berupa kemampuan bayi mengekspresikan rasa takut, sedih, senang, menangis, atau merasakan orang lain ketika proses pemenuhan kebutuhannya.

Sejumlah faktor juga sangat memengaruhi kondisi psikologis bayi periode neonatal. Hal-hal yang mempengaruhi kehidupan bayi neonatal antara lain

lingkungan neonatal, jenis persalinan bayi, pengalaman persalinan, lamanya kehamilan, dan sikap orang tua pada bayi tersebut. Sikap dari orang tua maksudnya adalah bagaimana psikologis orang tua bayi saat menyambut kelahiran bayi tersebut. Jika orang tua memperlakukan bayi sebagai individu yang sangat berharga, hal itu akan mendorong bayi agar lebih mudah menyesuaikan diri.

Sejumlah bahaya psikologis yang dapat dialami oleh bayi usia neonatal di antaranya adalah ketidakberdayaan bayi neonatal sering kali membuat para orang tua ketakutan, terutama pasangan muda. Bahaya psikologis lain yang mungkin saja dialami oleh bayi neonatal adalah terhentinya perkembangan bayi untuk sementara waktu sebagai awal proses penyesuaian diri. Untuk bayi neonatal yang masih perlu dirawat di rumah sakit, kurangnya penerimaan rangsangan dapat memengaruhi psikologis bayi tersebut. Bayi neonatal juga akan mendapatkan bahaya psikologis jika mendapatkan sikap yang kurang menyenangkan dari orang tua, keluarga dan masyarakat sekitar.

3. Adaptasi Masa Babyhood

Pada masa *babyhood*, bayi akan mengalami perkembangan fisik yang berarti, baik dari pertumbuhan maupun perkembangan. Mekanisme perkembangan pada periode ini juga meliputi perkembangan yang sifatnya fisik maupun mental. Hal yang sifatnya fisik meliputi adanya penambahan berat badan, tinggi badan, proporsi fisik, tulang, otot, dsb. Bayi akan mengalami adaptasi berupa pertumbuhan badan yang dapat diukur serta perkembangan badan yang dapat diamati secara fisik.

Bayi yang mengalami sejumlah adaptasi fisiologis. Mulai dari perubahan adaptasi pola makan, yang semula mengisap dan menelan berubah menjadi mengunyah. Lalu, dari pola buang air, bayi juga mulai diajarkan toilet training (Latihan buang air). Bayi akan mengalami sejumlah adaptasi, baik secara motorik maupun sensorik. Babyhood merupakan periode bayi dengan kisaran umur 4-24 bulan. Pada masa ini pula, bayi akan semakin adaptif terhadap sejumlah gerak-gerak reflek.

Periode babyhood akan menunjukkan sejumlah adaptasi psikologis pada bayi. Secara psikologis, bayi akan mengalami perkembangan kognitif. Hal tersebut meliputi kemajuan dan kemampuan mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi yang diterima melalui gerakan fisik. Adaptasi psikologis lain dari periode babyhood ini adalah adanya perkembangan bicara. Kemampuan berbicara bayi juga berbeda-beda. Bayi memiliki sejumlah potensi melahirkan apa yang ada dalam diri bayi tersebut melalui suaranya. Suara

tersebut biasanya akan tersalurkan melalui tiga jenis komunikasi. Diantaranya adalah menangis, mengoceh (babbling), dan isyarat.

Bayi juga akan mengalami adaptasi psikologis berupa adaptasi terhadap emosi. Emosi menurut Janiwarty dkk merupakan perasaan atau afeksi yang melibatkan perpaduan gejala fisiologis dengan perilaku. Emosi ini direpresentasikan baik dalam afeksi negatif maupun positif. Fungsi emosi pada perkembangan bayi adalah sebagai bentuk penyesuaian diri, kelangsungan hidup, pengaturan, dan komunikasi. Sejumlah pola emosi bayi tersebut masih sangat sederhana. Semuanya berkaitan dengan pola komunikasi bayi yang merupakan ungkapan emosi bayi. Pembentukan perilaku moral bayi dapat ditunjukkan dari reaksi emosi, rasa takut, malu, bersalah, simpati, dan sederet emosi lainnya yang tentunya berkaitan dengan

proses perkembangan fisik bayi. Emosi-emosi tersebut ditunjukkan dengan berbagai macam hal, misalnya dari reaksi menangis, reaksi tersenyum dan tertawa, reaksi rasa bahagia, reaksi marah, reaksi kebencian, reaksi ketakutan, dan reaksi dari adanya perasaan kecewa.

Selain adaptasi dunia sosialnya, bayi pada masa babyhood ini juga akan mengalami adaptasi pada aspek psikoseksual. Fase pertama adalah fase oral, yakni sumber kenikmatan seks oral adalah menerima rangsangan melalui mulut, misalnya ketenangan saat menikmati puting susu ibu. Bayi yang tidak pernah menikmati putting susu ibu cenderung akan mengalami hambatan dalam perkembangan oral.

Hal ini membuat saat dewasa, bayi tersebut akan cenderung lebih cerewet dibandingkan dengan anak yang telah memiliki kepuasan seks oral. Kedua, fase anal, yakni ditandai dengan pembuangan feses. Pengendalian pembuangan feses merupakan salah satu bentuk pengendalian pada dorongan dalam diri. sikap ibu yang kasih sayang dan lembut saat membimbing anak melakukan pembuangan feses, akan membuat anak mengerti bahwa aktivitas tersebut sangat penting.

Adaptasi psikologis lainnya pada periode babyhood adalah adaptasi kepribadian bayi. Masa bayi sering kali diidentikkan dengan periode kritis perkembangan kepribadian anak. Hal ini dikarenakan pada periode ini, dasar peletakkan struktur kepribadian seorang anak akan terbangun. Pada tahun kedua kehidupan, bayi akan mulai menjauhkan diri dari ibunya seolah memiliki kehidupan baru berupa tahap otonomi yang berlawanan dengan rasa malu dan keragu-raguan, yang tampak dari aktivitasnya. Salah satu kepribadian sebagai bentuk adaptasi kepribadian bayi adalah munculnya sifat temperamen dan reaktif.

Bayi juga akan mengalami adaptasi psikologis berupa perkembangan kata hati (moral). Kata hati merupakan rasa ketidaknyamanan emosional yang muncul ketika melakukan suatu hal yang salah dan kemampuan diri untuk tidak melakukan hal itu. Awalnya, bayi memang tidak punya hierarki nilai suara hati, namun lambat laun bayi akan mempelajari moral dari orang tuanya. Bayi akan menganggap suatu tindakan itu salah hanya bila dia sendiri mengalami akibat buruk dari apa yang dilakukannya. Bentuk moral lain dari bayi yang dibiasakan dan dimiliki bayi dari orang tua adalah mengerti tentang barang-barang milik orang lain atau bukan miliknya.

Pada proses adaptasi psikologis sama babyhood ini, terdapat sejumlah masalah psikologis yang bisa saja terjadi. Bahaya psikologis yang terjadi pada bayi adalah kegagalan menguasai dan menyelesaikan tugas perkembangannya. Misalnya keterlambatan dalam bicara. Keterlambatan dalam hal motorik dapat menimbulkan keterlambatan. Berbicara pada masa bayi merupakan fase penting karena menjadi dasar alat komunikasi dan cakrawala sosial anak. Keterlambatan bicara ini bisa disebabkan oleh tingkat intelegensi yang rendah dan kurangnya rangsangan dari ibu/keluarga. Perkembangan motorik yang terganggu juga dapat mengganggu faktor psikologis bayi. Saat perkembangan motorik terganggu, maka akan berimbas pada anak yang kurang pandai dalam menyesuaikan diri.

Bayi di periode babyhood juga harus dihindarkan dari bahaya emosi. Bahaya emosi yang dimaksudkan disini adalah bayi harus diberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan emosinya. Misalnya, kebutuhan akan kasih sayang, keingintahuan, rasa gembira dan senang, menangis, dsb. Bayi harus diberi kesempatan pemenuhan emosi diatas agar tidak terjadi keterlambatan dalam perkembangannya. Jika bayi kurang kasih sayang, sikap-sikap yang tidak diinginkan akan muncul. Misalnya bayi akan tampak selalu murung, acuh tak acuh, lesu, dan gelisah.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Psikologi Bayi

Masa bayi berlangsung selama dua tahun pertama kehidupan setelah periode bayi baru lahir selama dua minggu. Masa bayi sering di anggap sebagai keadaan tidak berdaya di mana bayi setiap hari belajar untuk semakin mandiri, sehingga diakhir masa bayi dikenal sebagai anak kecil yang baru belajar berjalan. Sedangkan anak kecil biasa diasosiasikan dengan keadaan anak yang sudah dapat berjalan dan menguasai beberapa keterampilan mandiri. Masa bayi adalah masa dasar yang

sesungguhnya, meskipun seluruh masa anak-anak merupakan masa dasar. Dibawah ini merupakan factor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologi bayi:

1. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan bayi, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi bayi. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditemukan oleh keluarga, pola pergaulan, etika berinteraksi dengan orang lain banyak ditentukan oleh keluarga.

2. Kematangan

Untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasehat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional, disamping itu kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan.

3. Status Sosial Ekonomi

Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya.

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif, anak memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka dimasa yang akan datang.

5. Kapasitas Mental

Emosi dan intelegensi kemampuan berfikir dapat banyak, mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa dengan baik. Oleh karena itu jika perkembangan ketiganya seimbang maka akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan sosial anak

C. Tahap Perkembangan Psikologis Pada Bayi

1. Perkembangan Kognitif

Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian (pengetahuan), yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan

lingkungannya. Menurut Myers, "*Cognition refers to all the mental activities associated with thinking, knowing, and remembering*". Pengertian yang hampir senada juga diberikan oleh Margaret W Matlin, Yaitu, *cognition, or mental activity, involves the acquisition, storage, retrieval, and use of knowledge*." Dalam dictionary of *Psychology* karya Drever, dijelaskan bahwa kognisi adalah istilah umum yang mencakup segenap model pemahaman, yakni persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian dan penalaran". Dijelaskan bahwa kognisi adalah konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan, termasuk didalamnya mengamati, melihat, memperhatikan, memberikan, menyangka, membayangkan, memperkirakan, menduga, dan menilai. Secara tradisional, kognisi ini dipertentangkan dengan konasi (kemauan) dan dengan afeksi (perasaan).

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa kognitif adalah sebuah istilah yang digunakan oleh psikolog untuk menjelaskan semua aktifitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai dan memikirkan lingkungannya.

Selama masa bayi, kapasitas intelektual atau kognitif seseorang telah mengalami perkembangan. Uraian berikut akan membahas beberapa pandangan tentang perkembangan kognitif, terutama pandangan Piaget dan pandangan kontemporer, perkembangan persepsi, konsepsi, memori dan bahasa.

2. Perkembangan Psikososial

Perkembangan psikososial berhubungan dengan perubahan-perubahan perasaan atau emosi dan kepribadian serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, masa bayi adalah masa ketika anak-anak mulai belajar berjalan, berfikir, berbicara, dan merasakan sesuatu. Meskipun dalam pemenuhan kebutuhannya bayi masih sangat tergantung pada pengasuhnya, namun bukan berarti mereka sama sekali pasif. Sebab, sejak lahir pengalaman bayi semakin bertambah dan ia berpartisipasi aktif dalam perkembangan psikososialnya sendiri, mengamati dan berinteraksi dengan orang-orang disekitarnya.

Sebagai bayi yang sedang tumbuh menjadi lebih dewasa, dia memiliki kedekatan dan keterikatan emosional dengan orang-orang yang penting dalam hidupnya. Hal ini terlihat misalnya, bayi menangis ketika didekati oleh orang yang tidak dikenalnya, dan dia menyambut hangat kedatangan ibu atau bapaknya. Bayi juga berpartisipasi dalam menjalin hubungan dengan cara-cara yang lebih halus,

seperti ikut bermain bersama saudaranya yang lebih tua. Lebih dari itu, bayi juga menyatakan perasaan atau kebutuhannya dengan cara-cara

membbingungkan. Misalnya, ketika orang tuanya memberikan makanan tertentu, ia menolak tetapi ketika makanan tersebut diberikan oleh seorang baby sister, ia menerimanya dengan perasaan senang.

Perilaku demikian menunjukkan adanya dua tema utama dalam perkembangan psikososial selama masa bayi, yaitu kepercayaan dan otonomi. Bayi mempelajari apa yang diharapkan dari orang-orang yang penting dalam hidupnya, Mereka mengembangkan suatu perasaan mengenai siapa yang mereka senangi atau tidak mereka senangi dan makanan apa yang mereka sukai.

Dalam uraian berikut akan dikemukakan beberapa hal penting yang berkaitan dengan perkembangan psikososial pada masa bayi, diantaranya emosi, temperamen dan attachment (keterikatan).

3. Perkembangan Emosi

Emosi adalah sebuah istilah yang sudah populer, namun maknanya secara tepat masih membingungkan, baik dikalangan ahli psikologi maupun ahli filsafat. Oleh sebab itu kalau rumusan para psikolog tentang emosi sangat bervariasi sesuai dengan orientasi teoritisnya yang berbeda-beda. Meskipun demikian terdapat persesuaian umum bahwa keadaan emosional merupakan suatu reaksi kompleks yang mengait satu tingkat tinggi kegiatan dan perubahan-perubahan secara mendalam, serta dibarengi perasaan yang kuat, atau disertai keadaan afektif. Istilah emosi merujuk pada' *a feeling and its distinctive thoughts, psychological and biological states, and range of propensities to act*'. Sedangkan Morgan, King & Robinson mendefenisikan emosi sebagai' *A subjective feeling states, often accompanied by facial and bodily expressions, and having arousing and motivating properties*'. Jadi emosi dapat diartikan sebagai perasaan atau afeksi yang melibatkan kombinasi antara gejala fisiologis (seperti denyut jantung yang cepat) dan perilaku yang tampak (seperti senyuman atau ringisan).

Untuk dapat memahami secara pasti mengenai kondisi emosi bayi adalah sangat sukar, sebab informasi mengenai aspek emosi yang subjektif hanya dapat diperoleh dengan cara introspeksi sedangkan bayi-sesuai dengan usianya yang masih sangat muda-tidak dapat menggunakan cara tersebut dengan baik. Beberapa ahli mencoba memahami kondisi emosi bayi melalui ekspresi tubuh dan wajah, namun para ahli psikologi lain mempertanyakan seberapa penting kedua ekspresi tubuh dan wajah itu dapat menentukan apakah seorang bayi berada dalam suatu kondisi emosional tertentu.

Meskipun demikian, para ahli telah lama mempercayai bahwa kemampuan untuk bereaksi secara emosional sudah ada pada bayi yang baru lahir seperti menangis, tersenyum, dan frustrasi. Bahkan beberapa peneliti percaya bahwa beberapa minggu setelah lahir, bayi dapat memperlihatkan bermacam-macam ekspresi dari semua emosi dasar, termasuk kebahagiaan, perhatian, keheranan, ketakutan, kemarahan, kesedihan, dan kemukakan sesuai dengan situasinya. Disamping ada sejumlah emosi yang sudah berfungsi sejak lahir, ada pula emosi lain yang dipengaruhi oleh faktor pematangan (maturation) dan pengalaman belajar.

Untuk mengetahui apakah bayi benar-benar mengekspresikan emosi tertentu, Carroll dan Izard telah mengembangkan suatu sistem pengkodean ekspresi wajah bayi yang berkaitan dengan emosi tertentu yang dikenal dengan *Maximally Discrimination Facial Movement Coding System (MAX)*. Berdasarkan sistem klasifikasi Izard, diketahui beberapa ekspresi emosi selama masa bayi, yaitu kegembiraan tertawa diekspresikan pada usia 4 bulan, ketakutan pada usia 5 hingga 8 bulan, dan emosi-emosi yang lebih rumit seperti malu, kebingungan, rasa bersalah, cemburu, dan kebanggaan diekspresikan selama anak belajar berjalan. Secara singkat mengenai perkembangan emosi bayi ini dapat ditunjukkan dalam tabel 1 dibawah ini :

Tabel 4.1: Perkembangan Emosi Bayi

Umur	Umur Ekspresi Emosi
0-1 bulan	Senyuman sosial
3 bulan	Senyum Kesenangan
3-4 bulan	Kehati-hatian
4 bulan	Keheranan
4-7 bulan	Kegembiraan, Kemarahan
5-9 bulan	Ketakutan
18 bulan	Malu

Sumber: Mar'Art Samsunuwiyati, 2015

Ekspresi berbagai emosi tersebut mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan anak. 3 fungsi utama ekspresi emosi bayi yaitu : (1) adaptasi dan kelangsungan hidup (2) regulasi dan (3) komunikasi. Sehubungan dengan fungsi penyesuaian diri dan kelangsungan hidup, berbagai ketakutan (seperti takut gelap atau takut akan perubahan tiba-tiba di dalam lingkungan), adalah bersifat adaptif, karena ada kaitan yang jelas antara gejala perasaan dengan kemungkinan bahaya. Berkaitan dengan fungsi pengaturan, emosi

mempengaruhi informasi yang diseleksi anak-anak dari dunia persepsi dan perilaku yang mereka perlihatkan. Anak-anak yang sedang gembira misalnya, cenderung lebih mengikuti apa yang sedang mereka pelajari dibandingkan dengan anak-anak yang sedang merasa sedih. Kemudian berkaitan, dengan fungsi komunikasi, anak-anak menggunakan emosi untuk menginformasikan pada orang lain tentang perasaan-perasaan dan kebutuhan-kebutuhannya.

4. Perkembangan Temperamen

Temperamen (Tabiat, perangai) merupakan salah satu dimensi psikologis yang berhubungan dengan aktifitas fisik dan emosional serta merespons. Secara sederhana, Goleman merumuskan temperamen sebagai '*The moods that typify our emotional life*' sedangkan Baltes (mengartikan temperamen sebagai '*individual's behavioral style and characteristic way of responding*') Sementara itu Seifert dan Hoffnung menjelaskan : '*Temperamen refers to individual differences in responsiveness and self regulation that are present at birth, are relatively stable and enduring over time and cross situation, and are influenced by the intertion of heredity, maturation, and expperience*'.

Dari beberapa defenisi tersebut dapat dipahami bahwa temperamen adalah perbedaan kualitas dan intensitas respon emosional serta pengaturan diri yang memunculkan perilaku individual yang terlihat sejak lahir, yang relatif stabil dan menerap dari waktu ke waktu dan pada semua situasi, yang dipengaruhi oleh interaksi antara pembawaan, kematangan dan pengalaman. Sejak lahir, bayi memperlihatkan berbagai aktifitas individual yang berbeda-beda. Beberapa bayi sangat aktif menggerakkan tangan, kaki dan mulutnya tanpa hentihentinya, tetapi bayi yang lain terlihat lebih tenang. Sebagian bayi merespon dengan hangat kepada orang lain, sementara yang lain cerewet, rewel, dan susah diatur. Semua gaya perilaku ini merupakan temperamen seorang bayi.

Kebanyakan peneliti mengakui adanya perbedaan dalam kecenderungan reaksi utama, seperti kepekaan terhadap rangsangan visual dan verbal, respon emosional, dan keramahan dari bayi yang baru lahir. Penelitian Alexander Tomas dan Stella Chess misalnya memperlihatkan adanya perbedaan dalam tingkatan aktivitas bayi, keteraturan dari fungsi jasmani (makan,tidur, dan buang air), pendekatan terhadap stimulus dan situasi baru, kemampuan beradaptasi dengan situasi dan orang-orang baru, reaksi emosional, kepekaan terhadap ransangan, kualitas suasana hati dan jangkauan perhatian.

Dari hasil penelitian ini, Alexander Tomas & Stella Chess mengklasifikasikan temperamen atas tiga pola dasar. Pertama, bayi yang bertemperamen sedang (*easy babies*): menunjukkan suasana hati yang lebih positif, keteraturan fungsi tubuh, dan mudah beradaptasi dengan situasi baru. Kedua bayi yang

bertemperamen tinggi (*difficult babies*) : memperlihatkan suasana hati yang negatif, fungsi-fungsi tubuh tidak teratur, dan stress dalam menghadapi situasi baru. Ketiga, anak yang bertemperamen rendah (*slow to warm up babies*) memiliki tingkat aktifitas yang rendah dan secara relatif tidak dapat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru, suka murung serta memperlihatkan intensitas suasana hati yang rendah.

Pola-pola temperamen tersebut merupakan suatu karakteristik tetap sepanjang masa bayi dan anak-anak yang akan di bentuk dan diperbarui oleh pengalaman anak dikemudian hari. Misalnya, anak usia 2 tahun yang di golongan secara ekstrem sebagai pemalu dan penakut akan tetap menjadi anak yang pemalu dan penakut pada usia 8 tahun, ini menunjukkan adanya konsistensi perkembangan temperamen sejak lahir. Konsistensi temperamen ini ditentukan oleh faktor keturunan, kematangan dan pengalaman, terutama pola pengasuhan orang tua.

5. Perkembangan Attachment

Bayi yang baru lahir telah memiliki perasaan sosial, yakni kecenderungan alami untuk berinteraksi dan melakukan penyesuaian sosial terhadap orang lain. Hal ini berkaitan dengan kondisi bayi yang sangat lemah pada saat lahir, sehingga ia sangat membutuhkan pengasuhan dari orang lain dalam mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, tidak heran kalau bayi dalam semua kebudayaan mengembangkan kontak dan ikatan sosial yang kuat dengan orang yang mengasuhnya, terutama ibunya.

Kontak sosial pertama bayi dengan pengasuhnya ini diperkirakan mulai terjadi pada usia 2 bulan, yaitu pada saat bayi mulai tersenyum ketika memandang wajah ibunya. Kemampuan bayi untuk tersenyum pada usia dini tersebut berperan dalam memperkuat hubungan ibu dan anak. Sebab, dengan senyuman itu bayi ingin menyatakan pada ibunya bahwa ia mengenal atau mencintainya, dan karena itu akan mendorong ibu untuk membalas senyumannya, sehingga pada gilirannya masing-masing saling memperkuat respons sosial. Perkembangan awal kontak sosial pada bayi ini merupakan dasar bagi pembentukan hubungan sosial pada bayi ini merupakan dasar bagi pembentukan hubungan social dikemudian hari.

Kemudian, pada saat bayi memasuki usia 3 atau 4 bulan, mereka semakin memperlihatkan bahwa mereka mengenal dan menyenangkan anggota keluarga yang dikenalnya dengan senyuman, serta tetap dapat menerima kehadiran orang asing. Tetapi, pada usia kira-kira 8 bulan, muncul objek permanen bersamaan dengan kekhawatiran terhadap orang yang tidak dikenal, yang disebut dengan *stranger anxiety* (perasaan malu terhadap orang yang tak dikenal). Pada masa ini

bayi mulai memperlihatkan reaksi ketika didekati oleh orang yang tidak dikenalnya.

Setelah usia 8 bulan, seorang bayi dapat membentuk gambaran mental tentang orang-orang atau keadaan. Gambaran ini disebut skema, yang disimpan dalam memori dan kemudian diingatnya kembali untuk dibandingkan dengan situasi sekarang. Diantaranya skema terpenting yang dimiliki bayi usia 8 bulan adalah skema tentang wajah orang yang dikenal: ketika mereka tidak dapat menerima wajah baru dalam skema ingatan ini, mereka akan menjadi sedih.

Attachment adalah sebuah istilah untuk menggambarkan pertalian atau ikatan antara ibu dan anak. Menurut Martin Herbert dalam *The Social Sciences Encyclopedia*, *attachment* mengacu pada ikatan antara dua orang individu atau lebih : sifatnya adalah hubungan psikologis yang diskriminatif dan spesifik serta mengikat seseorang dengan orang lain dalam rentang waktu dan ruang tertentu.

Para ahli riset dan klinis lebih menaruh perhatian pada dua jenis ikatan, yaitu keterikatan dengan orang tua dan keterikatan dengan anak-anak, Sudah diakui secara luas bahwa anak-anak secara psikologis terikat kepada orang tua mereka. Bayi-bayi manusia mula-mula mengalami keterikatan dengan ibunya dan tidak lama kemudian dengan orang dekat selain ibu (*significan other*) dalam pertengahan kedua usia mereka yang pertama. Kebanyakan ahli psikologi perkembangan mempercayai bahwa attachment pada bayi merupakan dasar utama bagi pembentukan kehidupan sosial anak dikemudian hari. Menurut J Bowlby, pentingnya attachment dalam tahun pertama kehidupan bayi adalah karena bayi dan ibunya secara naluriah memiliki keinginan untuk membentuk suatu keterikatan. Secara biologis, bayi yang baru lahir diberi kelengkapan untuk memperoleh perilaku keterikatan dengan ibunya. Bayi menangis, menempel, merengek dan tersenyum. Kemudian, bayi merangkak, berjalan perlahan-lahan, dan mengikuti ibunya. Semua tingkat laku ini tidak lain adalah untuk mempertahankan agar ibu selalu dekat dengannya. Pada waktu yang sama , ternyata ibu memiliki rasa keterikatan dengan bayinya. Ketika perasaan keterikatan dengan bayi itu muncul, ibu akan terlihat suka mengajak bayinya berbicara atau bercanda, menenangkannya, mengayun-ayunkan serta berusaha memenuhi kebutuhan bayi dengan sebaik-baiknya.

Bowlby lebih jauh menjelaskan bahwa attachment berkembang melalui serangkaian tahap, yang Sebagian ditentukan oleh perubahan-perubahan kognitif dan Sebagian oleh interaksi yang benar-benar alami antara bayi dan pengasuhnya. Sebagaimana terlihat dalam tabel 2, Bowlby mengidentifikasi 4 tahap perkembangan attachment pada bayi:

Tabel 4.2: Tahap Perkembangan Attachment pada bayi

Tahap	Usia / Bulan	Tingkah Laku
Tahap 1 Indiscriminate Sociability	0-2	Bayi tidak membedakan antara orang-orang dan merasa senang dengan, atau menerima dengan senang orang yang dikenal dan yang tidak dikenal
Tahap 2 Attachment is the makin	2-7	Bayi mulai mengakui dan Menyukai orang-orang yang dikenal: tersenyum pada orang yang lebih dikenal
Tahap 3 : Specific, clear cut attachment	7-24	Bayi telah mengembangkan keterikatan dengan ibu atau pengasuh pertama lainnya dan akan berusaha untuk senantiasa dekat dengannya: akan menangis ketika berpisah dengannya
Tahap 4 Goal Coordinated partnerships	24 - seterusnya	Sekarang bayi merasa lebih aman dalam berhubungan dengan pengasuh pertama, bayi tidak merasa sedih selama berpisah dari ibu atau pengasuh pertamanya dalam jangka waktu yang lama

Sejumlah ahli psikologi perkembangan percaya bahwa attachment berkembang dari waktu ke waktu sebagai hasil interaksi yang berulang-ulang antara bayi dan ibunya (pengasuh) Mereka juga percaya attachment terdiri dari hubungan timbal balik yang sama kuat antara ibu dan anak, walaupun satu sama lain berbeda dalam memenuhi kebutuhan fisik dan emosionalnya. Semakin besar respon ibu terhadap sinyal-sinyal seperti tangisan, senyuman, sentuhan, dan kelekatan yang diberikan bayi, semakin kuat keterikatan di antara keduanya.

Berdasarkan hasil penelitian Harry Harlow, psikologi dari universitas Wisconsin, Madison pada akhir 1950-an terhadap bayi bayamonyet, berkesimpulan bahwa keterikatan bayi manusia pada ibunya mempunyai fungsi

yang sama pentingnya, yaitu memberikan rasa aman yang diperlukan bayi untuk bereksplorasi dengan lingkungannya, dan keterikatan itu membentuk dasar hubungan antar pribadi di kemudian hari. Anak-anak kecil lebih suka meneliti lingkungan asing pada waktu ibunya ada di dekatnya. Kegagalan membentuk keterikatan dengan seseorang atau beberapa orang pada tahun pertama kehidupannya.

Sesuai tahap perkembangan psikososial Erikson, tahun-tahun pertama kehidupan ditandai oleh perkembangan rasa percaya (*trust*) dan rasa tidak percaya (*mistrust*). Apa yang disebut Erikson dengan rasa percaya (*trust*) serupa dengan apa yang disebut Therese Benedek „ Kepercayaan penuh kepada seseorang (*confidence*), akan tetapi, sebagaimana diakui oleh Erikson ia lebih suka menggunakan kata *trust*, karena dalam kata *trust* itu terkandung lebih banyak aspek keifan dan kesaling tergantungan. Bagi seorang bayi hanya dikatakan percaya (*trusting*), sebab terlalu berlebihan apabila dikatakan bahwa ia mempercayakan diri sepenuhnya kepada seseorang (*confidence*). Lebih dari itu tambah Erikson, keadaan percaya pada umumnya mengandung tiga aspek, yaitu:

- a. Bahwa bayi belajar percaya pada kesamaan dan kesinambungan dari pengasuh luarnya
- b. Bahwa bayi belajar percaya diri dan dapat dipercaya pada kemampuan organ-organnya sendiri untuk menanggulangi dorongan-dorongan.
- c. Bahwa bayi menganggap dirinya cukup dapat dipercaya sehingga pengasuh tak perlu waspada dirugikan.

Menurut Erikson, bukti pertama menunjukkan adanya kepercayaan sosial pada bayi terlihat dalam kesenangan menikmati air susu, kepulasan tidur dan kemudahan buang air besar. Erikson yakin bahwa bayi mempelajari rasa percaya apabila mereka diasuh dengan cara yang konsisten dan hangat. Ini berarti bahwa hubungan antara bayi dengan ibunya menjadi sangat penting. Kala ibu memberi bayi makan, membuatnya hangat, memeluk dan mengajaknya berbicara, maka bayi tersebut akan memperoleh kesan bahwa lingkungannya dapat menerima kehadirannya secara hangat dan bersahabat. Inilah yang menjadi landasan pertama bagi rasa percaya. Sebaliknya, kalau ibu tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi, maka dalam diri bayi akan timbul rasa ketidakpercayaan terhadap lingkungannya.

Pengalaman akan adanya suatu pengaturan timbal balik antara peningkatan kemampuan bayi untuk menerima dan cara-cara pengasuhan ibu, secara berangsur-angsur membantu anak mengimbangi keadaan tidak seimbang yang disebabkan oleh ketidakmatangan homeostatis yaitu kecenderungan bagi organ-organ tubuh dan darah untuk mempertahankan diri agar tetap konstan

yang menyertainya sejak ia lahir. Seiring dengan timbulnya rasa senang dalam diri bayi, maka ketika saat-saat bangun yang semakin bertambah secara berangsur-angsur ia menemukan bahwa kian lama petualangan-petualangan panca inderanya membangkitkan perasaan akrab dengan lingkungan. Bentuk-bentuk rasa senang dan orang-orang yang berkaitan dengan rasa senang itu, akan menjadi sama iasa seperti rasa sangat tidak senang karena buang air besar. Oleh sebab itu, prestasi sosial pertama bayi adalah kerelaannya membiarkan ibu hilang dari pandangan tanpa kecemasan dan kemarahan, karena ibu sudah menjadi suatu kepastian batin dan kehadirannya kembali sudah menjadi suatu kepastian batin dan kehadirannya Kembali sudah dapat dipastikan.

Dengan demikian, bayi memiliki rasa percaya dalam dirinya cenderung untuk memiliki rasa aman dan percaya diri untuk mengeksplorasi lingkungan yang baru. Sebaliknya, bayi yang memiliki rasa tidak percaya (mistrust) cenderung tidak memiliki harapan-harapan positif.

D. Rangkuman Materi

Perkembangan adalah proses perubahan bertahap sejak pembuahan hingga sepanjang hidup. Fokus utama adalah perkembangan anak pada masa prenatal, neonatal, dan babyhood, yang masing-masing memiliki ciri adaptasi khusus. Perkembangan bayi terjadi dari masa perinatal, masa neonatal dan masa Babyhood.

Perkembangan anak pada masa awal kehidupan sangat dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan, dan interaksi dengan pengasuh. Masa prenatal hingga babyhood adalah fondasi utama bagi pertumbuhan fisik, kognitif, emosional, dan sosial anak.

Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Psikologi Bayi yaitu Keluarga sebagai lingkungan pertama, Kematangan fisik dan psikis, Status sosial ekonomi, Pendidikan dan Kapasitas mental (emosi, intelegensi, bahasa)

Tahap Perkembangan Psikologis pada bayi terdiri dari Kognitif: proses mental untuk memahami, mengingat, dan memecahkan masalah (menurut Piaget & teori lain). Psikososial: bayi membangun kepercayaan, otonomi, dan hubungan emosional dengan pengasuh. Emosi: sejak lahir bayi dapat mengekspresikan emosi dasar (senyum, menangis, takut, marah), berkembang bertahap hingga kompleks. Temperamen: bawaan sejak lahir, relatif stabil, dipengaruhi genetik dan pengalaman. Tiga tipe utama: easy, difficult, slow-to-warm-up. Dan Attachment (Keterikatan): ikatan emosional bayi dengan pengasuh, terutama ibu. Perkembangan keterikatan menurut Bowlby melalui 4 tahap, dari indiscriminate sociability hingga goal-coordinated partnerships. Attachment yang baik menjadi dasar rasa percaya, keamanan, dan hubungan sosial di masa depan.

E. Latihan Soal

1. Menurut Pieter, perkembangan adalah ...

- a. Perubahan fisik yang terjadi sepanjang masa anak-anak
- b. Serangkaian perubahan yang terjadi secara bertahap dan teratur karena pengalaman dan proses belajar manusia
- c. Perubahan perilaku yang hanya dipengaruhi oleh faktor genetik
- d. Suatu kondisi tetap sejak pembuahan hingga dewasa
- e. Kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan luar

2. Faktor berikut bukan termasuk yang memengaruhi kesejahteraan psikologis bayi dalam masa prenatal adalah

- a. Genetik
- b. Pola hidup ibu yang tidak sehat
- c. Penggunaan narkoba
- d. Pola komunikasi bayi
- e. Lingkungan fisik ibu

3. Pada masa neonatal, faktor yang dapat memengaruhi kondisi psikologis bayi adalah

- a. Aktivitas menendang janin dalam rahim
- b. Jenis persalinan dan pengalaman persalinan
- c. Fase oral dalam psikoseksual
- d. Perkembangan temperamen bayi
- e. Kapasitas intelektual bayi saat dewasa

4. Menurut J Bowlby, tahap perkembangan attachment pada bayi usia 7–24 bulan ditandai dengan

- a. Bayi tidak membedakan antara orang yang dikenal atau tidak dikenal
- b. Bayi mulai mengakui orang-orang yang dikenal dan tersenyum pada mereka
- c. Bayi telah mengembangkan keterikatan dengan pengasuh pertama dan menangis saat berpisah
- d. Bayi merasa aman walau ditinggal pengasuh dalam waktu lama
- e. Bayi mulai memperlihatkan stranger anxiety sejak lahir

5. Pada masa babyhood (4–24 bulan), bentuk adaptasi fisiologis yang dialami bayi antara lain adalah

- a. Perubahan pola makan dari mengisap menjadi mengunyah
- b. Perkembangan kemampuan membaca dan menulis

- c. Kemampuan untuk berpikir abstrak
- d. Keterampilan bekerja sama dalam kelompok
- e. Peningkatan kontrol diri sepenuhnya

Kunci Jawaban

- 1. B
- 2. D
- 3. B
- 4. C
- 5. A

F. Glosarium

Antenatal: kondisi perawatan pada saat kehamilan

Laktasi: Proses menyusui pada masa nifas

Perinatal: masa kehamilan hingga sekitar satu tahun setelah bayi lahir.

Postnatal: kondisi atau periode waktu segera setelah melahirkan (persalinan), baik untuk ibu maupun bayi, yang berlangsung selama masa nifas hingga organ reproduksi wanita kembali normal, biasanya sekitar enam minggu pertama pasca-melahirkan.

Feses: Tinja / kotoran manusia

G. Referensi

- Sari, M. H., Furwasyih, D., Anggraeni, L., Komariyah, S., & Dwichristy, J. (2023). *Buku Ajar Psikologi Kebidanan*. Jakarta: Nuansa Fajar Cemerlang.
- Khasanah , A. N., & Sulistyawati , W. (2017). *Buku Ajar Nifas Dan Menyusui*. Surakarta: Kekata Publisher.
- Nurseha, Kusumastuti, Farida, S. N., Mardianingsih, S., & Marlinawati, I. T. (2024). *Buku Ajar Psikologi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas*. Jakarta: PT Nuansa Fajar Cemerlang .
- Nurul, A. (2023). *Buku Ajar Psikologi Pendidikan Profesi Bidan*. Sidoarjo: UMSIDA Press .
- Rosyidah, R., & Azizah, N. (2016). *Asuhan Kebidanan Masa Nifas Dan Menyusui*. Sidoarjo: UMSIDA Press.

BAB 3

DAMPAK KEHAMILAN DAN PERSALINAN TERHADAP STATUS KESEHATAN MENTAL PEREMPUAN

Tujuan Intruksional:

- Menjelaskan konsep kesehatan mental perempuan
- Menjelaskan dampak kehamilan terhadap status kesehatan mental perempuan
- Menjelaskan dampak persalinan terhadap status kesehatan mental perempuan

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan konsep kesehatan mental perempuan
2. Mampu mendeskripsikan dampak kehamilan terhadap status kesehatan mental perempuan
3. Mampu mendeskripsikan dampak kehamilan terhadap status kesehatan mental perempuan

Pendahuluan:

Menurut Shahid dkk., (2022), ibu hamil mengalami banyak perubahan fisik, mental, dan emosional selama masa ini, yang mungkin berdampak pada kesehatan mental ibu. Kecemasan selama kehamilan berhubungan dengan risiko yang lebih tinggi yaitu terjadinya masalah mental pada ibu hamil (Sunarmi dkk., 2022). Efek negatif pada kesehatan mental selama kehamilan, termasuk stres yang dapat mengganggu pertumbuhan janin atau bahkan membahayakan nyawa ibu, dapat diakibatkan oleh perawatan prenatal yang tidak memadai (Montagnoli dkk., 2020). Beberapa hal yang dapat membuat ibu hamil berisiko mengalami masalah kesehatan mental antara lain adalah dukungan suami dan keluarga selama masa kehamilan, umpan balik positif dan negatif dari orang-orang di sekitarnya, kurangnya rasa percaya diri atau keyakinan diri terhadap situasi saat ini, dan kesulitan keuangan di rumah (Franks dkk., 2017). Penyebab stres telah diteliti pada populasi secara umum, dimana kita membutuhkan lebih banyak penelitian tentang kecemasan terkait persalinan, stres, dan kesehatan mental jika kita ingin membantu para ibu dan bayi mereka yang baru lahir agar dapat mengatasinya dengan lebih baik (Liu dkk., 2021). Agar bayi dapat keluar dari rongga

rahim dan memasuki dunia luar, jalan lahir harus dipersiapkan selama persalinan. Biasanya, teknik ini dapat dilakukan melalui persalinan alami atau operasi caesar. Perubahan fisiologis dan psikologis yang alami dapat terjadi pada ibu sebagai konsekuensi dari pengeluaran energi yang tinggi setelah melahirkan. Untuk meminimalkan konsekuensi negatif pada ibu dan bayi, masalah ini harus segera ditangani dengan bantuan lingkungan dan profesional. Perubahan hormon, faktor psikologis termasuk perasaan tidak berdaya, dan pengalaman persalinan yang traumatis atau tidak terduga dapat memicu hal tersebut. Kehamilan dan persalinan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, tetapi ada beberapa cara untuk mengatasinya, seperti cukup tidur, berolahraga secara teratur, dan mencari bantuan medis seperti konseling atau pengobatan. Pendidikan tentang kehamilan, bersama dengan jalur komunikasi yang terbuka dengan pasangan dan penyedia layanan kesehatan, juga sangat penting bagi para ibu untuk merasa lebih baik secara mental dan fisik selama kehamilan.

A. Kesehatan Mental Perempuan

1. Pengertian Kesehatan Mental Perempuan

Jika seseorang tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit mental, kita mengatakan bahwa mereka sehat secara mental. Ketika pikiran seseorang sehat, mereka dapat menghadapi stres dengan cara yang sehat dan menjalani kehidupan sehari-hari secara teratur (Putri et al., 2015). Setiap perubahan dalam kehidupan seseorang yang membutuhkan adaptasi atau modifikasi untuk mengatasi tekanan (ketegangan mental) yang muncul dianggap sebagai stresor psikososial. Namun demikian, beberapa individu kesulitan untuk beradaptasi dan mengatasinya, sehingga menimbulkan masalah mental. Masalah dalam pernikahan, seperti pertengkaran, perpisahan, perceraian, perselingkuhan, atau kehilangan pasangan, dan dalam pengasuhan anak, seperti kelebihan atau kekurangan anak, atau anak yang tidak sehat atau memiliki masalah perilaku, merupakan contoh stres psikososial.

Konflik dalam hubungan interpersonal dapat muncul dalam berbagai cara, termasuk perselisihan dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan, serta faktor eksternal seperti relokasi dan penggusuran. Banyak hal yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bekerja, misalnya pensiun, kelelahan, terlalu banyak bekerja, uang, pertumbuhan, kesehatan, keluarga, dan masalah pribadi lainnya (Kemkes, 2019).

2. Prinsip – Prinsip Kesehatan Mental

Fakhriyani (2019) menyatakan bahwa kesehatan mental didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Memiliki kesehatan mental yang baik tidak sama dengan tidak memiliki perilaku menyimpang sama sekali. Hanya dengan menyatakan bahwa seseorang yang sehat secara mental tidak abnormal atau normal saja tidak cukup. Berbeda dengan konotasi negatifnya sebagai sebuah konstruksi statistik, istilah "kesehatan mental" memiliki konotasi yang lebih optimis.
- b. Gagasan tentang kesehatan mental sangat baik. Menjaga kesehatan mental seseorang harus menjadi prioritas utama, seperti yang ditekankan oleh gagasan ini. Selain itu, gagasan bahwa kesehatan mental ada dalam sebuah spektrum juga diakui. Mengingat hal ini, sangat penting bagi individu untuk mendapatkan perawatan kesehatan terbaik dan bekerja tanpa lelah untuk mempertahankan tingkat perawatan tersebut.
- c. Kesehatan mental seseorang merupakan indikator kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Menurut gagasan ini, kesehatan mental seseorang adalah

ukuran kualitas hidup mereka. Tidak ada yang dapat mengatakan bahwa kualitas hidup seseorang meningkat ketika kesehatan mentalnya meningkat, atau seseorang dapat mengatakan bahwa kesehatan mentalnya meningkat ketika kualitas hidupnya meningkat. Berdasarkan hal tersebut di atas, adalah masuk akal untuk mengatakan bahwa seseorang dianggap berada dalam kondisi kesehatan mental yang baik ketika aspek fisik, emosional, intelektual, dan kepribadiannya bekerja pada kinerja puncak; mereka mampu mengatasi dan bahkan berkembang dalam menghadapi stres dan tantangan lingkungan lainnya; mereka selaras dengan dan menguasai lingkungan mereka; mereka merasa aman dengan diri mereka sendiri; mereka mampu beradaptasi dan berkembang sesuai dengan ekspektasi sosial budaya mereka; mereka mampu tumbuh dan berkembang sepanjang hidup mereka; mereka mampu menerima dan mengatasi kekurangan pribadi mereka; mereka mampu menghadapi masalah; mereka menikmati hubungan yang bermakna; dan akhirnya, mereka bahagia.

3. Aspek – Aspek Kesehatan Mental

Komponen kesehatan mental dalam penelitian ini diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Veit & Ware (1983). Ada beberapa aspek dalam kesehatan mental, termasuk:

- a. *Psychological Distress* mendeskripsikan orang dengan kesehatan mental yang buruk digambarkan sebagai orang yang berada dalam kondisi tekanan psikologis. Beberapa gejala klinis muncul dan dilihat oleh orang-orang sebagai indikator kesehatan mental yang buruk. Individu mungkin mendapati bahwa gejala-gejala ini memengaruhi kehidupan pribadi dan sosialnya. Kecemasan, yang dapat muncul dalam bentuk mental dan fisik, adalah tanda klinis pertama. Gejala depresi, yang ditandai dengan kemurungan yang terus-menerus dan berlebihan, adalah tanda kedua. Ketidakmampuan untuk mengatur emosi atau tindakan seseorang adalah tanda ketiga.
- b. *Psychological Well-Being Mental health* yaitu kesehatan mental ada dua kutub, kesehatan mental yang baik dan kesehatan mental yang buruk, gagasan tentang kesehatan mental paling baik dipahami sebagai sebuah kontinum. Kondisi kesejahteraan psikologis mencirikan keadaan positif, sementara adanya ketidaknyamanan psikologis mencirikan keadaan negatif. Orang yang sehat secara mental dikatakan berada dalam kondisi kesejahteraan psikologis. Indikasi pribadi seperti kebahagiaan, kepuasan terhadap hidup, dan ikatan emosional yang kuat memberikan bukti akan hal ini. Orang yang sehat secara mental merasa puas dengan diri mereka sendiri, memiliki hubungan yang kuat

dengan orang-orang di sekitar mereka, dan secara konsisten menetapkan dan mencapai tujuan yang dapat dicapai.

4. Faktor – faktor yang mempengaruhi Kesehatan Mental

Variabel biologis, psikologis, lingkungan, dan sosial-budaya adalah empat pilar yang menjadi dasar dari kesehatan mental :

a. Faktor Biologis

Sejumlah penelitian telah meneliti hubungan antara variabel biologis pada manusia dan gangguan kesehatan mental. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa susunan biologis manusia secara signifikan memengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Genetika, otak, indera, sistem endokrin, jenis kelamin, usia, dan kondisi ibu saat hamil merupakan faktor-faktor yang berdampak pada kesehatan mental. Variasi hormon antara jenis kelamin berdampak pada kualitas tidur, yang pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan psikologis. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, sebanyak 14 juta orang dewasa muda di negara ini melakukan bunuh diri sebagai akibat dari masalah kesehatan mental, stres, atau depresi pada tahun 2018. Penyakit mental mungkin memiliki penyebab biologis yang menurun dalam keluarga. Risiko seseorang mengalami depresi meningkat 20-30% jika mereka memiliki riwayat keluarga dengan gangguan tersebut. Penelitian dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang menemukan prevalensi 54,2% untuk penyakit mental dan peningkatan risiko tiga kali lipat untuk terkena penyakit tersebut pada mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi tersebut (Wahyuningsih & Mamnu'ah, 2015).

b. Faktor Psikologis

Kondisi mental manusia tidak dapat dipisahkan dari tubuh manusia. Kesehatan mental seseorang dapat dipengaruhi oleh serangkaian pengalaman unik mereka, pelajaran yang telah mereka pelajari dari pelatihan dan peristiwa kehidupan mereka, kebutuhan mendasar mereka, dan sejumlah faktor psikologis lainnya seperti temperamen, ketahanan terhadap stres, kemampuan kognitif, dan sebagainya.

c. Faktor Sosial Budaya

Dalam lingkungan sosial manusia menghabiskan tahun-tahun formatifnya. Seseorang memiliki kapasitas untuk menyerap, memproses, dan menginternalisasi semua aspek lingkungan sosialnya. Stratifikasi sosial, dinamika keluarga, norma-norma budaya, pergeseran masyarakat, tuntutan pekerjaan, dan tekanan psikososial lainnya merupakan aspek-aspek lingkungan sosial dan budaya yang berdampak pada kesehatan mental seseorang.

d. Faktor Lingkungan dan Alam

Setiap saat setiap hari, manusia terlibat dalam suatu interaksi dengan alam dan lingkungan di sekitarnya. Hubungan ini menunjukkan adanya ekosistem di alam. Karena ada kesatuan yang tak terpisahkan dalam cara manusia dan alam berinteraksi satu sama lain. Beberapa abad sebelumnya telah melihat pertumbuhan yang luar biasa dalam pemahaman manusia dan kemampuan teknologi, yang berpuncak pada munculnya revolusi industri keempat. Banyak yang percaya bahwa kondisi lingkungan dan fenomena alam berdampak pada kesejahteraan emosional dan psikologis manusia. Beberapa contoh elemen lingkungan yang mungkin memiliki dampak adalah sebagai berikut: lingkungan di sekitar kesehatan dan pendidikan; lingkungan di sekitar komponen fisik, kimia, dan biologis; dan lingkungan di sekitar peristiwa traumatis yang disebabkan oleh alam, seperti kebakaran dan bencana alam.

B. Dampak Kehamilan terhadap Status Kesehatan Mental Perempuan

a. Kehamilan dan kesehatan mental

Ada banyak perubahan nyata yang terjadi pada fisik wanita selama kehamilan. Perubahan dalam pikiran dan jiwa sama pentingnya dengan perubahan dalam tubuh. Kecemasan seorang wanita selama kehamilan merupakan respon emosional terhadap kekhawatirannya tentang kesehatan janin yang dikandungnya, durasi kehamilannya, proses persalinan, waktu setelah persalinan, dan peran barunya sebagai seorang ibu (Novelia et al., 2022). Menurut Elvina dkk., (2018), perubahan psikologis yang paling mencolok yang dialami para ibu seiring bertambahnya usia kehamilan mereka adalah perasaan khawatir yang terus berlanjut hingga waktu persalinan. Yang dimaksudkan ketika berbicara tentang kesehatan mental seorang ibu selama dan setelah kehamilannya adalah kestabilan emosi, sosial, dan psikologisnya. Perubahan suasana hati yang ringan adalah hal yang biasa terjadi selama kehamilan karena perubahan hormon, tetapi beberapa wanita memiliki masalah kesehatan mental yang lebih parah selama dan setelah kehamilan yang mungkin memerlukan bantuan profesional (Arikalang dkk., 2023).

Karena kesehatan mental mereka sangat rentan terhadap berbagai perubahan yang terjadi selama kehamilan, wanita hamil memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan mental. Sekitar 20% wanita hamil memiliki beberapa jenis masalah kesehatan mental baik sebelum atau setelah melahirkan (Kemenkes RI, 2022). Pemeriksaan kesehatan prenatal untuk ibu hamil sering kali mengabaikan kesehatan mental wanita, meskipun kesehatan mental memiliki peran penting dalam kesehatan reproduksi (Deo dkk., 2020). Depresi

adalah gejala umum dari banyak penyakit kesehatan mental yang mungkin diderita oleh wanita hamil. Sayangnya, baik ibu hamil maupun penyedia layanan kesehatan cenderung mengabaikan tanda-tanda awal depresi ini karena prevalensinya yang dianggap rendah (Ria dkk., 2018). Tujuan 3.1 yang membahas tentang kematian ibu, merupakan salah satu tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang membahas tentang kesehatan mental ibu hamil. Masalah kesehatan mental yang muncul selama dan setelah persalinan berkontribusi terhadap kematian ibu.

b. Dampak kesehatan mental pada kehamilan

Menurut statistik yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kecemasan memengaruhi sekitar 4% populasi dunia saat ini. Gangguan kecemasan menyumbang 301 juta kasus di seluruh dunia pada tahun 2019, menjadikannya sebagai kondisi mental yang paling banyak terjadi (WHO, 2023). Kecemasan memengaruhi 8-10% wanita hamil pada tahun 2020, dan angka tersebut meningkat menjadi 12% sebelum melahirkan (WHO, 2020). Kecemasan sering terjadi pada ibu hamil di seluruh dunia, menurut sejumlah penelitian. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan di Australia oleh Val & Míguez (2023), gejala kecemasan dilaporkan oleh 6,8% hingga 59,5% wanita hamil. Sekitar 43,3% ibu hamil di Indonesia menderita kecemasan dan dari total populasi Jawa, 679.765 ibu hamil (atau 355.873 dari total 679.765) melaporkan kekhawatiran tentang melahirkan (Elsera dkk., 2022).

Menurut Rwakarema dkk., (2015), ketika ibu menderita kecemasan selama kehamilan, hal ini dapat memengaruhi kesehatan mental mereka setelah melahirkan, kesehatan bayi mereka, dan kualitas persalinan secara keseluruhan. Kecemasan yang terabaikan selama kehamilan meningkatkan kemungkinan depresi pascapersalinan, yang pada gilirannya berdampak pada kesehatan dan perkembangan ibu dan anak (Norhayati dkk., 2015). Ibu hamil yang mengalami kecemasan tingkat tinggi, menurut penelitian Astria dkk., (2019), lebih mungkin melahirkan bayi prematur, mengalami keguguran, dan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Menurut Ismawati (2017) mengatakan bahwa kecemasan sedang dilaporkan oleh 50% ibu hamil, kecemasan ringan oleh 46% ibu, dan kecemasan berat oleh 4% ibu. Terdapat peningkatan risiko depresi pascapersalinan sebesar 3,84 kali lipat pada wanita yang mengalami kecemasan selama kehamilan. Kecemasan dan kesedihan pascamelahirkan merupakan kontributor utama terhadap perkembangan masalah kesehatan mental. Menurut Wulandari & Rohmah (2019), kecemasan yang terus menerus dapat memicu sistem saraf simpatik, yang kemudian merangsang paru-paru untuk menghirup oksigen. Hal ini menyebabkan jantung memompa darah dengan kuat ke seluruh

tubuh, termasuk janin melalui plasenta di dalam rahim ibu. Keguguran (abortus) dapat terjadi apabila janin mengalami guncangan hebat akibat tekanan kuat yang diberikan kepadanya oleh tekanan darah tinggi yang masuk ke dalam rahim.

c. Faktor yang mempengaruhi kecemasan pada ibu hamil

Tingkat kecemasan ibu hamil dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan paritas. Kemampuan kognitif ibu, stabilitas ekonomi, jaringan sosial, dan yang paling penting, dukungan emosional dan praktis dari suami selama kehamilan, semuanya memiliki peran dalam tingkat kecemasan wanita (Handayani, 2015).

1) Usia ibu

Hasil kehamilan dipengaruhi oleh beberapa variabel, salah satunya adalah usia ibu. Dalam hal memiliki keluarga, kesempatan terbaik adalah menunggu hingga berusia dua puluhan atau tiga puluhan. Preeklampsia adalah salah satu komplikasi yang lebih sering terjadi pada kehamilan remaja dibandingkan dengan usia reproduksi yang sehat. Hal ini terjadi ketika organ reproduksi wanita belum berkembang sempurna, yang dapat berdampak negatif pada kesehatannya dan kesehatan janin yang dikandungnya (Setiawan & Nurfaiza, 2021). Kehamilan yang terjadi saat seorang perempuan berada pada usia reproduksi yang baik akan lebih baik karena sesuai dengan perkembangan psikologisnya. Seorang calon ibu akan menemukan posisi barunya sebagai angin lalu pada usia ini. Rahim secara psikologis dan fisik telah siap untuk mengakomodasi kehamilan antara usia 20 dan 35 tahun, sehingga jangka waktu tersebut sangat ideal bagi seorang wanita hamil. Umumnya aman untuk memiliki bayi antara usia 20 dan 35 tahun. Karena usia di atas 35 tahun dikaitkan dengan peningkatan risiko cacat bawaan dan masalah neonatal (Alini dkk., 2024).

2) Paritas

Kondisi yang menggambarkan kelahiran sekelompok atau beberapa kelompok perempuan selama siklus reproduksi adalah paritas, yang didefinisikan sebagai jumlah anak yang dilahirkan hidup (BKKBN, 2021). Khususnya bagi perempuan yang memasuki masa persalinan pada trimester ketiga, paritas seorang perempuan dapat berdampak pada kesehatan mentalnya. Saat usia kehamilan mendekati waktu persalinan, ibu hamil dengan paritas primigravida sering mendengarkan cerita tentang apa yang akan terjadi saat persalinan dan merasa takut karena masih belum tahu apa yang akan terjadi (Arinda & Herdayati, 2021). Sebagian besar wanita yang hamil kembar memiliki pengetahuan tentang hamil dan melahirkan dari kehamilan sebelumnya. Mereka cenderung lebih mempersiapkan diri secara emosional

dan psikologis saat hamil. Jawaban dari pertanyaan "apa" - "apa itu air?" "apa itu manusia?" "apa itu alam?" merupakan hal yang mendasar bagi pengetahuan manusia (Agisna dkk., 2023).

3) Umur kehamilan

Seluruh proses dari saat pembuahan hingga bayi lahir dikenal sebagai fase hamil. Dari hari pertama haid terakhir hingga bayi lahir, kehamilan umumnya berlangsung selama 280 hari, yaitu 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Trimester pertama dimulai saat pembuahan dan berlangsung selama tiga bulan; trimester kedua dimulai pada usia empat bulan dan berlangsung selama enam bulan; dan trimester ketiga berlangsung selama sembilan bulan (Saifuddin, 2022). Menurut Ans Efi Irawati (2020) menemukan bahwa lebih dari separuh ibu hamil pada trimester kedua tidak mengalami kecemasan. Dua belas ibu hamil (85,7% dari total) mengalami kecemasan sedang (Febriati & Zakiyah, 2022). Dorsinta dan Dwi Lestari menemukan adanya hubungan yang signifikan secara statistik antara kondisi kesehatan ibu, graviditas, dan usia kehamilan dengan tingkat kecemasan yang dialami ibu menjelang persalinan (Siallagan & Lestari, 2018).

4) Pendidikan

Pendidikan adalah upaya sistematis dan terencana untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, lingkungan, dan disiplin dasar yang dibutuhkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat hukum (Arinda & Herdayati, 2021). Pengetahuan dan tingkat kematangan intelektual seseorang meningkat seiring dengan tingkat pendidikannya. Mereka memprioritaskan kesejahteraan diri sendiri dan keluarganya. Hawari (2016) mencatat fenomena yang sama, menyatakan bahwa kapasitas seseorang untuk berpikir kritis dan menyerap pengetahuan baru dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya, yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah stres yang dialami ibu hamil. Penelitian dan pengalaman menunjukkan bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan lebih langgeng daripada perilaku yang didasari oleh perilaku, sehingga tingkat pengetahuan ibu hamil menjadi faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

5) Status ekonomi

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Tang dkk., (2019) mengungkapkan bahwa wanita hamil sering mengalami stres prenatal ringan hingga sedang, dan stres ini berkorelasi dengan pendapatan keluarga. Menurut penelitian lain, wanita yang menjadi ibu rumah tangga atau tidak bekerja selama kehamilannya lebih mungkin mengalami gejala stres prenatal dan kecemasan dibandingkan dengan mereka yang bekerja (Rusli dkk., 2012).

Menurut Campillo dkk., (2017), menganggur dapat menyebabkan status sosial ekonomi yang lebih rendah, lebih banyak konflik keluarga, peningkatan perilaku tidak sehat (seperti merokok dan minum-minuman keras), peningkatan kesepian (karena memiliki banyak waktu luang tanpa ada orang yang bisa diajak untuk menghabiskan waktu bersama), dan rasa keterikatan (karena bergantung pada orang lain secara finansial). Ada beberapa bukti bahwa masalah ekonomi, seperti cara hidup seseorang, berkontribusi terhadap stres ibu dan bahkan depresi selama kehamilan (Syam & Aminah, 2019); Kusuma, 2019).

6) Jenis keluarga

Ketika pasangan pertama kali mulai berkencan, mereka mungkin tinggal dengan satu set orang tua. Seiring berjalannya waktu, mereka akan saling mengenal satu sama lain, menemukan ruang mereka sendiri, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka. Kesehatan mental ibu lebih baik di rumah tangga inti dibandingkan dengan mereka yang anak-anaknya tinggal bersama keluarga besar, menurut penelitian di Turki tahun 2019 (Kaya & Akdogan, 2022).

7) Dukungan suami

Salah satu aspek eksternal yang mempengaruhi kecemasan ibu hamil adalah dukungan suami. Tingkat kecemasan wanita hamil akan meningkat jika tidak ada dukungan dari suaminya. Suami yang mendukung selama kehamilan dan masa nifas dapat membuat perbedaan besar. Demi kesehatan janin yang dikandungnya, para suami harus menghindari pertengkaran dan mencari cara untuk meredakan emosinya agar ibu hamil tidak terlalu cemas (Sudirman dkk., 2019).

d. Penatalaksanaan kesehatan mental pada kehamilan

Terdapat berbagai cara sebagai penanganan kecemasan pada ibu hamil antara lain :

1) Dukungan suami

Dalam hal membantu ibu hamil mengatasi kecemasan, peran dan dukungan yang diberikan oleh suami dan anggota keluarga lainnya sangatlah penting dan kuat. Seorang pasangan dapat menjadi sumber stabilitas finansial dan emosional bagi istrinya. Perubahan suasana hati dan ketidakstabilan adalah pengalaman yang umum dialami oleh wanita hamil. Oleh karena itu, dukungan fisik dan emosional dari seorang suami sangat penting bagi istrinya (Rusdiana, 2022).

2) Dukungan tenaga kesehatan

Kecemasan selama kehamilan dapat diatasi melalui konseling dengan penyedia layanan kesehatan, seperti bidan. Menurut Sari & Afifah (2022), bidan memainkan peran penting dalam meringankan kecemasan persalinan dengan menggunakan berbagai teknik yang membantu ibu hamil merasa nyaman, siap, dan tenang dalam menghadapi proses persalinan. Dukungan dari penyedia layanan kesehatan dapat berupa berbagai bentuk, termasuk penyediaan sumber daya keuangan dan moral, serta penyediaan dukungan emosional dan fisik, dorongan, dan perawatan. Menurut Wahyu Agustini (2018), tenaga kesehatan dapat membantu masyarakat dengan beberapa cara, termasuk dengan bertindak sebagai komunikator, motivator, fasilitator, dan konselor. Untuk membantu pasien mereka mencapai tujuan mereka, yaitu tanpa rasa khawatir untuk melahirkan. Diharapkan peran penyedia layanan kesehatan yang memberikan informasi, dorongan, dan konseling yang bermanfaat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mereka.

3) Olahraga selama kehamilan (yoga prenatal)

Yuniza dkk., (2021) menemukan bahwa yoga prenatal, yang mudah dilakukan di rumah dapat membantu ibu hamil menurunkan tingkat kecemasan mereka dengan pendekatan komplementer (non-farmakologis). Sejumlah aktivitas dapat membantu ibu hamil merasa lebih aman dan tenang, dan yoga prenatal adalah salah satunya. Penekanan pada pola pernapasan dan penekanan latihan pada keamanan dan kenyamanan membuat yoga prenatal menjadi pilihan yang sangat baik untuk ibu hamil. Cara terbaik untuk bersantai dan melepas penat pada trimester ketiga adalah dengan berlatih yoga prenatal, sebuah aktivitas yang bermanfaat bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional ibu.

C. Dampak Persalinan terhadap Status Kesehatan Mental Perempuan

a. Persalinan dan Kesehatan Mental

Salah satu pengalaman yang paling monumental dan mengubah hidup setiap wanita di planet ini adalah melahirkan. Penelitian psikologis tentang sifat alamiah manusia mengungkapkan bahwa, sebagai wanita kita cenderung menganggap kemampuan kita untuk beranak pinak sebagai tanda kesempurnaan kita. Melahirkan adalah peristiwa yang luar biasa yang dapat menandai babak baru yang menyenangkan dalam hidup seseorang. Melahirkan sering dikatakan sebagai salah satu pengalaman yang paling menantang dalam hidup. Kesehatan mental dan tingkat perkembangan psikologis seorang wanita adalah dua faktor yang dapat mempengaruhi cara dia menjalani persalinan.

Setiap wanita yang sedang hamil hidup di bawah bayang-bayang keyakinan bahwa persalinan itu mengerikan. Wanita hamil yang akan melahirkan mungkin mengalami peningkatan iritabilitas, kemarahan, melamun, dan kegelisahan karena sistem saraf simpatik, yang mencakup sistem saraf endokrin (Lail, 2019).

b. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan masalah kesehatan mental pada masa persalinan

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan masalah kesehatan mental selama persalinan meliputi (Kurniarum, 2016):

- 1) Kekhawatiran
- 2) Gelisah
- 3) Takut akan kematian
- 4) Trauma akan kelahiran
- 5) Stress
- 6) Perasaan bersalah
- 7) Konflik batin
- 8) Kecemasan
- 9) Sedih sekaligus bahagia

c. Penyebab kecemasan pada persalinan

Penyebab kecemasan pada persalinan yaitu (Kurniarum, 2016):

- 1) Nyeri

Meskipun sebagian besar wanita merasakan rasa sakit saat melahirkan, namun cara setiap wanita menghadapi rasa sakit tersebut sangat bervariasi. Rahim tidak bisa mendapatkan oksigen yang cukup karena stres melepaskan katekolamin, yang pada gilirannya membatasi aliran darah ke rahim.

- 2) Keadaan fisik

Kehamilan dan persalinan merupakan proses fisiologis, tetapi juga dapat menimbulkan komplikasi psikologis, yang dapat membuat tingkat kecemasan seorang ibu hamil meningkat.

- 3) Riwayat pemeriksaan kehamilan

Bidan, dokter kandungan, dan dokter keluarga dapat memeriksa ibu hamil. Selama kunjungan prenatal, para ibu akan menerima lebih dari sekadar pemeriksaan fisik; mereka juga akan belajar tentang perawatan prenatal yang tepat, bagaimana mempersiapkan mental dan fisik untuk melahirkan, dan apa yang diharapkan selama proses persalinan yang sebenarnya. Karena itu, ibu hamil dikatakan memiliki lebih banyak keyakinan diri dan kesiapan untuk proses persalinan. Oleh karena itu, ibu hamil harus sering mengunjungi penyedia layanan kesehatan untuk memantau perkembangannya.

- 4) Pengetahuan

Kecemasan lebih mungkin menyerang orang yang kurang informasi. Kecemasan dapat muncul ketika seseorang tidak memiliki informasi tentang hal-hal yang mereka anggap sebagai tekanan, yang kemudian dapat meningkat menjadi krisis. Ibu yang tidak berpengalaman dalam persalinan dan persalinan mungkin menderita kecemasan karena kurangnya pemahaman tentang apa yang mungkin mereka harapkan dan apa yang harus mereka alami selama proses tersebut. Data yang dikumpulkan tidak mencukupi, yang merupakan alasan untuk hal ini.

5) Dukungan lingkungan sosial

Salah satu bentuk dukungan sosial adalah ketika seorang suami mendampingi istrinya saat melahirkan. Secara psikologis, dukungan sosial dilihat dari berbagai segi. Para suami, khususnya, harus mendampingi istri mereka saat melahirkan. Hal ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti mendampingi istri sesaat sebelum persalinan atau dengan menyentuh tangan istri dengan lembut untuk membantunya rileks.

6) Pendidikan

Ketika bereaksi terhadap rangsangan internal dan eksternal, tingkat pendidikan seseorang berpengaruh. Tanggapan seseorang yang berpendidikan akan lebih masuk akal daripada orang yang kurang berpendidikan atau tidak berpendidikan.

d. Perubahan emosi pada persalinan (intranatal)

Pada sebagian besar ibu, persalinan akan disambut dengan beragam respon emosi (Wahyuni, 2018) :

- 1) Antusiasme yang sangat tinggi dan keinginan untuk menyampaikan kekhawatiran tentang apa yang dapat terjadi.
- 2) Keengganan terhadap alat-alat medis, prosedur, perawatan, administrasi, dan rumah sakit.
- 3) Kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan akan rasa sakit dan kemampuan untuk mempertahankan kontrol diri saat melahirkan.
- 4) Kekhawatiran akan kesehatan bayi dan kemampuan pasangan untuk menangani situasi tersebut.
- 5) Ketakutan seorang ibu untuk melahirkan dan institusi medis yang akan dikunjunginya. Intensitas emosi ini dapat meningkat jika ibu mengalami kesulitan saat melahirkan, seperti pendarahan hebat atau masalah lainnya.
- 6) Banyak orang mengalami perasaan malu dan kehilangan privasi karena informasi pribadi mereka menjadi pengetahuan umum saat melahirkan.

e. Masalah atau dampak kesehatan mental yang terjadi pada persalinan

Berikut adalah beberapa contoh masalah kesehatan mental yang mungkin terdeteksi saat bayi dilahirkan. Kondisi-kondisi ini dapat muncul sebelum, selama, atau setelah proses persalinan (Lail, 2019):

1) Kecemasan

Banyak orang mengalami kecemasan pada hari-hari menjelang hari persalinan. Sebagian besar wanita mengalami kegugupan dan kecemasan selama masa kehamilan mereka, terutama bagi mereka yang sedang mengandung anak pertama. Hal-hal yang dianggapnya berbahaya terus berputar-putar dalam pikirannya. Kesehatan mental ibu pasti akan memburuk jika tidak mampu mengendalikan kecemasannya secara efektif. Memiliki dukungan dari orang-orang terdekat (pasangan dan keluarga) sangat penting jika ingin menaklukkan rasa cemas. Kecemasan dapat dikurangi secara efektif dengan cara ini. Karena, bagaimanapun juga, ibu hamil sering terpapar dengan materi yang meningkatkan kecemasan mereka, akan lebih bermanfaat untuk mendengarkan pengalaman yang menenangkan.

2) Ketakutan

Kecemasan dan ketakutan adalah emosi yang berbeda. Kekhawatiran tentang sesuatu yang belum ada atau yang tidak mudah terlihat dikenal sebagai kecemasan. Ketakutan, di sisi lain, ditandai dengan kecemasan tentang objek yang dapat diidentifikasi. Seorang wanita dapat mengembangkan rasa takut yang tidak rasional untuk melahirkan saat dalam proses persalinan. Sang ibu mengkhawatirkan keselamatan janin yang dikandungnya. Atau, rasa sakit yang tak tertahankan yang hadir selama persalinan. Seorang wanita harus ditenangkan sebelum dapat menaklukkan rasa takutnya. Akan lebih bijaksana jika mendengarkan keluhannya. Rasa takutnya tidak akan hilang jika menasihatinya untuk berhenti merasa takut atau bersikap merendahnya.

3) Sikap pasif

Ketika seorang wanita hamil ragu-ragu untuk melahirkan, hal ini disebut pasif. Lemahnya dukungan dari lingkungan sekitar juga menjadi faktor pendorong dalam hal ini. Jika pasangan dan keluarga tidak memperhatikan wanita hamil, ibu akan menjadi pasif. Untuk itu, kita harus berada di sisinya. Dengan menghujaninya dengan cinta dan perhatian, kita dapat membantunya mengatasi sikap pasifnya. Ingatlah bahwa hal ini akan berdampak langsung pada seberapa mudah persalinannya.

4) Hipermaskulin

Istilah "pasif" menggambarkan keengganan wanita hamil untuk melahirkan. Tidak adanya dorongan dari lingkungan sekitar juga berperan. Wanita hamil akan rileks dan berhenti menuntut perhatian dari orang yang

dicintainya jika mereka mengabaikannya. Untuk melakukannya, Anda harus menemaninya. Untuk mengatasi sikap tidak berperasaan ini, kita dapat memberikan bantuan praktis. Seorang wanita hamil mungkin merasa hipermaskulin, yang berhubungan dengan keraguan untuk memiliki anak. Sang ibu, tanpa diragukan lagi, mendekati akhir persalinannya. Karena itu, kestabilan emosinya menurun. Wanita yang bekerja lebih mungkin mengalami hal ini. Ia mengalami gejolak emosi karena keinginan yang saling bertentangan untuk terus melakukan berbagai hal dengan cara keibuan dan memiliki anak sendiri. Hal ini dapat disebabkan, sebagian, oleh fakta bahwa banyak wanita yang menderita masalah kesehatan mental ketika mencoba untuk hamil. Menyediakan sistem pendukung yang kuat adalah salah satu cara untuk mengatasi hal ini. Dengarkan kekhawatirannya dan berkolaborasi dengannya untuk menemukan solusi bagi sistemnya, yang akan muncul sebagai perhatian dan kasih sayang yang ia dapatkan. Lakukan hal yang benar. Ingatlah bahwa hal ini secara langsung berdampak pada seberapa mudahnya pekerjaan itu dilakukan.

5) Hiperaktif

Keinginan seorang ibu untuk memulai persalinan dengan cara apa pun dapat membuatnya menjadi hiperaktif pada hari-hari menjelang hari besar. Akibatnya, sang ibu meningkatkan tingkat aktivitasnya untuk memastikan persalinan yang cepat. Pendekatan yang dapat membantu meringankan masalah ini adalah dengan mengedukasi ibu hamil tentang apa yang diharapkan selama persalinan. Wanita juga dapat memperoleh manfaat dari perawatan psikologis untuk membantu mereka mempersiapkan diri.

6) Kompleks maskulin

Contoh hiperaktif yang tidak terkendali adalah gangguan kompleks maskulin. Agresivitas seorang wanita meningkat saat melahirkan. Urgensi yang ia gunakan untuk melakukan pekerjaannya menunjukkan keinginannya untuk tidak membuang-buang waktu. Sikapnya mulai memberikan kekuatan yang lebih besar pada orang lain di sekitarnya. Cara terbaik bagi staf medis untuk membantu seorang wanita mengatasi gangguan psikologis selama persalinan adalah dengan memiliki pasangan di sisinya.

7) Halusinasi hipnagonik

Kontraksi yang dirasakan seorang wanita hamil adalah bagian yang tak terelakkan dari proses persalinan. Kontraksi ini melewati masa istirahat. Bahkan, seorang ibu bisa saja mengalami tidur semu. Halusinasi hipnagonik terwujud di sini. Berkembangnya masalah psikosomatis akan menyebabkan ibu

merasa cemas. Kita dapat menyiasatinya dengan tetap berhubungan dengan ibu pada hari-hari menjelang kelahiran.

8) *Sindrom baby blues*

Hal ini sering terjadi setelah prosedur persalinan. Seorang ibu dapat menolak anaknya jika ibu mengalami kesulitan untuk berhubungan dengannya. Untuk mencegah kondisi ini, kita dapat memberikan bantuan dalam bentuk motivasi dan persiapan untuk peristiwa yang mengubah hidup menjadi seorang ibu.

f. Cara mengatasi gangguan kecemasan dan psikologis saat persalinan

- 1) Bidan yang penuh kasih sayang terhadap ibu bersalin memainkan peran penting dalam mengatasi kekhawatiran mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Wanita yang akan melahirkan tidak perlu panik dengan penjelasan yang baik tentang proses persalinan.
- 2) Ketika seorang wanita dalam proses persalinan, memiliki keluarga dan teman di sekitar yang akrab dengan proses persalinan merupakan kenyamanan yang luar biasa, baik secara fisik maupun emosional.

g. Dukungan yang dapat diberikan bidan untuk mengurangi tingkat kecemasan saat persalinan

1) Pemberian sugesti

Tujuan menawarkan alternatif yang masuk akal adalah untuk mempengaruhi pendapat ibu. Ini adalah rekomendasi konstruktif yang akan mendorong ibu untuk memiliki persalinan yang sehat. Psikologi sosial individu menyatakan bahwa mereka yang kesehatan mentalnya genting lebih rentan terhadap bujukan dan sugesti. Satu hal yang membesarkan hati yang dapat disampaikan oleh bidan kepada ibu bersalin adalah bahwa semuanya akan baik-baik saja dan prosedurnya akan berjalan sesuai rencana. Yakinkan ibu bahwa semuanya akan baik-baik saja dengan mengatakan hal ini berulang kali. Untuk menjaga antusiasme ibu selama proses persalinan, bidan harus selalu memberikan pernyataan yang membesarkan hati. Kunci untuk membuat rekomendasi ini adalah ungkapan yang jelas dan ringkas. Diharapkan bidan mempertahankan sikap yang menyenangkan setiap saat, yang bertujuan untuk memuaskan ibu dan suami atau keluarganya.

2) Mengalihkan perhatian

Mengalihkan pikiran ibu dari ketidaknyamanan yang dialami selama proses persalinan akan membantu meringankan penderitaan tersebut. Dari sudut pandang psikologis, penderitaan ibu justru akan semakin meningkat jika bidan terpaku pada hal tersebut melalui empati dan kasih sayang yang berlebihan.

D. Latihan

Soal Pilihan Ganda

1. Kecemasan dalam kehamilan sangat sering terjadi, dimana banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kecemasan tersebut, kecuali....
 - A. Usia ibu yang masih muda
 - B. Rendahnya status ekonomi
 - C. Kurangnya pengetahuan
 - D. Kurangnya dukungan keluarga
 - E. Tingginya pendidikan ibu
2. Salah satu bentuk dukungan suami yang dapat menurunkan kejadian kecemasan dalam kehamilan kecuali....
 - A. Suami ikut membantu pekerjaan rumah
 - B. Suami mendengarkan keluhan ibu
 - C. Mengantarkan ibu melakukan pemeriksaan kehamilan
 - D. Membiarkan ibu sendiri saat marah
 - E. Membantu memijat ibu saat kelelahan
3. Di bawah ini yang merupakan contoh dukungan tenaga kesehatan yang dapat menurunkan kecemasan ibu saat hamil dengan terapi komplementer yaitu??
 - A. Memberikan konseling kehamilan
 - B. Memberikan terapi obat
 - C. Memberikan motivasi kepada ibu
 - D. Melakukan pemeriksaan kehamilan
 - E. Mengajarkan prenatal yoga
4. Berikut yang merupakan penyebab kecemasan dalam menghadapi persalinan kecuali....
 - A. Rasa nyeri saat melahirkan
 - B. Pemeriksaan ANC teratur
 - C. Pengetahuan yang kurang
 - D. Kurangnya dukungan keluarga
 - E. Adanya penyakit penyerta saat hamil
5. Keadaan saat seorang calon ibu merasa goyah keinginannya antara ingin punya anak atau tidak, padahal sudah berada di saat-saat menjelang persalinan merupakan gangguan kesehatan mental yaitu...?
 - A. Kecemasan
 - B. Sikap pasif
 - C. Hipermaskulin
 - D. Hiperaktif
 - E. Halusinasi hipnagpnik

Soal Isian

1. Apa yang dimaksud dengan kesehatan mental?
2. Sebutkan penyebab kecemasan yang terjadi saat kehamilan!
3. Apa dampak yang ditimbulkan jika seorang ibu hamil mengalami masalah kesehatan mental?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi kecemasan saat proses persalinan?
5. Bagaimana penanganan kecemasan pada ibu yang sedang dalam proses persalinan?

Kunci Jawaban

1. E
2. D
3. E
4. B
5. C

E. Rangkuman Materi

Kesehatan mental merupakan kondisi individu yang terbebas dari segala bentuk gejala gangguan mental. Jika seseorang tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit mental, kami mengatakan bahwa mereka sehat secara mental. Orang yang memiliki mental yang sehat mampu mengatasi stres dengan cara yang sehat, yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas sehari-hari secara teratur dan menyesuaikan diri dengan situasi baru. Ada banyak perubahan nyata yang terjadi pada fisik wanita selama kehamilan. Perubahan dalam pikiran dan jiwa sama pentingnya dengan perubahan dalam tubuh. Kecemasan kehamilan adalah respons emosional yang normal bagi wanita hamil karena mereka mengkhawatirkan kesehatan mereka sendiri dan janin mereka selama masa kehamilan, persalinan, saat-saat setelah kelahiran, dan transisi menjadi orang tua. Jika seorang wanita mengalami kecemasan selama kehamilannya, hal ini dapat memengaruhi kemampuannya untuk melahirkan, kesehatan mentalnya setelah melahirkan, dan kesehatan bayi secara keseluruhan. Jika kecemasan seorang ibu tidak diobati, ia akan meningkatkan peluangnya untuk mengalami depresi pascamelahirkan, yang pada gilirannya berdampak pada kesehatan dan perkembangan bayinya. Usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan paritas adalah beberapa faktor yang memengaruhi kecemasan ibu hamil. Pemahaman ibu, kesehatan mental, kondisi ekonomi, dukungan keluarga dan teman, dan yang paling penting adalah dukungan suami, semuanya berperan dalam kecemasan ibu hamil. Kecemasan selama kehamilan dapat diatasi dengan berbagai cara, termasuk dengan bantuan pasangan dan penyedia layanan kesehatan, serta dengan olahraga sederhana, seperti yoga

prenatal. Bayi siap keluar dari rahim ke dunia ketika jalan lahir dipersiapkan selama persalinan. Persalinan normal atau operasi caesar biasanya merupakan metode yang cukup untuk menyelesaikan prosedur ini. Kecemasan selama persalinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketakutan ibu akan rasa sakit, kondisi fisiknya, kurangnya pemeriksaan prenatal, kurangnya informasi, tidak adanya dukungan sosial dan lingkungan, dan kurangnya pendidikan. Adapun beberapa gangguan kesehatan mental yang bisa kita identifikasi pada saat persalinan yang bisa terjadi sebelum persalinan, saat persalinan dan setelah persalinan adalah kecemasan, ketakutan, sikap pasif, hipermaskulin, hiperaktif, kompleks maskulin, halusinasi hipnagonik serta *sindrom baby blues*. Selama persalinan, bidan dapat membantu meringankan kecemasan ibu dengan memberikan ide-ide positif dan pengalih perhatian untuk membantunya fokus pada prosedur daripada rasa sakit.

F. Glosarium

Halusinasi hipnagonik : persepsi nyata (seperti melihat, mendengar, atau merasakan hal yang tidak ada) yang terjadi saat seseorang baru akan tertidur, yaitu dalam periode transisi antara kondisi terjaga dan tidur lelap.

Hiperaktif : keadaan ibu hamil yang beraktivitas sebanyak mungkin agar cepat melahirkan

Hipermaskulin : keadaan calon ibu yang merasa goyah keinginannya antara ingin atau tidak punya anak

Kompleks maskulin : situasi di mana seseorang, terutama perempuan selama masa persalinan, menunjukkan perilaku hiperaktif, agresif, dan terlalu mengatur, yang dikaitkan dengan gangguan psikologis dan tidak tertangani secara positif

Paritas : jumlah anak

Postpartum : masa setelah melahirkan

Sindrom baby blues : kondisi perubahan emosi yang umum dialami ibu setelah melahirkan, ditandai dengan perasaan sedih, cemas, mudah tersinggung, dan kelelahan tanpa alasan jelas, serta munculnya suasana hati yang labil

G. Referensi

Agisna, R., Jauhari, Z. A., Zuar, M. S., Sholihin, M., & Khusnul, A. (2023). Evaluasi pembelajaran. *Social Science Academic*, 1(2), 353–362.

Alini, A., Meisyalla, L. N., & Novrika, B. (2024). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kesehatan Mental Ibu Hamil di Desa Pulau Rambai. *Jurnal Ners Universitas Pahlawan*, 8(1), 178–186.

Ans Efi Irawati, A. (2020). *Korelasi Dukungan Keluarga Dengan Kecemasan Ibu Hamil*

Sebelum Operasi Sectio Caesarea di RSUD Karanganyar. Universitas Kusuma Husada Surakarta.

- Arikalang, F., Wagey, F. M. M., & Tendean, H. M. M. (2023). Gambaran Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Primigravida dan Multigravida dalam Menghadapi Persalinan di Indonesia. *E-CliniC*, 11(3), 283–292.
- Arinda, Y. D., & Herdayati, M. (2021). Masalah kesehatan mental pada wanita hamil selama pandemi COVID-19. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 6(1), 32–41.
- Asghari, A., Farhadi, M., Kamrava, S. K., Ghalehbaghi, B., & Nojomi, M. (2012). *Subjective sleep quality in urban population.*
- Astria, Y., Nurbaeti, I., & Rosidati, C. (2019). Hubungan Karakteristik Ibu Hamil Trimester III dengan Kecemasan dalam Menghadapi Persalinan di Poliklinik Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit X Jakarta. *Majalah Keperawatan UNPAD*, 10(19), 38–48.
- BKKBN. (2021). Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Dan Keluarga Berencana. *Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.*
- Campillo, I. S. L., Meaney, S., McNamara, K., & O'Donoghue, K. (2017). Psychological and support interventions to reduce levels of stress, anxiety or depression on women's subsequent pregnancy with a history of miscarriage: an empty systematic review. *BMJ Open*, 7(9), e017802.
- Deo, B. K., Sapkota, N., Kumar, R., Shakya, D. R., Thakur, A., & Lama, S. (2020). A study on pregnancy, perceived stress and depression. *Journal of BP Koirala Institute of Health Sciences*, 3(1), 79–87.
- Elsera, C., Risti, P., Rusminingsih, E., & Rochana, A. (2022). Kecemasan Berat Masa Kehamilan. *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 5.
- Elvina, L., ZA, R. N., & Rosdiana, E. (2018). Faktor Yang Berhubungan dengan Kesiapan Psikologis Ibu Hamil Trimester III dalam Menghadapi Persalinan. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 4(2), 176–184.
- Fakhriyani, D. V. (2019). Kesehatan Mental (PDF). *Pamekasan: Duta Media Publishing. Hlm, 4.*
- Febriati, L. D., & Zakiyah, Z. (2022). Hubungan dukungan keluarga dengan adaptasi perubahan psikologi pada ibu hamil. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 13(1).
- Franks, W. L. M., Crozier, K. E., & Penhale, B. L. M. (2017). Women's mental health during pregnancy: A participatory qualitative study. *Women and Birth*, 30(4), e179–e187.
- Handayani, R. (2015). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Kecemasan Menjelang Persalinan Pada Ibu Primigravida Trimester III di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya Padang Tahun 2012: Factors Associated with Anxiety Level Toward Childbirth in Primigravida Trimester III Mothers in the Work Area

Lubuk Buaya Padang Health Center in 2012. *Ners Jurnal Keperawatan*, 11(1), 60–69.

Hawari, D. (2016). Manajemen Stress, Cemas, Depresi. *Jakarta: FKUI*.

Ismawati, R. (2017). *Gambaran Perilaku Eksternal Dan Internal Ibu Nifas Primipara Dan Multipara Dalam Pencegahan Infeksi Luka Perineum Di Rs Roemani Muhammadiyah Semarang*. Universitas Muhammadiyah Semarang.

Kaya, F., & Akdoğan, İ. Y. (2022). The Examination of Psychological Well-Being in Pregnant Women in Terms of Demographic and Pregnancy-Related Features and Self-Compassion. *Journal of Education & Research in Nursing/Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi*, 19(1), 85–92.

Kemenkes RI. (2022). *Kesehatan Mental pada Ibu Hamil dan Pasca Melahirkan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kemkes, R. I. (2019). Perlu Kepedulian untuk Kendalikan Masalah Kesehatan Jiwa. Retrieved from Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: <https://www.depkes.go.id/article/view/19030400005/Perlu-Kepedulian-Untuk-Kendalikan-Masalah-Kesehatan-Jiwa>. Html.

Kurniarum. (2016). *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kusuma, R. (2019). Karakteristik ibu Yang mengalami depresi dalam kehamilan. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 8(1), 99–106.

Lail, N. H. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Hipertensi Dalam Kehamilan Di Puskesmas Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi Tahun 2015. *Ilmu Dan Budaya*, 41(62).

Liu, J., Hung, P., Alberg, A. J., Hair, N. L., Whitaker, K. M., Simon, J., & Taylor, S. K. (2021). Mental health among pregnant women with COVID-19-related stressors and worries in the United States. *Birth*, 48(4), 470–479.

Montagnoli, C., Zanconato, G., Cinelli, G., Tozzi, A. E., Bovo, C., Bortolus, R., & Ruggeri, S. (2020). Maternal mental health and reproductive outcomes: a scoping review of the current literature. *Archives of Gynecology and Obstetrics*, 302(4), 801–819.

Norhayati, M. N., Hazlina, N. H. N., Asrenee, A. R., & Emilin, W. M. A. W. (2015). Magnitude and risk factors for postpartum symptoms: a literature review. *Journal of Affective Disorders*, 175, 34–52.

Notosoedirdjo, M. (2014). *Latipun, Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan*. Malang: UMM Press.

Novelia, S., Rukmaini, R., & Umayah, U. (2022). Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil dan Dukungan Suami dengan Kecemasan Ibu Hamil dalam menghadapi Persalinan. *Journal for Quality in Women's Health*, 5(1), 90–98.

- Putri, A. W., Wibhawa, B., & Gutama, A. S. (2015). Kesehatan mental masyarakat Indonesia (pengetahuan, dan keterbukaan masyarakat terhadap gangguan kesehatan mental). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 252–258.
- Ria, M. B., Budihastuti, U. R., & Sudiyanto, A. (2018). Risk factors of postpartum depression at Dr. Moewardi Hospital, Surakarta. *Journal of Maternal and Child Health*, 3(1), 81–90.
- Rusdiana, R. (2022). Hubungan Dukungan Suami Dengan Kecemasan Ibu Hamil Trimester Iii Menghadapi Proses Persalinan Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Praktik Mandiri Bidan Sf Martapura Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Kesehatan Insan Sehat*, 10(2), 130–134.
- Rusli, R. A., Meiyuntariningsih, T., & Warni, W. E. (2012). Perbedaan depresi pasca melahirkan pada ibu primipara ditinjau dari usia ibu hamil. *Jurnal Insan Media Psikologi*, 13(1).
- Rwakarema, M., Premji, S. S., Nyanza, E. C., Riziki, P., & Palacios-Derflingher, L. (2015). Antenatal depression is associated with pregnancy-related anxiety, partner relations, and wealth in women in Northern Tanzania: a cross-sectional study. *BMC Women's Health*, 15(1), 68.
- Saifuddin, A. (2022). *Psikologi Umum Dasar*. Prenada Media.
- Sari, I. W., & Afifah, V. A. (2022). Pengaruh Konseling Keluarga Terhadap Kecemasan Ibu Hamil Trimester Iii Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Keperawatan*, 15(1), 8.
- Setiawan, S. A., & Nurfaiza, L. (2021). Hubungan Paritas Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Menghadapi Persalinan Normal. *Oksitosin: Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 8(2), 128–135.
- Shahid, A., Malik, N. I., Shahid, F., Ullah, I., & Abbass, Z. (2022). Psychosocial predictors of mental health among pregnant women. *Perspectives in Psychiatric Care*, 58(3), 1071–1076.
- Siallagan, D., & Lestari, D. (2018). Tingkat Kecemasan Menghadapi Persalinan Berdasarkan Status Kesehatan, Graviditas dan Usia di Wilayah Kerja Puskesmas Jombang. *Indonesian Journal of Midwifery (IJM)*, 1(2).
- Sudirman, S., Puspitawati, H., & Muflikhati, I. (2019). Peran suami dalam menentukan kesejahteraan subjektif istri pada saat hamil dan melahirkan. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 12(1), 26–37.
- Sunarmi, A., Haksari, E. L., & Fitriahadi, E. (2022). Childbirth counseling by WhatsApp group to reduce the anxiety of primigravida. *International Journal of Health & Medical Sciences*, 5(3), 193–200.
- Syam, A., & Aminah, S. (2019). Hubungan Antara Faktor Sosiodemografi Dengan Potensi Kejadian Depresi Maternal Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Pampang Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, 14(2), 199–203.

- Tang, X., Lu, Z., Hu, D., & Zhong, X. (2019). Influencing factors for prenatal stress, anxiety and depression in early pregnancy among women in Chongqing, China. *Journal of Affective Disorders*, 253, 292–302.
- Val, A., & Míguez, M. C. (2023). Prevalence of antenatal anxiety in European women: a literature review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(2), 1098.
- Veit, C. T., & Ware, J. E. (1983). The structure of psychological distress and well-being in general populations. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 51(5), 730.
- Wahyu Agustini, N. L. P. (2018). *Asuhan Kebidanan Pada Ibu "An" Umur 34 Tahun Multigravida Dari Umur Kehamilan 37 Minggu 1 Hari Sampai 42 Hari Masa Nifas*. Jurusan Kebidanan 2018.
- Wahyuni, E. D., & Wahyuni, E. D. (2018). *Asuhan kebidanan nifas dan menyusui*. Pusdik SDM Kesehatan.
- Wahyuningsih, S., & Mamnu'ah, M. (2015). *Hubungan faktor keturunan dengan kejadian gangguan jiwa di desa Banaran Galur Kulon Progo Yogyakarta*. STIKES'Aisyiyah Yogyakarta.
- WHO. (2023). *Anxiety Disorders*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders>
- Wulandari, A., & Rohmah, M. (2019). Hubungan Motivasi Suami dan Tenaga Kesehatan dengan Kunjungan Ante Natal Care (ANC) pada Ibu Hamil di BPM Ny. H. Pakisaji Kabupaten Malang. *Journal for Quality in Women's Health*, 2(1), 57–64.
- Yuniza, Y., Tasya, T., & Suzanna, S. (2021). Pengaruh Prenatal Yoga Terhadap Kecemasan Pada Ibu Hamil Trimester Iii Di Kecamatan Plaju. *Jurnal Keperawatan Sriwijaya*, 8(2), 78–84.

BAB 4

DETEKSI DINI GANGGUAN PSIKOLOGI PADA PERSALINAN

Pendahuluan

Pada bab ini berisikan materi tentang deteksi dini gangguan psikologi yang akan terjadi pada ibu bersalin. Buku ini dapat membantu pembaca mempelajari dan mengenali tanda-tanda masalah kesehatan mental pada ibu baru pada tahap awal.

Buku ini disusun dan disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah psikologi kehamilan, persalinan dan nifas. Berisi materi, latihan soal beserta jawaban sehingga pembaca bisa berlatih pada setiap bab nya. Buku ini juga sudah disesuaikan dengan peraturan terbaru yang berkaitan dengan kebidanan.

Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Intruksional:

- a. Menjelaskan Penyebab gangguan psikologi pada ibu bersalin
- b. Menjelaskan Masalah-masalah psikologi pada ibu bersalin
- c. Memaparkan Deteksi dini gangguan psikologi pada persalinan

Capaian Pembelajaran :

- a. Mampu memahami penyebab gangguan psikologi pada persalinan
- b. Mampu memahami masalah-masalah psikologi pada persalinan
- c. Mampu memahami deteksi dini gangguan psikologi pada persalinan

Uraian Materi

Mahasiswi kebidanan dan para pembaca selamat bertemu pada bab 9, buku psikologi kehamilan, persalinan dan nifas, dengan materi deteksi dini gangguan psikologi persalinan, dengan sub pokok bahasan penyebab gangguan psikologi pada persalinan, masalah-masalah psikologi pada persalinan, saat mengidentifikasi masalah kesehatan mental selama persalinan dan melahirkan pada tahap awal. Masalah kesehatan mental selama kehamilan dan diagnosis dini mereka adalah upaya untuk mengenali dan menemukan gejala-gejala awal masalah kesehatan jiwa yang dapat muncul selama proses kehamilan dan persalinan, seperti kecemasan, ketakutan akan kematian, trauma persalinan, atau depresi, sehingga intervensi dini dapat dilakukan untuk membantu ibu. Tujuannya adalah untuk mengurangi penderitaan ibu dan memastikan pengalaman persalinan yang lebih aman dan positif.

A. Penyebab gangguan psikologi pada ibu bersalin

Gangguan psikologi pada ibu bersalin disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Faktor biologis meliputi penurunan drastis hormon setelah melahirkan dan riwayat depresi/psikiatri sebelumnya. Faktor psikologis meliputi kelelahan fisik dan mental, kurang tidur, serta kecemasan akibat proses persalinan atau perubahan hidup. Faktor sosial meliputi kurangnya dukungan dari keluarga/pasangan, masalah keuangan, isolasi sosial, dan riwayat kekerasan.

Faktor Biologis

- **Perubahan Hormon:**
Kadar estrogen dan progesteron ibu menurun drastis setelah melahirkan. Perubahan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi dan perubahan suasana hati yang ekstrem.
- **Riwayat Kesehatan Mental:**
Depresi pascapersalinan lebih umum terjadi pada ibu yang memiliki riwayat depresi atau memiliki kerabat yang mengalami depresi.

Faktor Psikologis

- **Kelelahan dan Kurang Tidur:**
Perawatan bayi yang baru lahir dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental, serta kurang tidur, yang memengaruhi suasana hati.
- **Stres Persalinan:**
Pengalaman nyeri persalinan dan stres selama proses melahirkan juga dapat berkontribusi pada munculnya gangguan psikologis.

- **Perubahan Pola Hidup:**
Perubahan drastis dalam pola hidup untuk merawat bayi bisa memicu perasaan cemas atau kesulitan membangun ikatan emosional dengan bayi.

Faktor Sosial dan Lingkungan

- **Kurangnya Dukungan Sosial:**
Dukungan yang kurang dari pasangan, keluarga, dan lingkungan sosial dapat meningkatkan risiko gangguan mental.
- **Masalah Keuangan:**
Kesulitan ekonomi dapat menjadi sumber stres yang berkontribusi pada kondisi psikologis ibu.
- **Isolasi Sosial:**
Ibu yang terisolasi secara sosial dan tidak memiliki dukungan dari teman atau keluarga dekat lebih rentan mengalami depresi.
- **Masalah Hubungan:**
Masalah dalam perkawinan atau hubungan yang penuh kekerasan juga merupakan faktor risiko.
- **Kehamilan Tidak Direncanakan:**
Kehamilan yang tidak direncanakan dapat meningkatkan risiko gangguan mental.

B. Masalah-masalah psikologi pada ibu bersalin

1. Masalah Psikologis Pada Ibu Bersalin Kala I

Selain kontraksi rahim, ibu biasanya tenang, rileks, dan tidak terlalu pucat selama tahap pertama persalinan. Selama tahap pertama persalinan, wanita umumnya mengalami kondisi psikologis berikut :

- a. Kekhawatiran dan ketakutan akan membuat lebih banyak kesalahan atau pelanggaran. Kecemasan irasional ini muncul dalam bentuk takhayul dan kekhawatiran bahwa bayi akan lahir abnormal.
- b. Kecemasan, rasa sakit, stres, ketakutan, dan pertikaian internal. Janin yang sedang tumbuh di dalam rahim menjadi penyebabnya, juga penyebab seringnya ibu merasa lelah, tidak nyaman, dan insomnia, serta seringnya kesulitan bernapas dan masalah kesehatan lainnya.
- c. Sensasi marah, tidak nyaman, panas yang terus-menerus, dan ketidaksabaran sering mengganggu kedamaian antara ibu dan janin. Hal ini terjadi ketika rahim berkontraksi dan kepala bayi menyembul ke panggul.
- d. Kekhawatiran akan potensi tantangan dan bahaya selama persalinan dan

melahirkan :

- 1) Timbulnya perasaan cemas secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas
 - 2) Menunjukkan nyeri dada, kesulitan bernapas, atau sensasi tercekik
 - 3) Takut mati atau merasa tidak berdaya saat melahirkan
 - 4) Kulit pucat, ekspresi irasional, napas pendek dan cepat, serta jantung berdebar kencang
- e. Antisipasi tentang jenis kelamin bayi baru lahir. Karena hal ini, muncul emosi-emosi yang saling bertentangan:
- 1) Hasrat akan cinta romantis
 - 2) Kecenderungan antagonis dan kekerasan
- f. Sikap bermusuhan terhadap bayinya
- 1) Preferensi terhadap janin yang inferior
 - 2) Merasa terbebani oleh tanggung jawab menjadi ibu
 - 3) Kekhawatiran bahwa bayi yang belum lahir mungkin berada dalam bahaya saat ia lahir
- g. Kegelisahan dan ketakutan menjelang kelahiran bayi
- 1) Takut akan kematian
 - 2) Pengalaman buruk selama persalinan
 - 3) Rasa bersalah
 - 4) Ketakutan yang nyata
2. Perubahan Psikologis Ibu Bersalin Kala II
- Sementara beberapa calon ibu merasakan euforia dan kebanggaan atas kelahiran bayi mereka, yang lain mengalami teror. Perubahan mental ini terjadi:
1. Peristiwa yang sama sekali tidak terduga dan menakutkan terjadi setelah serviks membuka sepenuhnya.
 2. Ketidakpastian atas proses yang terjadi ketika serviks membuka sepenuhnya.
 3. Perasaan marah dan frustrasi.
 4. Sama sekali tidak tertarik pada apa pun atau semua orang yang hadir di ruang bersalin.
 5. Kesulitan untuk tetap terjaga dan mengikuti arahan.
 6. Memusatkan perhatian pada diri sendiri

C. Deteksi dini gangguan psikologi pada persalinan

Deteksi dini gangguan psikologi pada persalinan adalah upaya untuk mengenali dan menemukan gejala-gejala awal masalah kesehatan jiwa yang dapat muncul selama proses kehamilan dan persalinan, seperti kecemasan, ketakutan akan kematian, trauma persalinan, atau depresi, sehingga intervensi dini dapat dilakukan untuk membantu ibu. Tujuannya adalah untuk mengurangi penderitaan ibu dan memastikan pengalaman persalinan yang lebih aman dan positif.

Manfaat Deteksi Dini:

1. Mencegah Masalah Lebih Lanjut:
Masalah yang lebih parah, seperti depresi pascapersalinan, mungkin muncul dari gejala awal yang tidak diobati.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Ibu:
Dengan deteksi dini, ibu dapat menerima dukungan yang dibutuhkan untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan, sehingga meningkatkan pengalaman persalinan.
3. Mendukung Adaptasi Psikologis:
Bantu ibu beradaptasi dengan perubahan mental dan fisiologis yang terjadi selama dan setelah kehamilan.

Gangguan psikologis dapat dicegah atau dideteksi secara dini dengan cara:

1. Ikuti jadwal perawatan prenatal.
2. Tekankan pentingnya keluarga, terutama suami dan orang tua, serta keterlibatan mereka.
3. Adakan sesi konseling dan bicarakan dengan ibu tentang masalahnya.
4. Memastikan ibu mendapatkan informasi yang memadai dan dirawat dengan baik selama kehamilan dan persalinan sehingga ia tidak memiliki rasa takut atau curiga terhadap proses persalinan.
5. Pemantauan rutin oleh bidan selama kehamilan dan persalinan memungkinkannya untuk segera mengatasi atau meminimalkan masalah apa pun, memastikan persalinan yang aman bagi ibu dan bayi yang sehat

Siapa yang Melakukan Deteksi Dini?

1. Tenaga Kesehatan:
Bidan dan tenaga kesehatan lainnya berperan penting dalam melakukan komunikasi terapeutik, memberikan dukungan mental, dan mengidentifikasi tanda-tanda awal gangguan psikologis.
2. Keluarga dan Pasangan:

Dukungan dari keluarga dan pasangan juga sangat krusial untuk membuat ibu merasa lebih aman dan nyaman selama proses persalinan.

D. Latihan

Petunjuk soal: pilihlah salah satu jawaban dibawah ini yang paling benar.

1. Gangguang psikologi pada ibu bersalin disebabkan oleh beberapa faktor dibawah ini, kecuali:
 - a. Faktor biologi
 - b. Faktor kelelahan
 - c. Faktor hormon laktasi
 - d. Faktor sosial dan lingkungan
 - e. Faktor hormon estrogen
2. Masalah-masalah psikologi yang sering terjadi pada ibu bersalin kala I adalah
 - a. Takut mati atau merasa tidak dapattertolong saat melahirkan
 - b. Adanya harapan-harapan mengenai jenis kelamin
 - c. Sikap bermusuhan terhadap bayinya
 - d. Impuls bermusuhan dan kebencian
 - e. Kegelisahan dan takut menjelang kehamilan
3. Dibawah ini adalah deteksi dini gangguan psikologi pada ibu bersalin, kecuali
 - a. Melakukan pemeriksaan berkala selama kehamilan
 - b. Melakukan konseling dan temu wicara bila ibu mengalami masalah atau keluhan
 - c. Membawa ke psikiater untuk mendeteksi gangguan pada ibu
 - d. Memberikan asuhan dan pengetahuan pada ibu tentang persalinan
 - e. Dilakukan pemantauan berkala bila ditemukan adanya gangguan selama masa kehamilan dan persalinan
4. Sebagian ibu merasa bahagia pada saat bersalin, tapi sebagian lagi ada ibu yang mengalami masalah psikologi pada ibu bersalin kala II, dibawah ini adalah masalah atau tanda-tanda gangguan psikologi persalinan kala II , kecuali:
 - a. Panik dan terkejut dengan apa yang terjadi pada saat pembukaan lengkap
 - b. Timbul rasa lelah dan mau mengikuti perintah
 - c. Rasa lelah dan sulit mengikuti perintah
 - d. Frustasi dan marah
 - e. Tidak perduli apa dan siapa yang ada dikamar bersalin

5. Deteksi dini gangguan psikologi pada ibu bersalin sangat diperlukan karna penting untuk mencegah terjadinya gangguan psikologi tersebut, dibawah ini manfaat kita melakukan deteksi dini gangguan psikologi persalinan, kecuali:
- a. Mencegah masalah lebih lanjut
 - b. Meningkatkan kesejahteraan ibu
 - c. Mendukung adaptasi psikologi
 - d. Memberikan terapi bila gejala sudah berlanjut
 - e. Mengatasi gangguan lebih serius

Kunci Jawaban

1. C
2. E
3. C
4. B
5. D

E. Rangkuman Materi

Proses persalinan pada dasarnya merupakan suatu hal fisiologis yang dialami oleh setiap ibu bersalin, sekaligus merupakan suatu hal yang menakutkan bagi ibu dan keluarga. Namun, rasa khawatir, takut maupun cemas akan muncul pada saat memasuki proses persalinan. Perasaan takut dapat meningkatkan respon fisiologis dan psikologis, seperti: nyeri, otot-otot menjadi tegang dan ibu menjadi cepat lelah, yang pada akhirnya akan menghambat proses persalinan.

Bidan sebagai pemberi asuhan dan pendamping persalinan diharapkan dapat mendeteksi gangguan psikologi pada ibu bersalin, dengan memberikan bimbingan dan dukungan selama masa kehamilan dan saat proses persalinan berlangsung.

F. Referensi

- Dr. Kartini Kartono, 2007. Psikologi Wanita 2. Bandung. Sumber Sari Indah.
- Hastanti, Heni, Budiono Budiono, dan Nining Febriyana (2021). "Primigravida Memiliki Kecemasan Yang Lebih Saat Kehamilan". Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal: 67-178.
- Herawati M, (2011). Psikologi Ibu Anak untuk kebidanan, Jakarta, Salemba Medika
- Herri Zan Pieter, dkk. 2011. Pengantar Psikologi Untuk Kebidanan. Jakarta.

Kencana.

Modul Psikologi, {2022}. Kehamilan, Persalinan dan Nifas. Program studi Kebidanan Program Sarjana Stikes Yarsi Mataram.

Nurul husnul lail, (2019). Buku Asuhan Kebidanan Komprehensif. Jakarta selatan, LPU-UNAS

Prawirohardjo, S. (2002). Ilmu Kebidanan. Jakarta: YBPSP

Usnidar & israini suryati, (2020). Buku Ajar Psikologi Kebidanan, Palopo, LPPIUMP
Departemen Kesehatan RI. (2012). Asuhan Persalinan Normal Manuaba, IBG

BAB 5

DETEKSI DINI GANGGUAN PSIKOLOGI PADA NIFAS

Pendahuluan

Mahasiswa bidan dan para pembaca, sekarang kita sudah masuk Bab 10 yang berisikan materi tentang deteksi dini gangguan psikologi nifas yang terdiri dari penyebab gangguan psikologi pada ibu nifas, masalah-masalah psikologi pada ibu nifas.

Seperti pada Bab sebelumnya, di bab ini juga ada latihan soal untuk membantu mahasiswa dan pembaca mengevaluasi pemahaman dari materi yang sudah dipelajari.

Selamat belajar, semoga menjadi bidan yang handal!

Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Intruksional:

- a. Menjelaskan Penyebab gangguan psikologi nifas
- b. Menjelaskan Masalah-masalah psikologi nifas
- c. Memaparkan Deteksi dini gangguan psikologi nifas

Capaian Pembelajaran :

- a. Mampu memahami penyebab gangguan psikologi nifas
- b. Mampu memahami masalah-masalah psikologi nifas
- c. Mampu memahami deteksi dini gangguan psikologi nifas

Uraian Materi

Uraian materi dalam buku ajar ini adalah deskripsi atau penjelasan tentang topik deteksi dini gangguan psikologi pada nifas, materi ini mencakup penyebab gangguan psikologi pada nifas, masalah atau gangguan psikologi pada ibu nifas serta deteksi dini gangguan psikologi pada nifas. Dengan tujuan agar pembaca memahami dan menguasai materi yang diberikan.

Deteksi dini gangguan psikologi pada masa nifas adalah proses mengenali tanda-tanda awal masalah kejiwaan seperti baby blues syndrome, depresi pascamelahirkan, dan psikosis pascamelahirkan pada ibu setelah melahirkan, untuk memungkinkan penanganan yang cepat dan mencegah kondisi yang lebih serius berkembang. Proses ini penting karena gangguan mental dapat memengaruhi kesejahteraan ibu, bayi, dan keluarga, dan sering kali dipicu oleh perubahan biologis dan psikologis pascapersalinan.

A. Penyebab Gangguan Psikologi Nifas

Penyebab gangguan psikologi pada ibu nifas adalah kombinasi faktor hormonal, seperti penurunan drastis estrogen dan progesteron, yang menyebabkan perubahan kimia otak dan suasana hati; fisik dan kelelahan, termasuk kurang tidur dan perubahan metabolisme tubuh; serta faktor psikososial, seperti kurangnya dukungan dari pasangan atau keluarga, masalah keuangan, isolasi sosial, riwayat depresi sebelumnya, dan stresor lingkungan atau trauma persalinan.

Faktor Biologis dan Hormonal

1. Perubahan Hormonal:

Penurunan tajam hormon estrogen dan progesteron setelah melahirkan memengaruhi sistem neurotransmitter yang mengatur suasana hati, menyebabkan perubahan kimia di otak dan memicu gangguan mood.

2. Faktor Biologis Lain:

Perubahan hormon tiroid juga dapat berperan dalam perubahan suasana hati pascapersalinan.

3. Faktor Fisik dan Kelelahan

a. Kelelahan:

Ibu nifas sering mengalami kelelahan fisik dan mental akibat merawat bayi baru lahir, yang dapat memperburuk suasana hati dan membuat sulit beradaptasi.

b. Kurang Tidur:

Kekurangan tidur yang terus-menerus membuat ibu merasa kewalahan dan kesulitan menangani masalah sehari-hari, sehingga meningkatkan risiko gangguan psikologis.

c. Faktor Psikososial dan Lingkungan

1) Dukungan Sosial:

Kurangnya dukungan dari suami, keluarga, teman, atau masyarakat dapat meningkatkan risiko depresi pascapersalinan.

2) Stres dan Tekanan:

Kehamilan yang penuh tekanan atau masalah dalam hubungan perkawinan dapat memicu atau memperburuk kondisi psikologis ibu.

3) Masalah Keuangan:

Impitan ekonomi atau keuangan menjadi stresor psikososial yang dapat berkontribusi pada gangguan mental.

4) Riwayat Gangguan Mental:

Depresi pascapersalinan lebih umum terjadi pada ibu yang memiliki riwayat masalah kesehatan mental, seperti depresi atau gangguan bipolar.

5) Masalah Citra Diri:

Ibu mungkin merasa tidak percaya diri dengan perannya, kurang menarik, atau merasa kehilangan kendali atas hidup, yang dapat memicu perasaan depresi.

6) Perubahan Peran dan Identitas:

Menjadi ibu baru seringkali menyebabkan kecemasan dan ketidakpercayaan diri dalam merawat bayi, serta kesulitan beradaptasi dengan identitas baru.

B. Masalah-masalah Psikologi Pada Nifas

Masalah psikologi pada ibu nifas mencakup Postpartum Blues (Baby Blues), Depresi Pascapersalinan, dan Psikosis Pascapersalinan. Postpartum blues adalah perasaan sedih dan cemas yang ringan dan sementara, sedangkan depresi pasca persalinan adalah kondisi yang lebih berat dan berlangsung lebih lama, ditandai dengan kesedihan mendalam dan kehilangan minat. Psikosis pascapersalinan adalah kondisi mental serius yang membutuhkan penanganan segera, ditandai dengan halusinasi dan delusi.

1. *Postpartum Blues/Baby Blues*

Postpartum blues sering disebut juga *maternity blues* atau *baby syndrome*, yaitu episode depresi sementara yang disebabkan oleh

peningkatan reaktivitas emosional yang memengaruhi 50% wanita. Kondisi ini sering dimulai dalam seminggu atau beberapa hari setelah melahirkan dan biasanya memburuk pada hari ketiga dan keempat (Suririnah, 2008). Merasa sedih selama tiga hingga enam hari setelah melahirkan merupakan gejala umum depresi pascapersalinan. Istilah "postpartum blues" telah didefinisikan dalam berbagai cara, tetapi secara umum, istilah ini menggambarkan suasana hati yang buruk yang dirasakan banyak ibu baru selama tiga hingga enam hari setelah melahirkan, terutama jika perasaan tersebut berkaitan dengan bayi mereka.

Pengenalan Segera: Baby blues dapat diidentifikasi dari berbagai gejala, seperti perubahan suasana hati, tangisan, kecemasan, kesepian, kekhawatiran terhadap bayi, kesulitan menyesuaikan diri, sensitivitas, penurunan rasa lapar, gangguan tidur, penurunan gairah seks, dan kurangnya kepercayaan diri sebagai seorang ibu. Kondisi ini biasanya terjadi saat ibu berada di bangsal bersalin atau rumah sakit, meskipun mungkin masih terasa bahkan setelah ia tiba di rumah. Ibu primipara mengalami baby blues yang lebih intens dibandingkan dengan ibu multipara. Meskipun baby blues biasanya hilang dengan sendirinya, seorang ibu harus dievaluasi untuk depresi pascapersalinan jika gejalanya tidak membaik atau tetap sama setelah beberapa waktu.

2. Gangguan alam perasaan mayor pascapartum (Depresi Pasca Persalinan)

Perasaan duka yang luar biasa akibat berkurangnya kebebasan, otonomi, keterlibatan sosial, dan kemandirian seorang ibu merupakan ciri khas depresi pascapersalinan, yang juga dikenal sebagai depresi berat. Perbedaan utama antara penyakit mental ini dan penyakit mental lainnya adalah tingkat keparahannya, lamanya gejala berlangsung, dan seberapa sering gejala tersebut muncul.

Masalah tidur, perubahan nafsu makan, kelelahan, energi rendah, perasaan bersalah atau tidak berharga, kesulitan berkonsentrasi, dan pikiran untuk bunuh diri adalah beberapa gejala yang lebih umum, intens, dan berlangsung lama yang dialami oleh wanita dengan depresi. Membentuk ikatan dengan bayi mereka selama tahun pertama kehidupan dapat menjadi tantangan bagi mereka jika kondisi ini berlanjut hingga lebih dari tiga hingga enam bulan pertama.

3. Psikosis pasca persalinan (Postpartum Kejiwaan)

Agitasi yang ekstrem, perubahan suasana hati yang cepat, keputusasaan, dan delusi adalah gejala psikosis pascapersalinan, penyakit

mental berat yang memengaruhi wanita setelah melahirkan. Perawatan psikiatrik dan perhatian medis segera diperlukan bagi perempuan yang menderita psikosis pascapersalinan (Nirwana, 2011). Pada sebagian besar kasus, psikosis pascapersalinan berkaitan dengan gangguan bipolar; namun, psikosis ini juga bisa menjadi gejala depresi berat. Sebagian besar kasus psikosis pascapersalinan terjadi dalam tiga bulan pertama setelah melahirkan, dengan frekuensi 1-2 per 1.000 ibu baru. Jenis gangguan mental pascapersalinan yang paling parah adalah psikosis pascapersalinan. Waktu onsetnya adalah dua hingga empat minggu setelah melahirkan.

C. Deteksi Dini Gangguan Psikologi Nifas

Deteksi dini gangguan psikologi pada ibu nifas dilakukan melalui skrining berkala oleh tenaga kesehatan, pemeriksaan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, serta penggunaan alat bantu seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) untuk mengidentifikasi gejala depresi postpartum dan gangguan mental lainnya secara lebih akurat. Selain itu, penting juga untuk melakukan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai potensi gangguan mental yang dapat terjadi, agar mereka lebih waspada dan dapat mencari bantuan secara dini jika ada gejala yang muncul.

1. Kapan Deteksi Dini Dilakukan?

Skrining Terjadwal: Skrining kesehatan jiwa idealnya dilakukan secara berkala, termasuk saat pelayanan nifas ketiga yaitu pada 8-28 hari setelah persalinan.

a. Metode Deteksi Dini:

- 1) Pemeriksaan di Fasilitas Kesehatan: Ibu dapat melakukan skrining kesehatan jiwa di puskesmas.
- 2) Menggunakan Kuesioner/Skala: Alat seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) digunakan untuk mendeteksi gejala depresi postpartum secara dini.
- 3) Observasi Tanda-tanda Gejala: Tenaga kesehatan dan keluarga harus peka terhadap gejala-gejala gangguan psikologis yang mungkin muncul pada ibu nifas, seperti:
 - Perasaan sedih atau putus asa yang tidak tertahankan.
 - Perubahan drastis dalam suasana hati.
 - Kesulitan tidur.
 - Kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai.
 - Kesulitan merawat bayi.

b. Pentingnya Deteksi Dini:

1) Mencegah Kondisi yang Lebih Berat:

Gangguan mental pada masa nifas, seperti depresi postpartum, bisa berkembang menjadi lebih serius jika tidak ditangani dengan tepat.

2) Meningkatkan Kesejahteraan:

Deteksi dini membantu mencegah dampak negatif pada ibu, bayi, dan seluruh keluarga.

3) Mempercepat Pemulihan:

Intervensi yang cepat melalui deteksi dini dapat mempercepat proses pemulihan ibu.

c. Peran Keluarga:

- 1) Keluarga memiliki peran penting dalam upaya deteksi dini dengan memberdayakan diri untuk mengenali dan memberikan dukungan awal kepada ibu.

D. Latihan

1. Penyebab gangguan psikologi pada ibu nifas terdiri dari beberapa factor, salah satu diantaranya disebabkan factor hormonal sehingga :
 - a. mengalami kelelahan fisik dan mental akibat merawat bayi baru lahir, yang dapat memperburuk suasana hati dan membuat sulit beradaptasi.
 - b. ibu merasa kewalahan dan kesulitan tidur
 - c. memengaruhi sistem neurotransmitter yang mengatur suasana hati, menyebabkan perubahan kimia di otak dan memicu gangguan mood
 - d. tekanan atau masalah dalam hubungan perkawinan dapat memicu atau memperburuk kondisi psikologis ibu
 - e. Impitan ekonomi atau keuangan menjadi stresor psikososial yang dapat berkontribusi pada gangguan mental
2. Setelah melahirkan ibu akan mengalami rasa Bahagia melihat bayi nya, tapi ada beberapa ibu yang mengalami masa yang tidak menyenangkan pada saat nifas, terjadi gangguan psikologi pada masa nifas, apa saja gangguan psikologi pada masa nifas tersebut, kecuali:
 - a. Postpartum Blues
 - b. Baby Blues
 - c. Depresi Pascapersalinan,
 - d. Skizofrenia
 - e. Psikosis Pascapersalinan
3. Apa saja deteksi dini /Identifikasi gejala-gejala dari ibu yang mengalami *Baby blues*, kecuali :

- a. ibu mengalami perubahan perasaan, menangis, cemas, kesepian,
 - b. khawatir mengenai bayinya, tidak mampu beradaptasi,
 - c. tenang, bahagia dalam merawat bayi
 - d. sensitif, tidak nafsu makan
 - e. kurang percaya diri terhadap kemampuan menjadi seorang ibu.
4. Gangguan alam perasaan mayor pascaprtum atau depresi pasca melahirkan ini biasa disebut depresi berat yang terjadi bila ibu nifas, apa saja deteksi dini yang perlu kita perhatikan agar gangguan ini tidak terjadi
- a. gejala gangguan tidur, gangguan nafsu makan, keadaan ini berlangsung 1 bulan
 - b. kehilangan tenaga, perasaan tidak berharga atau perasaan bersalah,
 - c. kehilangan konsentrasi, dan pikiran tentang bunuh diri.
 - d. Gejala gangguan berlangsung antara 3-6 bulan bahkan pada beberapa kasus terjadi selama 1 tahun pertama kehidupan bayi,
 - e. Ibu tidak bisa menjalin hubungan kedekatan dengan bayinya.
5. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur atau mendeteksi gejala depresi postpartum secara dini Adalah
- a. Skala Depresi Geriatri (Geriatric Depression Scale/GDS)
 - b. Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)
 - c. Children's Depression Inventory (CDI)
 - d. Skala Diferensial Semantik
 - e. Skala Guttman

Kunci Jawaban

- 1. C
- 2. D
- 3. C
- 4. A
- 5. B

E. Rangkuman Materi

Pasca melahirkan adalah hal yang penting, karena ibu akan berada pada masa transisi dari perubahan fisik maupun psikologis. Pada masa transisi, ibu membutuhkan penyesuaian dan selama masa penyesuaian ibu rentan terkena stress bahkan depresi. Tidak jarang mereka mengalami perasaan sedih selama beberapa hari pertama atau minggu ke depan. Disini tubuh dan emosi mereka menyesuaikan diri dengan keadaan baru.

Deteksi dini gangguan psikologi pada ibu nifas dilakukan melalui skrining berkala oleh tenaga kesehatan, pemeriksaan di fasilitas kesehatan serta Skrining Terjadwa, Skrining kesehatan jiwa idealnya dilakukan secara berkala, termasuk saat pelayanan nifas ketiga yaitu pada 8-28 hari setelah persalinan.

F. Glosarium

EPDS : Edinburgh Postnatal Depression Scale

GDS : Geriatric Depression Scale

CDI : Children's Depression Inventory

G. Referensi

Dr. Kartini Kartono, 2007. Psikologi Wanita 2. Bandung. Sumber Sari Indah.

Hastanti, Heni, Budiono Budiono, dan Nining Febriyana (2021). "Primigravida Memiliki Kecemasan Yang Lebih Saat Kehamilan". Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal: 67-178.

Herawati M, (2011). Psikologi Ibu Anak untuk kebidanan, Jakarta, Salemba Medika

Herri Zan Pieter, dkk. 2011. Pengantar Psikologi Untuk Kebidanan. Jakarta. Kencana.

Modul Psikologi, {2022}. Kehamilan, Persalinan dan Nifas. Program studi Kebidanan Program Sarjana Stikes Yarsi Mataram.

Nurul husnul lail, (2019). Buku Asuhan Kebidanan Komprehensif. Jakarta selatan, LPU-UNAS

Prawirohardjo, S. (2002). Ilmu Kebidanan. Jakarta: YBPSP

Usnidar & israini suryati, (2020). Buku Ajar Psikologi Kebidanan, Palopo, LPPIUMP Departemen Kesehatan RI. (2012). Asuhan Persalinan Normal Manuaba, IBG

BAB 6

SIBLING RIVALRY DAN TANGGUNG JAWAB BIDAN MEMBERIKAN DUKUNGAN TERHADAP KESEHATAN PEREMPUAN

Tujuan Instruksional:

1. Menjelaskan konsep Sibling Rivalry
2. Menjelaskan Penyebab Sibling Rivalry
3. Menjelaskan faktor Sibling Rivalry
4. Menjelaskan Aspek Sibling Rivalry
5. Menjelaskan Dampak Sibling Rivalry
6. Menjelaskan Kategori Sibling Rivalry
7. Menjelaskan Cara Mengatasi Sibling Rivalry
8. Menjelaskan Tanggung Jawab Bidan Memberikan Dukungan Terhadap Kesehatan Mental Perempuan

Capaian Pembelajaran:

CPL	Mampu Menjelaskan dan Menjabarkan Terkait Apa itu Sibling Rivalry dan Peran Bidan Dalam memberikan Dukungan Terhadap Kesehatan Mental Perempuan
CPMK	Mahasiswa memiliki pengetahuan terkait Sibling Rivalry, Memiliki keterampilan mendeteksi gejala sibling Rivalry dan rencana intervensi serta memiliki sikap empati ,komunikatif dan profesional dalam memberikan edukasi kepada orang tua.
Sub-CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sibling rivalry
Sub-CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan apa saja penyebab sibling rivalry
Sub-CPMK 3	Mahasiswa mampu menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi sibling rivalry
Sub-CPMK 4	Mahasiswa dapat menjelaskan aspek apa saja terkait sibling rivalry

Sub-CPMK 5	Mahasiswa mampu menjelaskan apa saja dampak dari sibling Rivalry
Sub-CPMK 6	Mahasiswa mampu menjelaskan apa saja jenis atau kategori sibling Rivalry
Sub-CPMK 7	Mahasiswa Mampu atau Mengetahui cara mengatasi Sibling Rivalry
Sub-CPMK 8	Mahasiswa Mengetahui dan Mampu Menjelaskan Tanggung Jawab Bidan Memberikan Dukungan Terhadap Kesehatan Mental Perempuan

Pendahuluan:

Buku ini berjudul Sibling Rivalry dan Tanggung Jawab Bidan Dalam Memberikan Dukungan Terhadap Kesehatan Mental Perempuan, Buku ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang persiapan sibling untuk orang tua dan apa yang menjadi tugas sebagai seorang bidan dalam memberikan dukungan terhadap kesehatan mental perempuan. Buku ini boleh di baca oleh siapa saja terutama mahasiswa kesehatan. Buku ini berisikan tentang Sibling Rivalry mulai dari pengertian sampai cara mengatasinya serta tanggung jawab bidan dalam memberikan dukungan terhadap kesehatan mental perempuan. Untuk metode pembelajaran pada buku ini bisa dengan metode ceramah, Diskusi, tanya jawab, demonstrasi, simulasi dan studi kasus.

Uraian Materi

1. Konsep Sibling Rivalry
2. Penyebab Sibling Rivalry
3. Faktor Sibling Rivalry
4. Aspek Sibling Rivalry
5. Dampak Sibling Rivalry
6. Kategori Sibling Rivalry
7. Cara Mengatasi Sibling Rivalry
8. Tanggung Jawab Bidan Memberikan Dukungan Terhadap Kesehatan Mental Perempuan

A. Sibling Rivalry

1. Pengertian Sibling Rivalry

Sibling Rivalry sering diartikan sebagai kompetisi antara saudara kandung untuk mendapatkan kasih sayang, cinta serta perhatian dari orang tua. Atau untuk mendapatkan pengakuan dan mengharapkan sesuatu yang lebih dari kedua orang tuanya.

Sibling Rivalry juga diartikan sebagai bentuk persaingan, pertengkaran, kecemburuan yang timbul karena adanya penambahan anggota baru dalam keluarga dan biasanya sering terjadi pada anak jarak dekat. Terkadang sibling ini tidak diperhatikan, padahal bisa menimbulkan beberapa efek atau akibat baik bagi kakak ataupun adiknya.

Sibling Rivalry juga dianggap sebagai perilaku antagonis yang ditandai dengan persaingan, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara saudara kandung. Yang bisa memunculkan reaksi negatif. Bisa juga diartikan sebagai permusuhan dan kecemburuan yang terjadi antara saudara kandung.

2. Penyebab Sibling Rivalry

- a. Anak akan memiliki rasa bersaing antara saudara
- b. Anak akan merasa kurang mendapatkan perhatian, kurang disiplin dan tidak mau mendengarkan perkataan orang tua
- c. Merasa tidak nyaman, ada perasaan terancamnya hubungan dengan orang tua
- d. Bisa mempengaruhi proses kedewasaan anak
- e. Seringkali memicu pertengkaran antara anak
- f. Anggota keluarga tidak memiliki waktu bermain bersama anak
- g. Orang tua mungkin yang tidak adil dalam memperlakukan anak

3. Faktor Sibling Rivalry

a. Peran Orang Tua

Peran orang tua memiliki faktor yang cukup dominan dalam menyebabkan sibling rivalry, orang tua yang memiliki sifat yang tidak adil kepada anaknya serta waktu yang kurang bersama anak menjadi penyebab terjadinya sibling rivalry. Kadangkala ini menyebabkan rasa tidak nyaman dan bertengkar antara anak atau antara saudara kandung.

b. Urutan kelahiran

Kakak seringkali yang mengalami sibling rivalry, ini di karenakan rasa iri terhadap adik yang baru di lahirkan dan merasa tidak di perhatikan lagi semenjak ada penambahan anggota baru dalam keluarga. Orang tua terutama ibu mungkin memang lebih cenderung lebih banyak waktu bersama adik ketimbang kakaknya karena memang adiknya lebih banyak yang di urus ketimbang adik. Namun hal ini yang bisa meimbulkan rasa iri dan cemburu kakak terhadap adiknya, kakak juga merasa lebih berkuasa dan lebih kuat daripada adiknya.

c. Jenis Kelamin

Jenis kelamin juga memiliki peranan penting dari proses sibling itu sendiri, seperti anak perempuan, jika keduanya di lahirkan dengan jarak yang cukup dekat dan berjenis kelamin sama secara otomatis bisa meningkatkan reaksi sibling itu sendiri. Mereka memiliki kebutuhan yang sama. Jika adik lebih memiliki banyak barang ketimbang kakaknya, maka disinilah muncul rasa iri kepada adiknya sehingga kakak menjadi cemburu dan muncul lah pertengkar antara saudara tersebut.

d. Usia

Sibling rivalry cenderung terjadi pada anak jarak dekat dan muncul dan terjadi biasanya pada anak usia 1-3 tahun. Hal ini sering muncul ketika orang tua belum mempersiapkan kakak untuk penambahan anggota keluarga baru dalam keluarga.

e. Watak anak

Sifat anak tentunya juga menjadi penyebab sibling rivalry terjadi. Anak yang mudah tersinggung, sensitif serta mudah emosi akan mudah marah terhadap saudaranya dan orang di sekitar yang membanding bandingkan.

f. Jumlah saudara

Jumlah anak yang sedikit cenderung menjadi pemicu terjadinya reaksi sibling . jumlah anak yang sedikit cenderung membuat perselisihan dan pertengkar antara anak lebih sering terjadi. Hal ini terjadi karena ketika

jumlah anak atau saudara sedikit maka akan semakin terlihat perbedaan antara masing-masing anak sehingga memicu rasa iri antara anak atau saudara.

g. Sikap anak

Sikap anak yang cenderung suka mencari perhatian orang tua dan orang sekitar akan bisa memancing emosi dan membuat saudaranya merasa tersingkir sehingga dia melakukan berbagai cara supaya dia mendapatkan perhatian yang sama dan ini bisa membuat perselisihan atau konflik terjadi antara anak.

h. Pola Asuh orang tua

Pola asuh demokratis menjadi rekomendasi pola asuh yang harus diterapkan orangtua kepada anak. Anak tidak boleh di biarkan saja ketika terjadi konflik dan orang tua tidak boleh juga memihak kepada salah satunya. Ketika terjadi konflik antara anak, orang tua seharusnya mencari titik masalah dan mencari solusi yang tepat supaya kedepannya tidak terjadi lagi.

i. Pengaruh dari luar

Prilaku sibling rivalry juga bisa muncul karena pengaruh dari pihak luar, seperti pengasuh, nenek atau teman sebaya. Sebagai contoh anak yang diasuh oleh nenek mungkin cenderung di manja sehingga dia merasa lebih berkuasa ketimbang adiknya. Sehingga ketika bersama orang tua dia merasa lebih berhak atau berkuasa untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tuanya.

B. Aspek Sibling Rivalry

1. Konflik

Konflik sering terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contohnya adalah perilaku memprotes, menolak serta melawan. Terjadi biasanya antara dua individu atau lebih

2. Cemburu

Karena anak sangat tergantung dengan orang tua, baik itu perhatian, kasih sayang serta kebutuhan lainnya. Anak akan cenderung muncul rasa iri dan cemburu ketika ada penambahan anggota keluarga baru dan dituntut juga ketika orang tua tidak bisa memberikan keseimbangan antara kakak dan adik barunya. Di sini lah mulai muncul rasa iri dan cemburu sehingga memunculkan perilaku sibling rivalry.

3. Kekesalan

Hal ini sering muncul karena adanya rasa tidak nyaman dengan orang tua yang lebih memberikan perhatian kepada adiknya yang baru, dan

ketidakberdayaan anak dalam memberikan prlawanan kepada orang tua sehingga di lampiaskan kepada adiknya.

4. Kompetisi

Rasa ingin mendapatkan kasih sayang lebih dari orang tua cenderung menimbulkan rasa kompetisi antara anak. Mereka berlomba-lomba bagaimana caranya anak bisa memenangkannya.

5. Komunikasi

Komunikasi yang baik ataupun interaksi yang baik antara orang tua dan anak akan mengurangi reaksi sibling rivalry antara saudara.

6. Motivasi

Ini cenderung terjadi karena adanya dorongan dan keinginan anak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua.

C. Dampak Sibling Rivalry

1. Dampak Positif

- a. Anak cenderung lebih memahami perbedaan sehingga dia bisa mengontrol emosi dan menimbulkan keterampilan penting
- b. Mengajarkan anak untuk bernegosiasi
- c. Mengajarkan anak supaya bisa mengontrol emosi

2. Dampak Negatif

- a. Menimbulkan efek negatif seperti memukul bahkan mencederai saudara sendiri
- b. Mendorong bahkan mencakar saudara sendiri
- c. Pada anak tertua atau kakak cenderung menganggap saudara sebagai lawan
- d. Terjadinya kemunduran perilaku seperti anak tidak mau makan sendiri, anak tidak mau mandi sendiri serta perilaku lainnya yang tadinya bisa menjadi tidak bisa hanya untuk merebut perhatian dari orang tuanya.
- e. Membuat anak merasa tidak memiliki harga diri karena seringkali setiap ada pertengkaan yang di salahkan adalah kakaknya.
- f. Hal ini bisa membuat kakak memiliki dendam kepada adik karena orang tua cenderung lebih membela adik setiap kali ada pertengkar

D. Kategori Sibling Rivalry

1. Rendah

Pada tahapan ini konflik jarang terjadi, hanya terjadi sesekali perselisihan anatar saudara dan bisa di selesaikan serta tidak berlanjut. Hubungan antara orang tua dan anak mengurangi hal tersebut terjadi. Pada tahapan rendah ini

biasanya di tandai dengan konflik yang jarang terjadi, mudah di selesaikan dan tidak ada konflik jangka panjang.

2. Sedang

Di sini konflik cenderung lebih sering dari sebelumnya yang bisa mempengaruhi stress orang tua dan anak. Di sini moment atau hubungan antara saudara bisa lebih tegang tapi masih banyak moment kerja sama. Kadang iri hati dan cemburu lebih jelas.

3. Berat

Pada kategori berat perselisihan yang terjadi cukup intens dan bisa menimbulkan efek jangka panjang terhadap mental dan perkembangan anak kedepannya. Biasanya ini cenderung terjadi pada anak yang mendapatkan perhatian yang kurang dari orang tuanya . pada tahap ini ada perasaan iri, cemburu yang cukup besar pada saudara, sehingga bisa memicu hubungan buruk antara saudara seperti canggung , tegang bahkan rusak. Dan berdampak pada psikis anak-anak.

E. Cara Mengatasi Sibling Rivalry

1. Memperkenalkan secara dini kepada kakak bahwasanya di dalam kandungan ibu ada calon adik atau saudaranya
2. Mengikutsertakan anak pertama di setiap moment yang melibatkan calon adik baru atau calon anggota baru seperti membawa anak untuk pemeriksaan, merasakan gerakan adiknya, belanja perlengkapan untuk adik.
3. Memperluas area bermain anak pertama atau memberikan ruang anak pertama untuk bersosialisasi lebih banyak lagi
4. Orang tua meminta maaf kepada anak pertama jika memang tidak bisa memiliki banyak waktu lagi untuk bermain , mungkin ini disebabkan karena kehamilan ibu cenderung merasa lelah.
5. Pada awal kelahiran bayi, tetaplah perlakukan anak pertama seperti biasanya serta libatkan lah kakak seperti menerima tamu serta rugas ringan lainnya dalam membantu perawatan adik yang baru lahir
6. Jangan membedakan kasih sayang serta ada bandingan antara anak yang satu dengan yang lainnya.
7. Membiarkan anak menjalani hari-hari seperti biasa sesuai kepribadian mereka
8. Memberi apresiasi terhadap bakat dan capaian dari sang kakak
9. Melakukan cara agar anak mau bekerjasama bukan malah memusuhi adeknya
10. Memberikan perhatian seperti biasa kepada anak apalagi mungkin saat konflik terjadi antara anak

11. Mengajarkan anak bagaimana cara mengelola emosi dan bagaimana cara mendapatkan perhatian yang positif dari orang lain
12. Bersikap adil kepada masing-masing anak serta memenuhi kebutuhan anak sesuai tumbuh dan kembangnya.
13. Melakukan banyak kegiatan menyenangkan bersama keluarga
14. Sebagai orang tua juga tidak perlu langsung ikut campur apalagi sampai memarahi kakak, beri teguran dengan baik dan lembut kecuali ada aktifitas fisik yang bisa mencederai adiknya
15. Orang tua harus bisa menempatkan diri, mereka yang memberikan kekuasaan kepada anak sehingga kakak tidak bisa bertindak sesukanya kepada adik
16. Jika terjadi perselisihan atau pertengkaran, orang tua harus mampu jadi penengah. Bukan membela salah satu pihak.
17. Orang tua harus memberikan contoh positif kepada anak, memberikan contoh perilaku sabar dan pengendalian emosi yang baik kepada anak.

F. Tanggung Jawab Bidan Memberikan Dukungan Terhadap Kesehatan Mental Perempuan

Masalah mental ataupun psikologi memang sering muncul pada perempuan ketimbang laki-laki, berdasarkan hasil penelitian perempuan memiliki resiko dua kali lebih besar mengalami stress di bandingkan laki-laki. Hal ini bisa di mulai dari Menstruasi, kehamilan, persalinan, nifas, menopause. Dll nya.

Oleh karena hal tersebut di atas di harapkan bidan mampu mendampingi perempuan dalam masa-masa tersebut supaya tidak mengalami stress dan gangguan mental. Adapun peranan bidan adalah sebagai berikut :

a. Edukasi dan Informasi

Memberikan edukasi kepada ibu, bahwasanya rasa takut dan khawatir di masa kehamilan, persalinan dan nifas merupakan hal yang umum terjadi, namun ibu harus bisa mengelola dengan baik sehingga tidak berdampak luas kedepannya.

b. Konseling

Memberikan ruang kepada ibu untuk bercerita dan berdiskusi terkait ketakutan yang dia rasakan serta memberikan dukungan psikologi kepada ibu sehingga ibu bisa lebih tenang.

c. Deteksi dini dan rujukan

Jika memang ibu mengalami masalah mental yang cukup signifikan, sebaiknya ibu di rujuk ke tenaga yang profesional.

Ada beberapa masalah krusial yang di alami ibu, berikut yang bisa di lakukan oleh bidan :

a. Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD)

Biasanya terjadi ketika akan menstruasi di tandai dengan merasa cemas, mudah marah, cemas, tertekan, mudah tersinggung dan cenderung agak malas untuk beraktifitas seperti biasanya. Kaang juga di sertai dengan kurang nafsu makan dabrn gangguan tidur.

Pada masa ini bidan bisa mulai dengan memberikan edukasi kesehatan reproduksi perempuan, contohnya perawatan pada saat menstruasi termasuk memberikan pendidikan kesehatan terkait bahaya hamil di luar nikah.

Pada masa ini seringkali remaja megalami mod swing atau mood tidak teratur, ada beberapa edukasi yang bisa bidan berikan kepaa remaja, yang anataru lain:

1) Makan Makanan bergizi.

Mengkonsumsi makanan seimbang cenderung bisa memperbaiki mood karena perubahan hormonal

2) Olahraga

Bukan hanya untuk fisik saja, berolahraga juga bisa meringankan stress. Saat melakukan olahraga, akan muncul hormin endorfin yang bisa meringankan gejala stress.

3) Pengaturan Life Style

Pola hidup yang sehat seperti meghindari alkohol dan kafein juga bisa mengurangi stress, cukup istirahat dan hindari aktifitas pemicu stress.

b. Depresi Perinatal (Masa Kehamilan)

Pada masa kehamilan memang sering muncul perasaan cemas, takut, khawatir. Itu merupakan perubahan psikologi yang memang muncul pada kehamilan terutama pada awal dan akhir kehamilan. Seeringkali terjadi perasaan takut seperti aoakah anaknya lahir tidak cacat, apakah dia bisa bersalin normal, apakah dia bisa jadi ibu. Dan masalah ini seringkali di perberat oleh masalah yang lain seperti ekonomi, hubungan yang tidak baik serta kehamikan yang tidak di kehendaki .

Pada masa ini sangat di harapkan peranan bidan untuk mendampingi Ibu, menjelaskan bahwa semuanya adalah hal yang normal, memberikan dukungan psikologis serta menggali psikologi pasien pada masa kehamilan dengan cara melakukan anamnesa dan pendekatan dengan pasien sehingga pasien bisa terbuka dan menceritakan masalahnya. Karena masalah psikologi pada pasien akan menimbulkan masalah lainnya di kemudian hari.

Pada masa ini bidan juga harus memahami perubahan-perubahan fisik maupun psikologi, di sini bidan dapat memberikan layanan sesuai kebutuhan pasien :

- 1) Bersikap baik dan ramah
- 2) Membina hubungan baik dan saling percaya
- 3) Memberi ibu kesempatan bertanya dan memberi jawaban atas pertanyaannya
- 4) Meyakinkan ibu bahwa ibu akan menjalani kehamilan yang sehat
- 5) Memberikan dukungan psikologi dan semangat
- 6) Membantu penyelesaian masalah
- 7) Meyakinkan ibu bahwa bidan akan mendampingi ibu
- 8) Melakukan kelas ibu hamil

c. Depresi post partum

Depresi post partum terjadi pada awal kelahiran dan berlangsung beberapa minggu setelahnya. Kondisi ini akan mempengaruhi perempuan dalam mengasuh anaknya bahkan ada efek negatif sampai ingin bunuh diri. Untuk screening awal bidan bisa menggunakan Edinburgh Post Partum Depressionn Scale (EPDS).

Tugas bidan pada masa ini:

- 1) Mengajarkan teknik menyusui yang tepat
- 2) Memberi dukungan psikologi
- 3) Senam nifas
- 4) Pendidikan kesehatan terkait pola asuh, gizi dan lainnya
- 5) Anjuran istirahat cukup

d. Masa Menopause

Pada masa menopause sering kali juga mengalami perubahan psikologi, berikut yang bisa dilakukan oleh bidan:

1. Mendengarkan apa yang menjadi keluhan ibu dan memberikan solusi atau berempati tanpa menghakimi
2. Memberikan support beserta dukungan moral agar ibu merasa ada yang menemani
3. Membantu ibu membangun citra diri yang positif
4. Jika memang ada tanda gejala stres dan depresi muncul, harus dilakukan deteksi dini supaya tidak berlarut
5. Merujuk ke psikolog atau psikiater jika dibutuhkan.
6. Bidan juga bisa menganjurkan bidan untuk mengatur pola hidup sehat seperti makan bergizi, berolahraga teratur, dan melakukan aktivitas sosial serta berwisata.

7. Bidan bisa menyediakan grup untuk saling sharing pengalaman terkait menopause
8. Bidan juga bisa memberikan edukasi terhadap keluarga untuk memberikan support serta mendampingi ibu

G. Latihan soal

Soal essay :

1. Coba saudara jelaskan secara detail apa yang di maksud dengan sibling rivalry serta apa saja faktor penyebab terjadinya sibling Rivalry ?
2. Jelaskan jelaskan aspek apa saja yang mempengaruhi sibling rivalry?
3. Selain dampak negatif, sibling rivalry juga bisa menimbulkan dampak positif, mohon jelaskan apa saja dampak dari sibling rivalry ?
4. Agar sibling rivalry tiak terjadi, apa saja yang bisa di lakukan oleh orang tua?
5. Jelaskan secara detail apa saja peranan bidan dalam memberikan dukungan terhadap kesehatan mental perempuan?

Soal Objektif :

1. Ayu (4 tahun) tampak sering emosi dan marah sejak kelahiran adiknya lahir. Ia suka menolak makan, beberapa kali membanting mainan dan berteriak marah kepada adiknya.
Apa analisis yang tepat terhadap kasus di atas :
 - A. Rani mengalami fase perkembangan normal
 - B. Rani mengalami gangguan emosi berat
 - C. Rani mengalami sibling rivalry
 - D. Rani ingin belajar mandiri
 - E. Rani tidak menyukai keadaan
2. Raka (8 tahun), suka mengejek adiknya, mengambil mainan adiknya, dan mudah marah kepada adiknya. Orang tua sering membela dan membandingkan raka dengan roni adiknya yang penurut apa yang dikatakan orang tua.
Apa faktor utama sibling pada kasus ini ?
 - A. Perbedaan usia
 - B. Sikap orang tua
 - C. Kurang sosialisasi
 - D. Karena anak pertama lebih egois
 - E. Kurang perhatian
3. Dua kakak adik sering bertengkar karena memperebutkan perhatian ayah mereka yang memang kurang memiliki waktu bersama mereka, di sini ayah cenderung lebih menayangi anak bungsu karena lebih kecil dan butuh perhatian :

- Apa dampak jangka panjang jika situasi ini di biarkan ?
- A. Anak merasa tidak di sayang dan berkembang rasa rendah diri
 - B. Semakin akrab karena berbagi
 - C. Lebih mandiri
 - D. Anak belajar mengalah
 - E. Anak memiliki sosial yang tidak bagus
4. Salah satu tanggung jawab bidan dalam menjaga kesehatan mental perempuan adalah :
- A. Memberikan obat anti depresi tanpa resep dokter
 - B. Mengabaikan keluhan ibu
 - C. Membandingkan kondisi pasien
 - D. Tidak melibatkan keluarga
 - E. Menjadi pendengar aktif dan memberikan edukasi serta konseling
5. Tanggung jawab bidan dalam deteksi dini masalah kesehatan mental perempuan adalah ?
- A. Pemeriksaan laboratorium rutin
 - B. Menyarankan ibu menyimpan perasaan sendiri
 - C. Bero terapi obat
 - D. Mengidentifikasi tanda stres, depresi dan kecemasan pada ibu
 - E. Kunjungan berkala

Kunci Jawaban

Kunci jawaban pilihan ganda :

- 1. C
- 2. B
- 3. A
- 4. E
- 5. D

H. Rangkuman Materi

1. Sibling Rivalry

Sibling rivalry merupakan suatu perilaku yang terjadi karena adanya kecemburuan ataupun iri hati terhadap saudara. Hal ini muncul biasanya kepada anak yang lahir dalam jarak dekat. Sibling Rivalry biasanya terjadi karena beberapa faktor terutama kurangnya perhatian orang tua setelah kelahiran anggota baru dalam keluarga membuat anak kurang mendapatkan perhatian.

Tak hanya menimbulkan dampak negatif yang signifikan, sibling rivalry juga bisa memicu perilaku positif seperti pengontrolan emosi pada anak. untuk dampak

negatif yang paling parah adalah bisa menimbulkan dampak psikologi jangka panjang pada anak jika tidak di tangani dengan baik.

Ada beberapa tahapan Sibling rivalry mulai dari ringan sampai berat, pada tahapan berat bisa menyebabkan dampak jangka panjang pada anak. Di harapkan jika memang sibling sudah masuk ke dalam tahapan berat orang tua harus mencari solusi dan tidak memihak salah satu pihak.

Ada banyak solusi yang bisa di lakukan supaya perilaku sibling rivalry tidak muncul ketika ada penambahan anggota keluarga baru dalam keluarga seperti pengenalan dini pada kakak akan ada penambahan anggota keluarga baru dengan melibatkan kakak dalam kehamilan dan persapan kelahiran.

2. Tanggung Jawab Bidan Dalam Memberikan Dukungan Terhadap Kesehatan Mental Perempuan

Pada masa remaja, kehamilan, persalinan, nifas dan lansia setiap tahapannya selain mengalami perubahan fisik, perempuan juga mengalami perubahan psikologi. Di harapkan dalam hal ini bidan senantiasa melakukan langkah yang tepat supaya ibu tidak mengalami masalah mental yang serius .

Ada beberapa hal yang bisa di lakukan bidan mulai dari memberikan edukasi, pendidikan kesehatan, memberuikan support serta melakukan screening dan rujukan jika di perlukan.

I. Glosarium

1. **Sibling Rivalry** : perilaku yang muncul terhadap saudara kandung seperti kecemburuan,iri hati dan perselisihan.
2. **Antagonis** : karakter ataupun watak buruk seperti pendendam , sering di sebut sebagai tokoh yang jahat
3. **Sensitif** : suatu sifat yang mudah merasakan sesuatu atau peka terhadap sesuatu
4. **Demokratis** : sikap yang mencerminkan kesamaan hak, kebebasan berpendapat serta menghormati
5. **Konflik** : perbedaan atau pertentangan yang terjadi antara dua orang atau lebih
6. **Kompetisi** : satu individu atau kelompok yang memiliki tujuan yang sama dengan bersaing
7. **Intens** : sesuatu yang di lakukan dengan serius dan brsungguh sungguh
8. **Psikis** : mental atau jiwa seseorang
9. **Emosi** : gejala jiwa atau reaksi yang muncul terhadap sesuatu hal
10. **Stress** : kondisi tertekan akibat dari adanya tekanan maupun tuntutan
11. **Edukasi** : proses pemberian informasi yang bertujuan untuk merubah sikap, pengetahuan maupun perilaku

12. **Psikologi**: ilmu yang mempelajari jiwa , prilaku dan fikiran manusia
13. **PMDD**: gangguan yang terjadi sebelum menstruasi seperti gelisah, cemas, tidak mau makan, gangguan tidur
14. **Hormonal**: zat kimia yang di produksi oleh kelenjar endokrin di dalam tubuh untuk mengatur beberapa fungsi
15. **Endorphin**: senyawa kimia alami yang di produksi otak atau hormon kebahagiaan
16. **Life style**: pola hidup seseorang yang merupakan prilaku sehari hari
17. **Depresi post partum** : Depresi yang terjadi setelah persalinan
18. **Epps**: instrumen atau alat untuk melihat gejala depresi
19. **Menopause** : fase alami yang di alami perempuan ketika menstruasi berhenti secara permanen

J. Referensi

-
- Aisyah, S., I. (2013). "Perbedaan tingkat Sibling Rivalry antara Saudara yang Sejenis Kelamin dengan Saudara yang Berbeda Jenis Kelamin". Fakultas Psikologi. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.
- Akhtar, S., Dolan, A., & Barlow, J. (2017). *Understanding the relationship between state forgiveness and psychological wellbeing: A qualitative study. Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, Vol 14,*
- Andriyani, S., & Darmawan, D., (2018) Pengetahuan Ibu tentang Sibling Rivalry pada Anak Usia 5-11 Tahun di Cisarua Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal pendidikan keperawatan indonesia, 4(2),*
- Arif, F. (2013). "Mengatasi Sibling Rivalry dalam Keluarga melalui Konseling Rational Emotive Behavior dengan Teknik Reframing pada Siswa kelas VII di MTs NU Ungaran". Jurusan Bimbingan Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang.
- Arifudin, O, dkk. 2021. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal AUDHI, Vol 15*
- Chaplin, J., P. (2006). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gichara, J. (2006). *Mengatasi Perilaku Buruk Anak*. Jakarta: Kawan Pustaka.
- Gunarsa, S., D & Gunarsa, Y., S., D. (2008). *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
- Hidayah, R. (2009). *Psikologi Pengasuhan Anak*. Malang: UIN Malang Press.
- Hidayati, N., I., (2014) Pola Asuh Otoriter Orang Tua, Kecerdasan Emosi, Dan Kemandirian Anak SD. *Jurnal psikologi Indonesia, 3(1),*

- Idris, M., S. (2018). *Sibling Rivalry dan Penanganannya Studi Kasus pada Salah satu Keluarga di Kota Makassar*. Program Pasca Sarjana Bimbingan dan Konseling. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Irma, Marni Br Karo, Ayu Sri Wahyuni, Evi Zahara, dkk. (2024). *Kesehatan Mental Perempuan*. Penerbit Nuha Medika
- Lestari, S. (2012). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Milevsky, A. (2016). *Sibling Issues in Therapy: Research and Practice with Children, Adolescents and Adults*. USA: Palgrave Macmillan.
- Ningrum, Widya. (2017). *"Hubungan antara Persepsi terhadap Pola Asuh Permisif dengan Sibling Rivalry pada Remaja Akhir"*. Yogyakarta: Universitas Mercu Buana.
- Novairi, A. (2012). *Bila Kakak-Adik Saling Berselisih*. Yogyakarta: Javalitera.
- Pfaffly, C. P. (2015). *Sibling Rivalry*. USA : Magill's Medical Guide.
- Pramushinta, B., D. (2012). *"Hubungan antara Sibling Rivalry dengan Jarak Usia Kelahiran dan Jumlah Saudara Kandung pada Remaja Awal"*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Priatna, C., & Yulia, A. (2006). *Mengatasi Persaingan Saudara Kandung pada Anak-Anak* (1). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Soetjiningsih. (2014). *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Triwijayanti, N., & Sari, L.T. (2014). Pengaruh Jarak Usia Kelahiran dengan Tterjadinya Respon Sibling pada Anak Usia 2-4 Tahun. *Jurnal Ners dan Kebidanan*,
- Woolfson, D.L. (2006). *Persaingan Saudara Kandung: Mendorong Anak-Anak Menjadi Sahabat*. Alih bahasa: Fransiscus Rudijanto. Jakarta: Erlangga
- Yanuari, T., & Rahmasari, D. (2011). Hubungan antara sibling rivalry dengan stres pada anak. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*
- Zolten, K., & Long, N. (Ed.). (2006). Sibling Rivalry among Older Children. Artikel. [Department of Pediatrics : University of Arkansas for Medical Science, USA

PROFIL PENULIS



Hana Nurhanifah Budiadi, SST., M.Tr.Keb Lahir di Bandung, 25 Maret 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV pada Program Studi Diploma IV Kebidanan Pendidik Politeknik Karya Husada Jakarta pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Terapan Kebidanan, STIKes Dharma Husada Bandung tahun 2016. Saat ini penulis bekerja di STIKes Budi Luhur Cimahi mengampu mata kuliah, Dokumentasi Kebidanan dan Asuhan Kebidanan Masa Nifas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hananurhanifah4@gmail.com



Bdn. Ni Nyoman Ayuk Widiani, S.ST., M. Kes. lahir di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali 7 Pebruari 1988. Anak Ketiga dari tiga bersaudara. Putri ketiga dari pasangan I Wayan Sumantra (Alm) dan Ni Ketut Ngenik. Pendidikan tinggi yang ditempuh penulis yaitu pendidikan D-III Kebidanan di Akademi Kebidanan Kartini Bali yang kini sudah berubah bentuk menjadi Politeknik Kesehatan Kartini Bali. Setelah itu menempuh pendidikan Bidan Pendidik di Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, tahun 2014 menempuh pendidikan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Udayana, dan tahun 2022 menempuh pendidikan Profesi Bidan di Stikes Bina Usada Bali. Saat ini penulis adalah dosen tetap di Politeknik Kesehatan Kartini Bali pada Program Studi D-III Kebidanan yang berfokus pada bidang Neonatus, Bayi dan Balita. Saat ini penulis aktif menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). Penulis juga memiliki usaha dibidang terapi komplementer dalam kebidanan bernama Wirdhan Care di Denpasar, Bali, di mana penulis pun aktif sebagai praktisi terapi komplementer pada ibu hamil, bayi dan ibu nifas. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ayukwidiani070288@gmail.com

PROFIL PENULIS



Bdn.Yanti, S.SiT., M.Keb.

Lahir di Jambi, 07 Mei 1977. Lulus Sekolah Perawat Kesehatan Kesda II/SWJ Cabang Jambi tahun 1996.

Penulis melanjutkan Diploma III Kebidanan Akademi Kebidanan Poltekkes Jambi tahun 2003. Lulus Diploma IV Bidan Pendidik Poltekkes Kemenkes Padang tahun 2006. Dan Lulus Magister Kebidanan Universitas Andalas Padang tahun 2015.

Saat ini penulis sebagai Dosen di Prodi Profesi Kebidanan dan aktif mengajar di Universitas Senior Medan.

Penulis memiliki ketertarikan dibidang Kebidanan dan aktif sebagai peneliti dan menulis artikel jurnal ilmiah bidang Kebidanan.

Email: afriwanyanti@gmail.com

Motto "Teruslah Belajar Tak Perduli Berapa Usiamu, Orang Sukses adalah Orang Yang Selalu Ingin Belajar "



Bd.Sesmi Nanda Oktavia, S.ST, M.Biomed Lahir di Sijunjung, 01 Oktober 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis adalah pendidikan DIV Bidan Pendidik di STIKes Prima Nusantara Bukittinggi. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas Padang dan lulus tahun 2017. Untuk saat ini Penulis sedang melanjutkan Pendidikan S3 di Lincoln University Collage, Malaysia. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 di Akademi Kebidanan Pasaman Barat hingga sampai saat ini. Saat ini Penulis merupakan

Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi , Pembelajaran , Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dan juga Aktif dalam Publikasi Ilmiah, seminar, pelatihan, dan lainnya.

Penulis dapat dihubungi melalui sesminanda@gmail.com

Motto: "Datang, Lihat dan Taklukan..."

Sinopsis

Buku Ajar Psikologi Kehamilan, Persalinan, Nifas menyajikan gambaran utuh tentang perubahan psikologis yang dialami ibu dan bayi sejak masa kehamilan berakhir hingga periode nifas dan menyusui. Disusun untuk mahasiswa, pendidik, dan praktisi kebidanan, buku ini memadukan konsep, bukti ilmiah, dan pendekatan praktis agar pembaca mampu memahami gejala, faktor risiko, serta kebutuhan dukungan pada ibu dan keluarga. Penyajian materi mengikuti alur belajar yang bertahap, dilengkapi latihan, glosarium, dan rujukan yang memadai sehingga mudah diterapkan di kelas maupun lahan praktik.

Bagian awal menempatkan fokus pada masa setelah persalinan. Bab 1 mengulas adaptasi psikologis pada nifas dan menyusui, mulai dari proses adaptasi fisiologis, fase yang dilalui ibu, faktor yang memengaruhi kondisi psikologis, hingga dampaknya pada kesehatan mental, termasuk ragam kelainan dan bentuk dukungan yang relevan. Bab 2 mengalihkan perhatian pada bayi dengan membahas tahap adaptasi, faktor yang memengaruhi perkembangan psikologis, serta tahapan perkembangan pada tahun pertama kehidupan. Bab 3 memperluas sudut pandang melalui pembahasan kesehatan mental perempuan, dampak kehamilan, dan dampak persalinan terhadap status psikologis, sehingga pembaca memahami keterkaitan pengalaman biologis dan konteks sosial dengan kesejahteraan mental.

Bagian selanjutnya menekankan kewaspadaan klinis dan peran profesi. Bab 4 dan Bab 5 membimbing pembaca melakukan deteksi dini gangguan psikologi pada persalinan dan pada masa nifas, mencakup penyebab, masalah yang sering muncul, serta langkah identifikasi praktis. Bab 6 menambah wawasan tentang sibling rivalry dan menegaskan tanggung jawab bidan dalam memberikan dukungan terhadap kesehatan mental perempuan dan dinamika keluarga. Setiap bab ditutup dengan rangkuman materi, latihan, glosarium, dan referensi, kemudian diakhiri dengan profil penulis, sehingga buku ini menjadi rujukan komprehensif untuk meningkatkan kualitas asuhan yang berpusat pada perempuan, bayi, dan keluarga.

Buku Ajar Psikologi Kehamilan, Persalinan, Nifas menyajikan gambaran utuh tentang perubahan psikologis yang dialami ibu dan bayi sejak masa kehamilan berakhir hingga periode nifas dan menyusui. Disusun untuk mahasiswa, pendidik, dan praktisi kebidanan, buku ini memadukan konsep, bukti ilmiah, dan pendekatan praktis agar pembaca mampu memahami gejala, faktor risiko, serta kebutuhan dukungan pada ibu dan keluarga. Penyajian materi mengikuti alur belajar yang bertahap, dilengkapi latihan, glosarium, dan rujukan yang memadai sehingga mudah diterapkan di kelas maupun lahan praktik.

Bagian awal menempatkan fokus pada masa setelah persalinan. Bab 1 mengulas adaptasi psikologis pada nifas dan menyusui, mulai dari proses adaptasi fisiologis, fase yang dilalui ibu, faktor yang memengaruhi kondisi psikologis, hingga dampaknya pada kesehatan mental, termasuk ragam kelainan dan bentuk dukungan yang relevan. Bab 2 mengalihkan perhatian pada bayi dengan membahas tahap adaptasi, faktor yang memengaruhi perkembangan psikologis, serta tahapan perkembangan pada tahun pertama kehidupan. Bab 3 memperluas sudut pandang melalui pembahasan kesehatan mental perempuan, dampak kehamilan, dan dampak persalinan terhadap status psikologis, sehingga pembaca memahami keterkaitan pengalaman biologis dan konteks sosial dengan kesejahteraan mental.

Bagian selanjutnya menekankan kewaspadaan klinis dan peran profesi. Bab 4 dan Bab 5 membimbing pembaca melakukan deteksi dini gangguan psikologi pada persalinan dan pada masa nifas, mencakup penyebab, masalah yang sering muncul, serta langkah identifikasi praktis. Bab 6 menambah wawasan tentang sibling rivalry dan menegaskan tanggung jawab bidan dalam memberikan dukungan terhadap kesehatan mental perempuan dan dinamika keluarga. Setiap bab ditutup dengan rangkuman materi, latihan, glosarium, dan referensi, kemudian diakhiri dengan profil penulis, sehingga buku ini menjadi rujukan komprehensif untuk meningkatkan kualitas asuhan yang berpusat pada perempuan, bayi, dan keluarga.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7426-26-0

